Optimal Untuk Negeri

optimal

Buku Ajar

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DAN PRAKONSEPSI UNTUK BIDAN

Ermaya Sari Bayu Ningsih • Cynthia Puspariny • Feling Polwandari
Sri Handayani • Tria Puspita Sari

Editor:
Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.



BUKU AJAR
BUKU AJAR KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DAN PRAKONSEPSI UNTUK BIDAN

Penulis:
Bdn. Ermaya Sari Bayu Ningsih, SST., M.Kes., M.Keb.
Cynthia Puspariny, S.ST., Bdn., M.Kes.
Bdn. Feling Polwandari., M.Keb.
Dr. Sri Handayani, S.Kep., Ns., M.Kes.
Tria Puspita Sari, SST., M.Kes., M.Keb.

Editor:
Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.

Optimal Untuk Negeri

Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi untuk Bidan

Penulis:
Bdn. Ermaya Sari Bayu Ningsih, SST., M.Kes., M.Keb.
Cynthia Puspariny, S.ST., Bdn., M.Kes.
Bdn. Feling Polwandari., M.Keb.
Dr. Sri Handayani, S.Kep., Ns., M.Kes.
Tria Puspita Sari, SST., M.Kes., M.Keb.

Editor:
Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7756-70-1

Cetakan Pertama: Juli, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Ajar *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi untuk Bidan 2* ini dapat disusun dengan baik. Buku ajar ini hadir sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan dalam memahami isu-isu penting terkait kesehatan reproduksi remaja dan pelayanan prakonsepsi. Materi yang disajikan diharapkan dapat membantu calon bidan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional dalam memberikan edukasi, skrining, konseling, rujukan, dan asuhan kebidanan yang sesuai dengan kebutuhan remaja, calon pengantin, pasangan usia subur, keluarga, sekolah, dan komunitas.

Buku ini membahas berbagai topik penting yang disusun secara sistematis, meliputi infeksi menular seksual dan HIV pada remaja, skrining risiko, edukasi, rujukan, serta simulasi keterampilan. Selain itu, buku ini juga menguraikan kesehatan mental remaja yang berkaitan dengan reproduksi, seperti stres, citra tubuh, dan perilaku berisiko. Pembahasan dilanjutkan dengan materi pelayanan prakonsepsi, komponen paket pelayanan, konseling prakonsepsi, perencanaan kehamilan, KB prahamil, kesiapan keluarga, komunikasi informasi dan edukasi, dokumentasi asuhan, serta tinjauan agama dan budaya dalam pelayanan kebidanan.

Setiap bab dalam buku ini dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran, latihan soal, studi kasus vignette, simulasi atau *skill lab*, rubrik penilaian, OSCE, DOPS, ringkasan, tabel *red flags* dan eskalasi, serta daftar pustaka untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa. Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, bidan, dan seluruh pembaca dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi secara komprehensif, inklusif, dan berkesinambungan.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB 1 INFEKSI MENULAR SEKSUAL DAN HIV PADA REMAJA: SKRINING RISIKO, EDUKASI, DAN RUJUKAN **1**
A. Pendahuluan 3
B. Skrining Risiko IMS & HIV 6
C. Edukasi IMS & HIV 7
D. Rujukan IMS & HIV 9
E. Simulasi/skill lab 10
F. Rubrik Penilaian Dan Kelulusan 56
G. Ringkasan 75
H. Tabel Red Flags & Eskalasi 72
I. Daftar Pustaka 75

BAB 2 KESEHATAN MENTAL REMAJA TERKAIT REPRODUKSI: STRES, CITRA TUBUH, DAN PERILAKU BERISIKO **79**
A. Stres Pada Remaja dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi 80
B. Citra Tubuh *(Body Image)* Pada Remaja 91
C. Perilaku Berisiko Pada Remaja 93
D. Mapping CP Bab → CPMK → CPL 103
E. Latihan Soal 103
F. Simulasi / Skill Lab Asuhan Kebidanan pada Remaja 105
G. Rubrik OSCE Ringkas 107
H. Rubrik Penilaian 109
I. DOPS (*Direct Observation of Procedural Skills*) — DOES 111
J. Ringkasan 114
K. Daftar Pustaka 116

BAB 3 SISTEM TRIAGE DAN MANAJEMEN ALUR PASIEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT **121**
A. Pendahuluan 122
B. Materi Pembelajaran 122
C. Komponen Paket Pelayanan Prakonsepsi 126

D. Aktivitas 1 — Knows How 138
E. Rubrik Penilaian (Untuk Dosen) 139
F. Aktivitas 2 — Shows How..... 139
G. Daftar Pustaka 144

BAB 4 KONSELING PRAKONSEPSI: PERENCANAAN KEHAMILAN, KB PRAHAMIL, DAN KESIAPAN KELUARGA.....147
A. Pendahuluan 149
B. Definisi Konseling Prakonsepsi..... 149
C. Tujuan Konseling Prakonsepsi 150
D. Konsep Dasar Masa Prakonsepsi 150
E. Perubahan Fisiologis pada Masa Prakonsepsi 150
F. Kebutuhan pada Masa Prakonsepsi 151
G. Tanda Normal Masa Prakonsepsi 152
H. Tanda Bahaya Masa Prakonsepsi..... 152
I. Tabel Skrining Prakonsepsi 152
J. Asuhan Kebidanan pada Konseling Prakonsepsi 153
K. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 154
L. Dokumentasi Asuhan Prakonsepsi..... 155
M. Tinjauan Agama dan Budaya 155
N. Studi Kasus Vignette 156
O. Pertanyaan 156
P. Latihan Soal Vignette..... 156
Q. Ringkasan 158
R. Daftar Pustaka 158

BAB 5 PELAYANAN BERBASIS SEKOLAH DAN KOMUNITAS: JEJARING, EDUKASI, DAN PENCATATAN-PELAPORAN.....159
A. Merancang Layanan/Program Berbasis Sekolah dan Komunitas (Jejaring, Peran Pemangku Kepentingan, dan Inklusivitas)..... 164
B. Melaksanakan pencatatan–pelaporan dan monitoring–evaluasi sederhana untuk perbaikan layanan berbasis data: 180
C. Penilaian Bab 5 190
D. Rubrik CPMK-7 194
E. Ringkasan 194
F. Daftar Pustaka 195

PROFIL PENULIS 197

BAB 1

INFEKSI MENULAR SEKSUAL DAN HIV PADA REMAJA: SKRINING RISIKO, EDUKASI, DAN RUJUKAN

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal serta hak kesehatan reproduksi dalam pelayanan remaja dan prakonsepsi.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan konseling ramah remaja yang berpusat pada klien, sensitif budaya, dan menjaga kerahasiaan.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-5
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan, perlindungan, dan rujukan aman dalam isu reproduksi remaja/prakonsepsi (termasuk IMS/HIV dan kekerasan berbasis gender).	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian, analisis masalah, dan perencanaan intervensi promotif–preventif pada isu kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi berbasis evidence.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Merancang dan melaksanakan edukasi kesehatan serta pemberdayaan individu/keluarga/komunitas untuk pencegahan masalah reproduksi dan stunting antar generasi.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Mengelola dokumentasi, pencatatan–pelaporan, jejaring layanan, dan refleksi perbaikan mutu dalam layanan remaja dan prakonsepsi.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep, determinan, serta kerangka etik–legal layanan kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi sebagai dasar pengambilan keputusan.
CPMK-2	Menganalisis pertumbuhan–perkembangan remaja dan faktor biopsikososial yang memengaruhi risiko serta kebutuhan layanan kesehatan reproduksi.
CPMK-3	Menerapkan pemahaman anatomi–fisiologi reproduksi, kesehatan menstruasi, dan edukasi seksualitas komprehensif sesuai tahap usia untuk promosi kesehatan.
CPMK-4	Melaksanakan komunikasi dan konseling ramah remaja/prakonsepsi secara aman (kerahasiaan, informed choice), termasuk edukasi, skrining risiko awal, dan rujukan sesuai alur layanan.
CPMK-5	Merancang intervensi promotif–preventif terkait gizi, anemia/KEK/obesitas, kesehatan mental, dan faktor risiko lain untuk pencegahan masalah reproduksi dan stunting antar generasi.
CPMK-6	Melakukan skrining prakonsepsi dan menyusun rencana intervensi serta tindak lanjut terkait imunisasi, penyakit kronis, penggunaan obat, dan kebiasaan berisiko.
CPMK-7	Mengorganisasi layanan berbasis sekolah/komunitas melalui jejaring, pencatatan–pelaporan, monitoring–evaluasi sederhana, dan pemanfaatan evidence untuk perbaikan layanan.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab 8. Infeksi Menular Seksual dan HIV pada Remaja: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan	8.1 Mengidentifikasi faktor risiko IMS/HIV pada remaja serta prinsip pencegahan dan reduksi risiko.	8.2 Melakukan skrining risiko, edukasi pencegahan, dan rujukan/kolaborasi untuk layanan tes dan tatalaksana sesuai alur.	CPMK-4	CPMK-3; CPMK-7

A. Pendahuluan

Masalah besar yang menjadi isu serius dalam bidang kesehatan masyarakat penyakit menular seksual (PMS) yang terus meningkat dengan insiden infeksi menular seksual terus bertambah di berbagai negara di seluruh dunia. PMS merupakan infeksi yang ditularkan oleh mikroba akibat perilaku seksual yang tidak aman. Selain itu, PMS juga mencakup penyakit sifilis dan infeksi yang disebabkan oleh *Virus Human Immunodeficiency* (HIV). Kemungkinan terjadinya infeksi menular seksual lebih tinggi jika seseorang terlibat dalam hubungan seksual dengan banyak pasangan, baik melalui vagina, maupun seks oral dan anal. Beberapa jenis infeksi PMS termasuk infeksi HIV, yang menjadi penyebab berkembangnya penyakit *Acquired Immune Deficiency Syndrome/* AIDS (Nela *et al.*, 2023). HIV termasuk golongan retrovirus yang dapat menyerang sistem kekebalan, dan mampu merangsang pembentukan antibodi sehingga dalam tubuh penderita HIV selain ada antigen yang merupakan bagian virus juga terbentuk antibodi terhadap virus HIV tersebut. Virus HIV dapat ditemukan pada sampel cairan tubuh terutama pada darah, cairan sperma, cairan vagina dan air susu ibu. Penularan virus ini dapat terjadi melalui hubungan seksual secara genital, anogenital maupun orogenital dengan seseorang yang terinfeksi Virus HIV, dapat terjadi melalui interaksi langsung dengan darah atau produk darah melalui penggunaan jarum suntik, serta secara vertikal yaitu dari ibu yang terinfeksi virus HIV kepada bayinya yang dapat ditularkan baik selama masa kehamilan, saat proses persalinan, atau saat menyusui (Aguirrebengoa *et al.*, 2023).

Infeksi menular seksual (IMS) dapat menular pada semua kalangan usia melalui cairan tubuh penderita, transfusi darah, penggunaan jarum suntik berulang, dari ibu ke janin melalui plasenta dan proses menyusui. Remaja merupakan kelompok usia yang rentan berpotensi tinggi terhadap risiko penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS karena faktor perilaku dan emosional, seperti hubungan seksual pranikah, penggunaan narkoba suntik, dan berganti-ganti pasangan seksual. Menurut Adriansyah (2022) dalam (Mariani, Devi and Abdullah, 2023) Data terbaru dari Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa sekitar 51% kasus HIV baru diderita oleh remaja dan kasus HIV di Indonesia mulai didominasi oleh usia muda, maka pencegahan dengan melakukan skrining penting dilakukan. Skrining risiko merupakan upaya untuk mendeteksi penyakit yang belum menunjukkan gejala klinis dengan memanfaatkan pemeriksaan tertentu atau prosedur lain yang dapat secara efektif membedakan antara individu yang tampak sehat tetapi mungkin memiliki penyakit, dan mereka yang benar-benar

sehat (Nationwide Childrens, 2025). Pada umumnya, skrining tidak bertujuan untuk memberikan diagnosis, sehingga jika hasil uji menunjukkan positif, diperlukan pemeriksaan lanjutan yang lebih mendalam untuk memastikan apakah individu tersebut benar-benar menderita penyakit atau tidak. Bagi mereka yang terdiagnosis positif, penanganan intensif diperlukan agar tidak menimbulkan risiko bagi diri mereka sendiri maupun lingkungan sekitar, terutama dalam hal infeksi menular seksual (Sugianto *et al.*, 2025).

Menurut WHO (2025) skrining merupakan langkah untuk mendeteksi penyakit yang belum menunjukkan gejala klinis dengan menggunakan metode tertentu atau prosedur lain yang dapat secara efektif membedakan individu yang tampak sehat namun mungkin mengidap penyakit, serta mereka yang benar-benar dalam keadaan sehat. Skrining umumnya tidak bertujuan untuk memberikan diagnosis, sehingga apabila terdapat hasil positif dari uji tersebut, diperlukan pemeriksaan lebih mendalam untuk menentukan apakah individu tersebut benar-benar mengalami sakit atau tidak. Bagi mereka yang mendapat diagnosis positif, perlu dilakukan perawatan intensif untuk menghindari risiko bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain, terutama terkait dengan infeksi menular seksual (Sugianto *et al.*, 2025).

Skrining risiko dilakukan untuk mendeteksi seseorang tanpa gejala dengan risiko terinfeksi HIV secara keseluruhan untuk mencegah transmisi lebih lanjut dan mendeteksi sejak dini diagnosa pasti guna mencegah komplikasi dengan meningkatkan kualitas hidup pasien. Metode diagnosis untuk infeksi HIV didasarkan pada analisis antibodi HIV melalui sampel darah, serum, atau plasma dari individu yang terinfeksi (Rini, 2025). Klasifikasi diagnosis dapat dibagi menjadi tiga jenis: viral load HIV dengan menggunakan *Enzim linked immunoassay* (ELISA), imunokromatografi (*Rapid test*), Western blotting, serta pengukuran viral load HIV. Metode tes *immunoassay* yang memanfaatkan imunokromatografi merupakan metode skrining yang efisien dan praktis. Prinsip pengujian ini melibatkan prosedur kualitatif yang menilai perubahan warna (aliran lateral) pada strip pengujian. Individu yang terinfeksi HIV menciptakan antibodi untuk melawan virus tersebut. Prosedur pengujian ini sangat mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan peralatan yang rumit (Nela *et al.*, 2023). Strategi skrining untuk menyaring remaja putri dan wanita muda yang tidak menunjukkan gejala IMS. Manfaat skrining dapat mencakup pengurangan penularan IMS, yang dapat mengurangi kejadiannya, tetapi tidak ada bukti yang melaporkan hasil ini. Mengenai kerugian, stigma dan konsekuensinya dapat timbul dari skrining, dan masih ada ketidakpastian tentang apakah konsumsi antibiotik mungkin sedikit meningkat dengan skrining atau apa

konsekuensi jangka panjang dari infeksi tanpa gejala (World Health Organization, 2025).



Gambar 1.1: Dokter medis dengan tabung reaksi HIV sedang meneliti AIDS, Pita Merah untuk meningkatkan kesadaran akan epidemi AIDS ilustrasi stok

Sumber: https://www.istockphoto.com/id/vektor/konsep-ilustrasi-hari-aids-sedunia-template-vektor-vektor-datar-dokter-medis-dengan-gm1896241528-554112844?searchscope=image%2Cfilm (Whiskerz, 2024).

Perilaku seksual berisiko dapat meningkatkan insiden Infeksi Menular Seksual/HIV seperti pengguna NAPZA (jarum suntik), berganti-ganti pasangan seksual karena semakin banyak jumlah pasangan seksnya semakin besar kesempatan terinfeksi penyakit IMS dan menularkan ke orang lain. Maka edukasi penting diberikan sebagai sumber informasi yang relevan tentang infeksi menular seksual dan HIV (Agung *et al.*, 2024). Pencegahan penularan HIV menurut WHO dikenal dengan istilah konsep ABCDE yaitu: A (Abstince): tidak melakukan seks diluar nikah, B (Be Faithful): bersikap saling setia kepada satu pasangan sek, C (Condom): menggunakan kondom saat berhubungan seks, D (Drug No): dilarang memakai narkoba, E (Education): memberikan edukasi dan informasi yang benar tentang HIV, cara pencegahan, penularan dan pengobatan (World Health Organization, 2024). Salah satu penanganan yang dapat dilakukan kepada sekolah-sekolah menengah atas yaitu dengan dilakukannya edukasi kesehatan terkait penyakit HIV AIDS (Manumara *et al.*, 2025).

Edukasi seksual pada anak remaja sangat penting untuk menjaga remaja dari kehamilan yang tidak diinginkan serta pencegahan penularan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, sehingga informasi tentang p**encegahan dapat dilakukan dengan** menggunakan **kondom saat berhubungan seks, menghindari berbagi jarum suntik,** melakukan **tes HIV dan infeksi menular seksual lainnya, serta menggunakan obat pencegahan sebelum paparan (PrEP) atau sesudah paparan (PEP) sesuai anjuran dokter. Pengobatan belum ada obat penyembuh HIV, namun terapi antiretroviral (ART) dapat**

menghambat replikasi virus, memperkuat sistem kekebalan, dan mencegah penularan kepada pasangan seksual jika virus dalam darah tidak terdeteksi (*undetectable viral load*). Pengobatan ini perlu dijalankan seumur hidup (Menkes RI, 2022).

Rujukan menular seksual (IMS) dan HIV pada remaja adalah proses pemindahan kasus remaja yang terdiagnosis atau dicurigai menderita IMS atau HIV dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (seperti puskesmas atau klinik umum) ke fasilitas yang lebih spesialis atau memiliki sumber daya lebih lengkap seperti rumah sakit atau pusat pelayanan HIV/IMS (Melo *et al.*, 2022). Rujukan dilakukan bertujuan untuk mendapatkan diagnosis yang lebih akurat: Terutama pada kasus dengan gejala tidak jelas atau hasil tes yang tidak pasti, sehingga pengobatan yang yang diberikan sesuai dan khususnya pada kasus yang kompleks, seperti HIV yang sudah berkembang menjadi AIDS atau IMS dengan komplikasi (misalnya gonore yang menyebabkan radang panggul). Dukungan dan perawatan berkelanjutan, seperti konseling psikologis, dukungan sosial, dan pemantauan kesehatan jangka panjang (Gamelia *et al.*, 2023).

B. Skrining Risiko IMS & HIV

1. Kasus

Seorang Perempuan berusia 16 tahun, datang ke klinik kesehatan remaja untuk berkonsultasi tentang kesehatan seksual di Puskesmas X. Hasil anamnesis: Ia mengaku telah aktif secara seksual selama 1 tahun dengan 3 pasangan yang berbeda dan jarang menggunakan kondom. Saat ini, ia tidak merasakan gejala apa pun, akan tetapi khawatir karena salah satu pasangannya baru saja didiagnosis menderita IMS.

2. Pertanyaan Diskusi:

a. Apakah kasus diatas tergolong kelompok yang disarankan untuk melakukan skrining IMS dan HIV?
b. Jelaskan skrining IMS dan HIV mengapa penting untuk dilakukan?
c. Apakah jenis tes yang sesuai dan seharusnya disarankan untuk kasus diatas?
d. Berapa frekuensi skrining yang harus dilakukan pada kasus diatas?
e. Jelaskan masa jendela deteksi tes pada kasus diatas?

3. Jawaban:

a. Kasus diatas benar merupakan golong kelompok yang disarankan untuk melakukan skrining IMS dan HIV, karena:
   1) Pasien aktif secara seksual dan memiliki banyak pasangan seksual
   2) Usia pasien di bawah 25 tahun
   3) Saat berhubungan seksual tidak menggunakan pelindung (kondom)

4) Terdeteksi pasangan seksualnya terdiagnosa IMS

b. Skrining pada penyakit menular seksual penting untuk dilakukan pada kasus diatas karen hasil anamnesis menunjukkan faktor risiko tinggi terhadap penularan IMS dan HIV. Selain itu, banyak IMS tidak menunjukkan gejala tetapi tetap menular, sehingga skrining sangat penting meskipun tidak ada keluhan.
c. Jenis tes yang disarankan untuk dilakukan adalah klamidia, gonore, sifilis, dan HIV.
d. Frekuensi skrining tes klamidia, gonore, sifilis, dan HIV pada kasus diatas dapat dinilai bahwa remaja diatas aktif seksual di bawah 25 tahun, skrining rutin untuk klamidia dan gonore sebaiknya dilakukan setahun sekali. Jika terdapat faktor risiko tambahan seperti kasus diatas, maka tes dapat dilakukan lebih sering atau mencakup jenis IMS lainnya. Tes HIV disarankan setidaknya sekali, dan jika risiko tetap ada, dilakukan kembali setiap tahun atau setelah paparan baru.
e. Perlu dijelaskan bahwa setiap tes memiliki masa jendela, yaitu waktu setelah paparan hingga tes dapat mendeteksi infeksi dengan akurat. Misalnya, klamidia dan gonore dapat terdeteksi sekitar 2 minggu setelah paparan, sifilis sekitar 4-6 minggu, dan tes HIV generasi ke-4 akurat setelah 4-6 minggu. Jika tes dilakukan sebelum masa jendela berakhir, hasilnya mungkin negatif meskipun sebenarnya terinfeksi, sehingga perlu diulang kembali nanti.

C. Edukasi IMS & HIV

1. Kasus

Minggu ini diadakan diskusi dikelas mengenai kesehatan reproduksi remaja dengan topik bahaya infeksi menular seksual dan HIV, saat kegiatan diskusi seorang siswa berusia 16 tahun menyatakan orang hanya bisa terinfeksi jika berhubungan seksual dengan banyak orang; IMS pasti terlihat dari penampilan orang tersebut; dan HIV bisa disembuhkan dengan obat herbal. Dia berpendapat bahwa berhubungan seksual tanpa pengaman bila dia dan pasangannya sehat, bersih maka aman dari bahaya IMS dan HIV, sehingga tidak perlu khawatir serta tidak perlu melakukan pemeriksaan tes tersebut.

2. Pertanyaan Diskusi:

a. Lakukan identifikasi terkait mitos atau informasi yang salah terhadap kasus diatas?
b. Jelaskan informasi yang tepat sebagai fakta yang sebenarnya?
c. Jelaskan bagaimana cara penyampaian informasi yang tepat agar siswa tidak merasa dihakimi?

d. Apakah pesan kunci yang harus disampaikan kepada siswa bahwa pentingnya tindakan pencegahan dan skrining?

3. Jawaban:

a. Adapun mitos-mitos ataupun informasi yang salah sehingga harus dikoreksi antara lain:
   1) Mitos tentang penularan IMS dan HIV hanya terjadi pada seseorang yang memiliki banyak pasangan seks.
   2) Mitos bahwa infeksi menular seksual bisa dilihat dari penampilan fisik seperti terlihat sehat, terlihat bugar.
   3) Mitos bahwa virus HIV dapat disembuhkan dengan obat herbal.

b. Maka informasi yang harus diperbaiki dari paradigma yang salah dan pentingnya edukasi diberikan kepada remaja antara lain:
   1) Mitos: Hanya orang dengan banyak pasangan yang bisa terinfeksi. Fakta: Cukup satu kali hubungan seksual tanpa perlindungan dengan orang yang terinfeksi (meskipun hanya memiliki satu pasangan) sudah bisa menyebabkan penularan.
   2) Mitos: IMS bisa dilihat dari penampilan. Fakta: Banyak IMS dan infeksi HIV pada tahap awal tidak menunjukkan gejala apa pun, tetapi tetap bisa menular. Penampilan fisik tidak bisa dijadikan patokan.
   3) Mitos: HIV bisa disembuhkan dengan obat herbal. Fakta: Sampai saat ini, belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV, namun pengobatan medis (antiretroviral) dapat menekan virus sehingga penderita bisa hidup sehat dan mencegah penularan. Obat herbal belum terbukti secara ilmiah dapat menyembuhkan atau mengontrol virus.

c. Penyampaian pesan edukasi sebagai informasi yang benar dan tepat bagi remaja harus dilakukan dengan pendekatan yang tidak menghakimi, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan sesuai usia remaja. Mulailah dengan mendengarkan apa yang ia ketahui dan rasakan, kemudian koreksi informasi salah secara bertahap dengan data fakta. Gunakan pendekatan yang berfokus pada kesehatannya sendiri, bukan pada penilaian moral terhadap perilakunya. Bisa juga menggunakan media visual atau cerita kasus yang relevan agar lebih mudah dipahami.

d. Pesan kunci yang penting untuk disampaikan kepada remaja antara lain:
   1) Risiko penularan bisa terjadi pada siapa saja yang melakukan hubungan seksual tanpa perlindungan, tidak peduli berapa banyak pasangannya.

2) Tidak adanya gejala tidak berarti tidak terinfeksi, sehingga skrining adalah satu-satunya cara untuk memastikan kondisi kesehatan.
3) Pengobatan medis adalah cara yang aman dan terbukti efektif untuk menangani IMS dan mengontrol HIV.
4) Pencegahan seperti penggunaan kondom yang benar dan konsisten sangat efektif mengurangi risiko.

D. Rujukan IMS & HIV

1. Kasus

Seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun, datang ke Puskesmas dengan keluhan nyeri saat buang air kecil, keluar cairan berwarna kekuningan dari alat kelamin, dan nyeri perut bagian bawah yang semakin parah selama 3 hari. Hasil anamnesis: pasien mengaku pernah berhubungan seksual tanpa kondom dengan beberapa pasangan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan kemungkinan infeksi gonore dan klamidia, serta diduga telah menyebar menyebabkan penyakit radang panggul. Petugas juga menyarankan untuk dilakukan tes HIV, namun Puskesmas hanya memiliki alat tes cepat sederhana dan belum memiliki fasilitas untuk menangani komplikasi yang lebih berat atau pengobatan jangka panjang.

2. Pertanyaan Diskusi:

a. Jelaskan alasan utama mengapa perlu dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut pada kasus diatas?
b. Jelaskan tujuan rujukan ke fasilitas kesehatan dan spesialis kesehatan yang tepat pada kasus diatas?
c. Jelaskan informasi apa saja yang harus disiapkan atau dicantumkan dalam surat rujukan agar pelayanan berjalan lancar?
d. Jelaskan bagaimana cara pendekatan rujukan pada kasus diatas tidak merasa takut atau merasa kasusnya sangat parah?

3. Jawaban:

a. Alasan utama dilakukan rujukan adalah adanya dugaan komplikasi (penyakit radang panggul) yang membutuhkan penanganan lebih mendalam, mungkin termasuk pengobatan infus atau pemantauan lebih ketat yang tidak tersedia di Puskesmas. Selain itu, meskipun tes HIV dapat dilakukan di tingkat pertama, jika hasilnya positif atau diperlukan pemeriksaan lanjutan, maka pasien membutuhkan layanan pengobatan dan pemantauan yang terintegrasi, layanan ini biasanya tersedia di rumah sakit atau klinik terpadu.
b. Pasien pada kasus diata sebaiknya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas kesehatan tingkat II/III yang memiliki layanan kesehatan remaja

dan spesialis kandungan atau penyakit dalam. Juga disarankan ke tempat yang memiliki program layanan IMS/HIV terpadu agar dapat menangani semua masalah kesehatan dalam satu tempat.

c. Surat rujukan harus memuat: data identitas pasien, riwayat keluhan dan pemeriksaan fisik, hasil tes yang sudah dilakukan, dugaan diagnosis, alasan rujukan, serta catatan tentang perlunya menjaga kerahasiaan data karena pasien masih remaja. Juga perlu menyertakan informasi kontak petugas yang merujuk jika diperlukan diskusi lebih lanjut.
d. Lakukan penjelasan dengan bahasa sederhana bahwa rujukan bukan berarti kondisinya tidak bisa disembuhkan, melainkan agar ia bisa mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang lebih lengkap dan tepat. Tegaskan bahwa semua data dan prosesnya akan dijaga kerahasiaannya, dan petugas di tempat tujuan juga terlatih menangani kasus seperti miliknya dengan sikap yang mendukung.

E. Simulasi/skill lab

1. Simulasi Skrining Risiko IMS dan HIV

a. Tujuan Simulasi Skrining Risiko IMS dan HIV
   1) **Tindakan**: Mampu melakukan penilaian risiko secara lengkap dan sistematis, serta menentukan jenis skrining yang tepat sesuai kondisi remaja.
   2) **Komunikasi**: Terampil berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti, tidak menghakimi, dan mampu membangun kepercayaan.
   3) **Keselamatan**: Memastikan kepatuhan terhadap prosedur keamanan biologis, perlindungan data pribadi, dan penerapan aturan hukum terkait persetujuan dan kerahasiaan.

b. Persiapan Simulasi Skrining Risiko IMS dan HIV

Tabel 1.2: Persiapan Simulasi Skrining Risiko IMS dan HIV

Katagori	Keterangan
Peralatan & Bahan	- Kuesioner skrining risiko yang disederhanakan dan ramah remaja. - Alat tes cepat simulasi, sampel darah/urin tiruan, APD lengkap (sarung tangan, masker, pelindung wajah jika perlu). - Wadah limbah medis simulasi, alat desinfeksi. - Formulir persetujuan tindakan medis, lembar catatan medis rahasia.

- Daftar pertanyaan panduan wawancara.

Lingkungan — Ruang tertutup atau dipartisi agar pribadi. Pengaturan kursi menyamping (tidak berhadapan langsung secara kaku) untuk mengurangi ketegangan. Tersedia tempat khusus untuk prosedur teknis yang bersih dan teratur.



Sumber: https://id.pngtree.com/freepng/friendly-counseling-cartoon-in-quiet-room_21998188.html (Whiskerz, 2024).

Peran
- Tenaga Kesehatan: Melakukan wawancara, penilaian, dan prosedur tes.
- Remaja: Memiliki karakter berbeda (misal: remaja yang tertutup, remaja yang berisiko tinggi tapi tidak sadar, remaja yang takut orang tua tahu).
- Pengamat/Penilai: Fokus menilai ketiga aspek (tindakan, komunikasi, keselamatan) menggunakan daftar periksa.

Aturan Dasar
- Remaja ≥14 tahun berhak memberikan persetujuan sendiri untuk layanan kesehatan reproduksi.
- Seluruh informasi bersifat rahasia, tidak disebarkan tanpa izin kecuali ada risiko bahaya.
- Prosedur keselamatan harus sama persis seperti menangani pasien sungguhan

c. Tahapan Simulasi Skrining Risiko IMS dan HIV

Tabel 1.3: Tahapan Simulasi Skrining Risiko IMS dan HIV

Tahapan	Kegiatan Utama	Fokus Penilaian	Detail Pelaksanaan
1. Pembukaan & Pembangunan Kepercayaan	Sapaan dan penetapan aturan dasar	**Komunikasi & Keselamatan**	- Tindakan: Memperkenalkan

				diri, menjelaskan tujuan kunjungan. - Komunikasi: Menggunakan sapaan santai ("Halo", "Apa kabar?"), nada bicara lembut, kontak mata yang wajar. Menjelaskan konsep kerahasiaan dengan bahasa sederhana: "Apa yang kita bicarakan di sini, tetap di sini, kecuali kalau kamu dalam bahaya." - Keselamatan: Menegaskan batasan privasi dan aturan hukum yang melindungi data remaja.
2.	Penilaian Risiko	Wawancara Mendalam	**Komunikasi & Keselamatan**	- Tindakan: Menggunakan pendekatan terstruktur (misal metode 5P yang dimodifikasi) agar tidak ada poin yang terlewat: Pasangan, Praktik, Perlindungan, Riwayat sebelumnya, dan Kehamilan (jika relevan). Juga tanyakan

			penggunaan obat suntik atau transfusi. - Komunikasi: Bertanya secara bertahap dari yang umum ke yang sensitif. Gunakan kalimat yang tidak menuduh, misal: "Banyak orang kadang lupa atau tidak sempat pakai pelindung, bagaimana dengan kamu?" Hindari kata-kata yang menyalahkan seperti "Kenapa kamu melakukan itu?". - Keselamatan: Memastikan pertanyaan tidak menimbulkan trauma atau tekanan psikologis. Hentikan atau ubah cara bertanya jika remaja tampak sangat tertekan.
3. Konseling Sebelum Tes & Persetujuan	Penjelasan Prosedur dan Pengambilan Keputusan	**Semua Aspek**	- Tindakan: Menjelaskan jenis tes yang disarankan dan alasannya berdasarkan hasil penilaian risiko. Menjelaskan cara pengambilan sampel dan waktu tunggu hasil.

				- Komunikasi: Menjelaskan istilah medis dengan bahasa sederhana. Menjawab keraguan atau ketakutan (misal: takut sakit saat diambil darah). Memastikan remaja mengerti sebelum meminta tanda tangan. - Keselamatan: Menjelaskan hak remaja untuk menerima atau menolak. Menjelaskan aturan persetujuan (apakah butuh orang tua atau tidak) sesuai hukum yang berlaku. Menjamin data tidak akan dicantumkan di tempat yang bisa dilihat orang lain.
4.	Prosedur Pemeriksaan	Pelaksanaan Teknis tes	**Tindakan & Keselamatan**	- Tindakan: Melakukan langkah kerja sesuai SOP: persiapan alat, pembersihan area pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel tiruan, pemberian label pada sampel, dan pengoperasian alat tes.

			- Komunikasi: Tetap berbicara dengan remaja selama prosedur untuk mengurangi kecemasan: "Sekarang saya akan menyentuh tanganmu ya," atau "Ini hanya sedikit terasa seperti digigit semut." - Keselamatan: Memakai APD lengkap. Menangani sampel dan alat bekas pakai seolah-olah berbahaya (memasukkan ke wadah limbah medis yang tepat). Melakukan desinfeksi permukaan kerja setelah selesai. Menerapkan prinsip keselamatan untuk mencegah penularan silang.
5. Penyampaian Hasil	Interprestasi dan Tindak Lanjut	**Semua Aspek**	- Tindakan: Membaca hasil sesuai panduan alat, menentukan apakah perlu tes ulang atau rujukan. - Komunikasi: Menyampaikan hasil dengan empati. Jika positif: "Hasilnya menunjukkan ada

			infeksi, tapi kabar baiknya ini bisa diobati/dikendalikan." Jika negatif: tetap berikan edukasi pencegahan dan jelaskan masa jendela. - Keselamatan: Menyampaikan hasil di ruang pribadi, tidak berteriak atau menyebutkan diagnosis di tempat umum. Menjelaskan risiko jika tidak diobati, namun tidak menakut-nakuti secara berlebihan.
6. Pencatatan dan penutup	Dokumentasi dan rencana lanjutan	**Tindakan & Keselamatan**	- Tindakan: Mencatat hasil pemeriksaan dan rencana tindak lanjut secara lengkap. - Komunikasi: Merangkum poin penting, memberikan informasi tempat layanan lanjutan, dan memastikan remaja tidak memiliki pertanyaan lagi. - Keselamatan: Menyimpan catatan medis di lemari terkunci atau sistem terproteksi. tidak menuliskan diagnosis secara gamblang di tempat yang mudah

terbaca orang luar Jika tidak perlu.

d. Contoh Skenario Simulasi Skrining Risiko IMS dan HIV

Skenario: Remaja dengan resiko tersembunyi

1) **Situasi**: Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun datang ke puskesmas dengan alasan "cek kesehatan umum". Pada awalnya dia berkata tidak berhubungan seksual karena takut dimarahi. Namun, dia mengeluh sering sakit perut bagian bawah dan keluar cairan tidak wajar. Tenaga kesehatan menyadari gejala tersebut dan perlu menggali informasi lebih lanjut dengan hati-hati.
2) **Fokus Latihan**:
   a) **Komunikasi**: Bagaimana cara mengubah pertanyaan agar remaja mau berterus terang tanpa merasa diinterogasi. Contoh: "Saya melihat ada gejala yang sering muncul kalau ada infeksi, dan itu bisa terjadi meskipun kamu pikir tidak ada risiko. Boleh saya tanya lagi lebih detail supaya saya bisa bantu berikan obat yang tepat?"
   b) **Tindakan**: Menyesuaikan daftar pertanyaan dan menyarankan paket tes yang lengkap (bukan hanya satu jenis) sesuai gejala.
   c) **Keselamatan**: Menjamin kerahasiaan berulang kali, menjelaskan bahwa tujuannya adalah pengobatan bukan menghakimi, serta melakukan prosedur pengambilan sampel dengan aman dan sopan.

e. Daftar Periksa Evaluasi Kinerja Simulasi Skrining Risiko IMS dan HIV

Aspek	Kriteria Penilaian	Ya/Tidak/Perlu Perbaikan
Tindakan	1. Melakukan penilaian risiko secara lengkap (tidak ada poin terlewat). 2. Menentukan jenis tes yang sesuai dengan risiko dan gejala. 3. Melakukan prosedur teknis sesuai urutan SOP yang benar. 4. Menentukan tindak lanjut atau rujukan yang tepat.	
Komunikasi	1. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak menggunakan istilah rumit tanpa penjelasan. 2. Sikap tidak menghakimi (nada bicara, ekspresi wajah, kalimat yang digunakan).	

	3. Mampu mengajukan pertanyaan sensitif dengan cara yang halus. 4. Mampu menenangkan kecemasan dan menjelaskan informasi rumit dengan sederhana.
Keselamatan	1. Selalu memakai APD yang sesuai saat prosedur teknis. 2. Menangani sampel dan limbah sesuai aturan keselamatan biologis. 3. Menjelaskan dan menjamin kerahasiaan serta aturan persetujuan dengan benar. 4. Menyimpan dan mencatat data dengan cara yang melindungi privasi pasien.

2. Simulasi Edukasi IMS dan HIV

a. Tujuan Simulasi Edukasi IMS dan HIV

1) **Tindakan**: Mampu merencanakan dan menyampaikan materi edukasi yang akurat, terstruktur, dan sesuai kebutuhan remaja, serta melakukan demonstrasi teknis pencegahan dengan benar.
2) **Komunikasi**: Terampil menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak menghakimi, dan mampu mengubah mitos atau pandangan yang salah tanpa merendahkan remaja.
3) **Keselamatan**: Menjamin keamanan psikologis (suasana aman, privasi terjaga), kepatuhan hukum, serta kebersihan dan etika dalam demonstrasi alat peraga.

b. Persiapan Simulasi Edukasi IMS dan HIV

Katagori	Keterangan
Peralatan & Bahan	- Materi edukasi: Poster, infografis, brosur ramah remaja, kartu pertanyaan/mitos-fakta.





- Alat peraga: Model alat reproduksi (opsional), model penis tiruan untuk demonstrasi pemakaian kondom, kondom contoh (tidak untuk pemakaian sungguhan), cairan pelumas tiruan.
- Dokumen: Aturan hukum layanan kesehatan remaja, daftar alamat layanan ramah remaja.
- Kebersihan: Tisu, cairan desinfeksi, sarung tangan (untuk demonstrasi).

Lingkungan — Ruang yang fleksibel, bisa diatur menjadi lingkaran diskusi atau ruang konseling pribadi. Pastikan tidak ada orang luar yang bisa mendengar atau melihat. Hindari pengaturan seperti ruang kelas formal yang kaku.

Peran

- Fasilitator Kesehatan/Pendidik: Menyampaikan edukasi.
- Remaja: Beragam karakter (remaja yang penakut, remaja yang sinis, remaja yang percaya mitos, remaja yang memiliki risiko tapi tidak sadar).

- Pengamat/Penilai: Menilai kinerja berdasarkan daftar periksa yang berfokus pada ketiga aspek di atas.

Aturan Dasar
- Hak remaja atas informasi dan kerahasiaan.
- Tidak ada pertanyaan yang salah atau memalukan.
- Demonstrasi Alat peraga hanya dilakukan pada Model tiruan, bukan pada tubuh manusia.
- Isi informasi harus sesuai pedoman kesehatan nasional.

c. Tahapan Simulasi Edukasi IMS dan HIV

Tahapan	Kegiatan Utama	Fokus Penilaian	Detail Pelaksanaan
1. Pembukaan & Penetapan Aturan	Membangun suasana aman dan tujuan pertemuan	**Komunikasi & Keselamatan**	- Tindakan: Memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, dan menyusun aturan main bersama (misal: saling menghormati, tidak menyebarkan cerita orang lain). - Komunikasi: Sapaan santai, nada bicara setara, tidak menggurui. Contoh: "Saya di sini bukan untuk marahi atau ajari kamu, tapi untuk berbagi info yang mungkin berguna." - Keselamatan: Menjelaskan batasan privasi dan hukum yang berlaku. Memastikan remaja merasa aman untuk bertanya apa pun

				tanpa takut dihakimi atau dilaporkan ke orang tua (kecuali ada risiko bahaya).
2.	Penilaian Pengetahuan Awal	Menggali apa yang sudah diketahui dan mitos yang dipercaya	**Tindakan & Komunikasi**	- Tindakan: Menggunakan metode interaktif seperti permainan "Benar atau Salah" atau diskusi kelompok untuk memetakan pemahaman remaja. - Komunikasi: Bertanya secara terbuka. Saat menemukan kesalahpahaman, jangan langsung berkata "Kamu salah", tapi gunakan kalimat seperti "Banyak orang memang berpikir begitu, tapi berdasarkan data kesehatan, faktanya adalah..." - Keselamatan: Tidak memaksa remaja berbicara di depan umum jika dia malu; sediakan opsi menulis pertanyaan secara anonim. Menghindari pembahasan yang bisa memicu trauma.

3.	Penyampaian Materi Edukasi	Menjelaskan cara penularan, pencegahan, dan pengobatan	**Semua Aspek**	- Tindakan: Menyampaikan informasi akurat: membedakan HIV dan IMS lain, cara penularan dan yang bukan cara penularan, gejala, risiko komplikasi, serta fakta pengobatan (HIV bisa dikendalikan, IMS bisa disembuhkan). Urutkan dari hal umum ke hal spesifik. - Komunikasi: Gunakan bahasa sehari-hari, hindari istilah medis rumit atau jelaskan artinya. Gunakan analogi sederhana. Sesuaikan kedalaman materi dengan usia dan tingkat pemahaman. Fokus pada solusi dan pencegahan, bukan pada ketakutan. - Keselamatan: Jangan memberikan detail eksplisit tentang aktivitas seksual yang tidak perlu. Jangan menyalahkan perilaku, tapi tekankan bahwa "keputusan yang aman" adalah kunci.

				Pastikan informasi tidak menyesatkan.
4.	Demonstrasi Teknik Pencegahan	Menunjukkan cara pemakaian kkondom dan alat pelindung	**Tindakan & Keselamatan**	- Tindakan: Melakukan demonstrasi langkah demi langkah pada model tiruan: cara membuka, arah pemakaian, membuang udara di ujung, pemakaian pelumas yang tepat, dan cara membuang setelah pakai. Jelaskan juga batasan kemampuan kondom (tidak 100% aman tapi sangat mengurangi risiko). - Komunikasi: Jelaskan setiap langkah dengan jelas dan tenang. Jawab pertanyaan seperti "Di mana bisa beli?" atau "Kalau malu beli bagaimana?". - Keselamatan: Wajib menggunakan model tiruan, dilarang melakukan demonstrasi pada tubuh sendiri atau orang lain. Gunakan sarung tangan saat memegang alat peraga. Bersihkan alat peraga dengan desinfeksi setelah

				digunakan. Jangan membagikan kondom bekas atau yang sudah kedaluwarsa sebagai contoh.
5.	Latihan Menjawab Pertanyaan Sulit	Menangani pertanyaan sensitive atau kontroversi	**Semua Aspek**	- Tindakan: Menjawab berdasarkan fakta ilmiah dan pedoman layanan kesehatan. Jika tidak tahu, akui dan katakan akan mencari informasi yang akurat. - Komunikasi: Tetap tenang, tidak terkejut atau memerah wajah saat mendengar pertanyaan berani. Contoh pertanyaan dan jawaban: Tanya: "Kalau cuma sekali berhubungan, pasti nggak akan tertular kan?" Jawab: "Risikonya memang lebih kecil dibanding sering, tapi penularan bisa terjadi bahkan hanya satu kali, jadi tetap harus waspada dan pakai pelindung." - Keselamatan: Menghindari jawaban yang bisa disalahartikan sebagai izin atau ajakan melakukan hubungan seksual. Fokus

				jawaban selalu kembali ke aspek kesehatan dan keamanan.
6.	Penutup & Tindak Lanjut	Merangkum dan memberikan akses layanan	**Tindakan & Keselamatan**	- Tindakan: Merangkum poin utama, membagikan materi tulisan, dan memberikan daftar tempat layanan kesehatan ramah remaja beserta jam pelayanan dan cara aksesnya. - Komunikasi: Menutup dengan kalimat yang memberdayakan: "Kamu punya hak untuk menjaga kesehatanmu sendiri, dan ada tempat yang siap membantu kalau kamu butuh." - Keselamatan: Memastikan materi yang dibagikan tidak memuat informasi sensitif yang bisa menyebabkan masalah jika ditemukan orang lain. Tidak memaksa remaja memberikan data kontak pribadi jika tidak mau.

d. Contoh Skenario Simulasi Edukasi IMS dan HIV

Skenario: Menghadapi Mitos dan Sikap Penolakan

1) **Situasi**: Pada sesi edukasi kelompok, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun berkata dengan keras: "Ah, itu penyakit cuma buat orang nakal saja. Saya dan pacar saya bersih, jadi nggak butuh tahu itu semua." Remaja lain ikut setuju dan menjadi tidak tertarik mendengarkan.
2) **Fokus Latihan**:
   d) **Komunikasi**: Bagaimana fasilitator merespons tanpa berkonflik. Contoh jawaban: "Saya mengerti kenapa kamu berpikir begitu, banyak orang juga berpikir begitu. Tapi faktanya, virus atau bakteri tidak melihat orang itu baik atau nakal, dia hanya mencari tempat untuk tinggal. Kalau pasangan kamu pernah berhubungan sebelumnya atau mungkin tertular lewat cara lain tanpa sadar, risiko tetap ada. Info ini saya sampaikan supaya kamu punya alat perlindungan, bukan karena menilai kamu atau orang lain."
   e) **Tindakan**: Mengalihkan pembahasan dari "siapa yang berisiko" menjadi "bagaimana cara melindungi diri sendiri" agar semua peserta tetap mendapatkan informasi.
   f) **Keselamatan**: Memastikan remaja tersebut tidak merasa diserang atau dipermalukan di depan teman-temannya, sehingga suasana diskusi tetap aman dan terbuka.

e. Daftar Periksa Evaluasi Kinerja Simulasi Edukasi IMS dan HIV

Aspek	Kriteria Penilaian	Ya/Tidak/Perlu Perbaikan
Tindakan	1. Isi informasi akurat, lengkap, dan sesuai pedoman resmi. 2. Materi disusun secara terstruktur dan logis, mudah diikuti. 3. Demonstrasi pemakaian kondom dilakukan langkah demi langkah dengan benar dan pada alat peraga. 4. Memberikan informasi layanan lanjutan yang jelas dan bisa diakses remaja	
Komunikasi	1. Bahasa yang digunakan sederhana, sesuai usia, dan tidak menggunakan istilah rumit tanpa penjelasan.	

	2. Sikap tubuh dan nada bicara tidak menghakimi, tidak menggurui, dan ramah. 3. Mampu mengoreksi kesalahpahaman/mitos dengan cara halus, tidak merendahkan. 4. Mampu menjawab pertanyaan sensitif dengan tenang dan berdasarkan fakta
Keselamatan	1. Menciptakan suasana aman di mana remaja berani bertanya tanpa takut dihukum atau dilaporkan. 2. Menjelaskan aturan kerahasiaan dan hak hukum remaja dengan benar. 3. Demonstrasi teknis dilakukan secara etis (menggunakan alat tiruan) dan higienis. 4. Tidak memberikan informasi yang berpotensi berbahaya atau menyesatkan.

3. Simulasi Rujukan IMS dan HIV

a. Tujuan Simulasi Rujukan IMS dan HIV

1) **Tindakan**: Mampu menentukan indikasi rujukan yang tepat, menyusun dokumen rujukan lengkap, dan mengatur alur pemindahan pasien sesuai standar pelayanan.
2) **Komunikasi**: Terampil menyampaikan alasan rujukan dengan bahasa yang mudah dipahami, menenangkan kekhawatiran, serta berkoordinasi efektif dengan fasilitas tujuan.
3) **Keselamatan**: Menjamin kepatuhan terhadap aturan hukum persetujuan dan kerahasiaan, keamanan data pasien, serta keselamatan fisik dan psikologis selama proses rujukan.

b. Persiapan Simulasi Rujukan IMS dan HIV

Katagori	Keterangan
Peralatan & Bahan	- Dokumen: Surat rujukan standar (disediakan kolom untuk data rahasia), formulir persetujuan tindakan medis, ringkasan hasil pemeriksaan.

- Data Pendukung: Daftar fasilitas kesehatan ramah remaja, nomor kontak petugas penghubung, informasi jaminan kesehatan/bantuan biaya.
- Simulasi: Alat komunikasi (telepon/radio tiruan), peta lokasi rute perjalanan, simulasi kendaraan evakuasi jika gawat darurat.

Lingkungan: Ruang pribadi tertutup untuk wawancara, dan area terpisah untuk simulasi koordinasi antar tenaga kesehatan. Pastikan suasana mendukung diskusi sensitif tanpa didengar orang lain.

Peran
- **Tenaga Kesehatan Perujuk**: Bertugas menilai kondisi, menyusun rujukan, dan berkomunikasi dengan remaja.
- **Remaja**: Memiliki karakter beragam (takut orang tua tahu, ragu berobat, kondisi gawat, atau memiliki keterbatasan biaya).
- **Tenaga Kesehatan Penerima**: Bertugas menerima rujukan dan mengonfirmasi kesiapan fasilitas.
- **Pengamat/Penilai**: Menggunakan daftar periksa yang berfokus pada ketiga aspek di atas.

Aturan Dasar
- Remaja ≥14 tahun berhak memberikan persetujuan sendiri untuk layanan kesehatan reproduksi, kecuali kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa atau memerlukan pembedahan besar.
- Kerahasiaan mutlak: data tidak disebarkan tanpa izin, kecuali ada risiko bahaya bagi diri sendiri atau orang lain.
- Isi surat rujukan hanya memuat informasi medis yang diperlukan, tidak menyertakan detail yang tidak relevan

c. Tahapan Simulasi Rujukan IMS dan HIV

Tahapan	Kegiatan Utama	Fokus Penilaian	Detail Pelaksanaan
1. Menentukan Indikasi Rujukan	Menilai kebutuhan dan kelayakan rujukan	**Tindakan & Keselamatan**	- Tindakan: Memastikan rujukan dilakukan karena alasan medis yang jelas: fasilitas

tidak memiliki alat/dokter spesialis, memerlukan pemeriksaan lanjutan (misal: hitung virus CD4), penanganan komplikasi, atau kondisi gawat. Jangan merujuk jika bisa ditangani di tempat.

- Komunikasi: Menjelaskan kesimpulan hasil pemeriksaan kepada remaja sebagai dasar alasan rujukan.
- Keselamatan: Menilai apakah kondisi remaja aman diangkut atau perlu penanganan stabilisasi terlebih dahulu. Memastikan rujukan tidak menunda penanganan yang bisa

				membahayakan nyawa.
2.	Penjelasan dan Persetujuan	Mengkomunikasikan rencana rujukan dan mendapatkan izin	**Semua Aspek**	- Tindakan: Menyusun penjelasan yang mencakup: ke mana akan dirujuk, siapa yang akan menangani, apa yang akan dilakukan di sana, dan perkiraan biaya/cara pembiayaan. - Komunikasi: Gunakan bahasa sederhana dan menenangkan. Contoh: "Alat di sini hanya bisa mendeteksi ada infeksinya, tapi untuk tahu seberapa parah dan berikan obat yang paling tepat, kamu perlu ke tempat yang alatnya lebih lengkap. Saya akan pastikan

				kamu diterima dengan baik di sana." - Keselamatan: Jelaskan aturan hukum: apakah perlu orang tua atau tidak, dan tegaskan kembali bahwa data akan dirahasiakan. Dapatkan persetujuan secara sadar dan sukarela, catat jika remaja menolak rujukan beserta alasannya.
3.	Persiapan Administrasi dan Medis	Menyusun dokumen dan memberikan penanganan awal	**Tindakan & Keselamatan**	- Tindakan: Mengisi surat rujukan lengkap: data identitas (bisa Gunakan inisial jika diperlukan demi privasi), hasil pemeriksaan, diagnosis dugaan, riwayat pengobatan yang sudah

diberikan, dan tujuan rujukan yang jelas. Berikan pengobatan atau penanganan awal yang mungkin dilakukan sebelum berangkat.

- Komunikasi: Jelaskan isi dokumen kepada remaja, Berikan salinan jika diperbolehkan dan aman.
- Keselamatan: Jangan mencatat informasi sensitif secara gamblang pada amplop atau bagian luar dokumen. Simpan data dengan aman. Pastikan tidak ada kesalahan data yang bisa membahayakan penanganan di tempat tujuan.

4.	Koordinasi Antara Fasilitas	Menghubungkan dan menyerahkan tanggung hawab	**Semua Aspek**	- Tindakan: Menghubungi petugas penerima, menyampaikan data penting, waktu perkiraan kedatangan, dan kebutuhan khusus (misal: butuh spesialis kulit kelamin, atau penanganan gawat darurat). - Komunikasi: Gunakan istilah medis yang jelas namun tetap jaga privasi. Sampaikan secara khusus: "Pasien ini masih remaja, mohon dilayani dengan pendekatan yang ramah dan menjaga kerahasiaan ya." - Keselamatan: Pastikan fasilitas tujuan siap menerima. Untuk kondisi

				gawat, atur transportasi medis dan pendampingan tenaga kesehatan. Jangan membiarkan remaja berangkat sendirian jika kondisinya tidak memungkinkan.
5.	Pendampingan dan Penutup	Memberikan dukungan dan memastikan kelanjutan layanan	**Semua Aspek**	- Tindakan: Memberikan petunjuk lokasi, jadwal pelayanan, dan nama orang yang harus dicari. Catat data kontak remaja untuk pemantauan (jika dia bersedia). - Komunikasi: Menjawab kekhawatiran terakhir. Contoh: "Kalau kamu bingung di jalan atau takut, kamu bisa telepon nomor ini.

Ingat, ini langkah supaya kamu cepat sembuh/sehat kembali."

- Keselamatan: Pastikan remaja memiliki cara transportasi yang aman dan dana yang cukup. Berikan nomor darurat. Jangan membiarkan remaja pergi dalam keadaan bingung atau putus asa.

d. Contoh Skenario Simulasi Rujukan IMS dan HIV

Skenario: Rujukan Hasil Reaktif dengan Masalah Kerahasiaan

1) **Situasi**: Seorang Remaja perempuan berusia 16 tahun, hasil tes cepat HIV reaktif. Fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak memiliki fasilitas untuk pemeriksaan lanjutan dan pengobatan. Remaja ini sangat takut kalau orang tuanya tahu dan memohon agar tidak ada dokumen yang mencantumkan nama lengkap atau diagnosis secara jelas di bagian luar amplop. Dia juga khawatir soal biaya
2) **Fokus Latihan**:
   a) **Tindakan**: Menentukan rujukan ke RS atau Puskesmas rujukan yang memiliki program VCT dan pengobatan ARV, serta memastikan akses pembiayaan melalui JKN atau bantuan lain. Mengisi surat rujukan lengkap namun aman.
   b) **Komunikasi**: Menjelaskan bahwa rujukan itu penting untuk keselamatan hidupnya, meyakinkan bahwa permintaan kerahasiaannya akan dipenuhi, dan menjelaskan skema pembiayaan agar dia tidak khawatir.

c) **Keselamatan**: Menulis diagnosis dengan kode atau istilah medis umum di bagian luar dokumen, menjelaskan kepada fasilitas tujuan agar menerima dengan pendekatan ramah remaja, dan memastikan dia berangkat dengan aman.

e. Daftar Periksa Evaluasi Kinerja Simulasi Rujukan IMS dan HIV

Aspek	Kriteria Penilaian	Ya/Tidak/Perlu Perbaikan
Tindakan	1. Indikasi rujukan tepat dan sesuai dengan kemampuan fasilitas serta kondisi pasien. 2. Surat rujukan lengkap memuat data medis yang diperlukan dan tujuan rujukan yang jelas. 3. Memberikan penanganan medis awal yang tepat sebelum pasien berangkat. 4. Mengatur jenis transportasi dan pendampingan yang sesuai dengan tingkat kegawatan.	
Komunikasi	1. Alasan rujukan dijelaskan dengan bahasa sederhana, mudah dimengerti, dan tidak membingungkan. 2. Mampu menenangkan kekhawatiran, ketakutan, atau keraguan yang dirasakan remaja. 3. Komunikasi dengan fasilitas tujuan jelas, ringkas, dan menyampaikan informasi penting termasuk status usia pasien. 4. Memberikan informasi lokasi, kontak, dan biaya secara jelas dan akurat	
Keselamatan	1. Penjelasan mengenai hak hukum remaja dan aturan kerahasiaan sudah benar dan dimengerti pasien. 2. Dokumen dan data pasien disusun dan disampaikan dengan cara menjaga privasi.	

3. Memastikan keamanan perjalanan dan kesiapan fasilitas tujuan sebelum pasien berangkat.
4. Tidak memaksa rujukan dan mencatat persetujuan atau penolakan pasien secara hukum

4. OSCE Ringkas + Critical Items

a. Skrining Risiko IMS & HIV Pada Remaja

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	05
2	Judul	Asuhan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi
3	Kasus	Skrining Risiko IMS & HIV Pada Remaja
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta ujian mampu melakukan skrining risiko IMS dan HIV pada remaja dengan pendekatan yang ramah, rahasia, dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
5	Kompetensi	1. Mampu melakukan anamnesis yang komprehensif dan sensitif terkait perilaku seksual dan faktor risiko lainnya pada remaja. 2. Mampu menilai tingkat risiko terinfeksi IMS dan HIV berdasarkan hasil pengkajian. 3. Mampu memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang IMS dan HIV, serta cara pencegahannya. 4. Mampu menjaga kerahasiaan data dan informasi pasien sesuai dengan etika kedokteran dan peraturan yang berlaku. 5. Mampu menentukan tindak lanjut yang tepat, termasuk pemeriksaan laboratorium, pengobatan, atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang remaja perempuan berusia 17 tahun datang ke Puskesmas dengan pendampingan temannya. Hasil anamnesis: pasien merasa khawatir karena baru saja

		mengetahui bahwa pasangan seksualnya pernah memiliki pasangan lain sebelumnya. pasien tidak mengalami gejala apa pun, tetapi ingin mengetahui apakah pasien berisiko terkena penyakit menular seksual. pasien juga bertanya tentang cara melindungi diri di masa depan. Pasien berharap semua informasi yang ia sampaikan tetap rahasia dan tidak diberitahukan kepada orang tuanya TUGAS PESERTA UJIAN 1. Menerima pasien dengan sikap ramah, sopan, dan menciptakan suasana yang nyaman serta aman. 2. Melakukan anamnesis dengan pertanyaan yang jelas, sensitif, dan sesuai dengan usia pasien, meliputi riwayat perilaku seksual, penggunaan alat pelindung, riwayat penyakit menular seksual sebelumnya, dan faktor risiko lainnya. 3. Menjelaskan hasil penilaian risiko kepada pasien dengan bahasa yang mudah dipahami. 4. Memberikan edukasi tentang IMS dan HIV, cara penularan, gejala, dampak, serta metode pencegahan yang efektif. 5. Menjelaskan manfaat dan prosedur pemeriksaan laboratorium, serta mendapatkan persetujuan pasien jika diperlukan. 6. Menjelaskan hak pasien terkait kerahasiaan data dan informasi. 7. Menentukan tindak lanjut yang tepat dan menjelaskannya kepada pasien. 8. Menutup pertemuan dengan sikap yang baik dan memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya kembali.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut:

		a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta. b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Bacakan skenario dan tugas peserta ujian dengan jelas dan lengkap sebelum peserta memulai tugas. 2. Amati dan nilai kinerja peserta berdasarkan rubrik penilaian yang telah ditetapkan, meliputi aspek komunikasi, pengetahuan, keterampilan klinis, dan perilaku profesional. 3. Jangan memberikan petunjuk atau bantuan kepada peserta selama pelaksanaan tugas, kecuali jika peserta mengalami kesulitan yang berlebihan atau situasi yang berbahaya. 4. Catat semua hal yang penting dan relevan selama pelaksanaan tugas. 5. Setelah selesai, berikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta tentang kinerjanya INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya.

		2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. Datang ke ruang pemeriksaan dengan sikap yang agak ragu-ragu dan khawatir. 2. Jawab pertanyaan peserta dengan jujur sesuai dengan peran, tetapi jika peserta bertanya dengan cara yang kasar atau tidak pantas, Anda dapat menolak menjawab atau mengekspresikan ketidaknyamanan. 3. Tanyakan hal-hal seperti: "Apakah saya pasti terkena penyakit?", "Apakah pemeriksaannya sakit?", "Apakah orang tua saya akan tahu?", "Bagaimana cara melindungi diri saya?". 4. Terima atau tolak usulan pemeriksaan atau tindakan lainnya sesuai dengan pertimbangan yang disampaikan oleh peserta
9	Dialog PS	**Peserta:** "Selamat pagi, silakan duduk. Saya adalah dokter yang akan melayani Anda hari ini. Boleh saya tahu nama Anda dan apa yang membawa Anda ke sini?" **PS:** "Selamat pagi. Nama saya Rina. Saya... saya agak takut untuk bicara, tapi teman saya menyarankan saya datang ke sini. Saya khawatir saya mungkin terkena sesuatu." **Peserta:** "Tidak perlu khawatir, Nona. Di sini semua yang Anda sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya, kecuali jika ada hal yang membahayakan nyawa Anda atau orang lain. Boleh Anda ceritakan apa yang membuat Anda khawatir?" **PS:** "Baiklah... Saya sudah berhubungan seksual dengan pacar saya sekitar dua minggu yang lalu. Kemarin saya mendengar dari orang lain bahwa dia pernah berhubungan dengan orang lain juga sebelumnya. Saya takut saya terkena penyakit. Saya tidak merasakan apa-apa, tapi tetap saja takut."

		Peserta: "Saya mengerti kekhawatiran Anda. Boleh saya tanya beberapa pertanyaan lagi agar saya bisa menilai situasi Anda dengan lebih baik? Apakah saat berhubungan seksual, kalian menggunakan kondom atau alat pelindung lainnya?" **PS:** "Tidak... kami tidak menggunakannya. Saya tidak tahu bahwa itu penting." **Peserta:** "Baiklah, terima kasih sudah memberitahu saya. Berdasarkan apa yang Anda ceritakan, memang ada risiko terinfeksi penyakit menular seksual, termasuk HIV. Tapi jangan panik dulu, karena tidak berarti Anda pasti terkena. Untuk memastikannya, kita bisa melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya tidak sakit dan cepat. Apakah Anda setuju untuk melakukannya? **PS:** "Apakah hasilnya akan segera keluar? Dan apakah orang tua saya akan tahu?" **Peserta:** "Hasilnya biasanya keluar dalam beberapa hari hingga satu minggu, tergantung jenis pemeriksaan. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, semua informasi ini adalah rahasia. Saya tidak akan memberitahukan kepada siapa pun, termasuk orang tua Anda, kecuali jika Anda mengizinkan atau ada situasi darurat yang membahayakan nyawa Anda." **PS:** "Baiklah, kalau begitu saya setuju untuk diperiksa. Tapi tolong beritahu saya juga bagaimana cara saya melindungi diri di masa depan." **Peserta:** "Tentu saja. Cara utama adalah dengan menggunakan kondom dengan benar setiap kali berhubungan seksual. Selain itu, penting untuk berbicara terbuka dengan pasangan tentang riwayat kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Saya juga akan memberikan brosur yang berisi informasi lebih lengkap." **PS:** "Terima kasih banyak, Dokter. Saya merasa lebih tenang sekarang."
10	Kebutuhan manikin	Tidak diperlukan dalam stasiun ini

11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: 1. Memahami prosedur pengambilan dan pengolahan sampel untuk pemeriksaan IMS dan HIV. 2. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan laboratorium. 3. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan kerja. 4. Menyimpan hasil pemeriksaan dengan aman dan rahasia, serta menyampaikannya kepada dokter yang menangani pasien.
12	Kebutuhan alat dan Bahan	1. Ruang pemeriksaan yang tertutup dan nyaman untuk menjaga kerahasiaan. 2. Meja dan kursi. 3. Formulir rekam medis. 4. Alat tulis. 5. Brosur atau materi edukasi tentang IMS dan HIV. 6. Alat dan bahan untuk pengambilan sampel (jika diperlukan): jarum suntik steril, tabung sampel, kapas, alkohol 70%, plester. 7. Lembar persetujuan pemeriksaan.
13	Penulis	Bdn. Ermaya Sari Bayu Ningsih, SST., M.Kes., M.Keb
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Remaja. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Penatalaksanaan Infeksi Menular Seksual dan HIV/AIDS. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2021. 3. World Health Organization. Guidelines for the Management of Sexually Transmitted Infections. Geneva: WHO; 2021. 4. World Health Organization. Adolescent and Young Adult Health: A Global Perspective. Geneva: WHO; 2022

b. Edukasi tentang IMS & HIV

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	06
2	Judul	Asuhan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi
3	Kasus	Edukasi tentang IMS & HIV Pada Remaja
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta ujian mampu memberikan edukasi tentang IMS dan HIV kepada remaja dengan bahasa yang mudah dipahami, pendekatan yang ramah dan sensitif, serta sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, sehingga remaja dapat memahami risiko, cara penularan, gejala, dampak, dan metode pencegahan yang tepat.
5	Kompetensi	1. Mampu menyampaikan informasi tentang definisi, jenis, cara penularan, gejala, dan dampak IMS serta HIV dengan akurat dan sesuai dengan tingkat pemahaman remaja. 2. Mampu menjelaskan metode pencegahan yang efektif, termasuk perilaku sehat dan penggunaan alat pelindung. 3. Mampu menjawab pertanyaan dan keraguan remaja dengan jelas, jujur, dan tidak menimbulkan ketakutan yang berlebihan. 4. Mampu menciptakan suasana percakapan yang terbuka, aman, dan menjaga kerahasiaan. 5. Mampu mengarahkan remaja untuk melakukan pemeriksaan atau mendapatkan bantuan lebih lanjut jika diperlukan
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun datang ke Puskesmas bersama temannya. Hasil anamnesis: pasien mendengar dari teman-temannya tentang penyakit menular seksual dan HIV, tetapi ia masih banyak yang tidak mengerti dan bingung antara informasi yang benar dan salah. Pasien bertanya-tanya apakah ia bisa terkena penyakit tersebut hanya dengan bergaul dekat, apa tanda-tandanya, dan bagaimana cara melindungi

No.	Komponen	Isi
		dirinya. Pasien juga merasa malu untuk bertanya kepada orang tua atau guru. TUGAS PESERTA UJIAN 1. Menerima pasien dengan sikap ramah, sopan, dan menciptakan suasana yang nyaman serta aman. 2. Menjelaskan definisi, jenis, cara penularan, gejala, dan dampak IMS serta HIV dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta membedakan antara fakta dan mitos. 3. Menjelaskan metode pencegahan yang efektif, termasuk prinsip ABCDE dalam pencegahan HIV/AIDS. 4. Menjawab semua pertanyaan dan keraguan pasien dengan jelas dan jujur. 5. Menjelaskan pentingnya pemeriksaan dini dan tempat di mana pasien bisa mendapatkan layanan yang ramah dan rahasia. 6. Menutup percakapan dengan sikap yang baik dan memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya kembali
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta. b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4)

No.	Komponen	Isi
		4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Bacakan skenario dan tugas peserta ujian dengan jelas dan lengkap sebelum peserta memulai tugas. 2. Amati dan nilai kinerja peserta berdasarkan rubrik penilaian yang telah ditetapkan, meliputi aspek komunikasi, keakuratan informasi, kemampuan menjelaskan, dan perilaku profesional. 3. Jangan memberikan petunjuk atau bantuan kepada peserta selama pelaksanaan tugas, kecuali jika peserta mengalami kesulitan yang berlebihan atau situasi yang berbahaya. 4. Catat semua hal yang penting dan relevan selama pelaksanaan tugas. 5. Setelah selesai, berikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta tentang kinerjanya. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Kebutuhan: 1. Berpakaian seperti remaja pada umumnya. 2. Memahami skenario dan peran yang harus dimainkan dengan baik. 3. Menjawab pertanyaan peserta sesuai dengan skenario, tetapi juga dapat menambahkan jawaban yang wajar dan sesuai dengan situasi.

No.	Komponen	Isi
		4. Dapat mengekspresikan perasaan bingung, malu, atau khawatir seperti yang dijelaskan dalam skenario. 5. Dapat mengajukan pertanyaan kepada peserta terkait informasi yang disampaikan. Instruksi PS: 1. Datang ke ruang pemeriksaan dengan sikap yang agak ragu-ragu dan malu. 2. Jawab pertanyaan peserta dengan jujur sesuai dengan peran, tetapi jika peserta bertanya dengan cara yang kasar atau tidak pantas, Anda dapat menolak menjawab atau mengekspresikan ketidaknyamanan. 3. Tanyakan hal-hal seperti: "Apakah saya bisa terkena HIV jika bersalaman atau makan bersama orang yang terkena?", "Apa tanda-tanda jika saya terkena penyakit ini?", "Apakah ada cara untuk melindungi diri selain tidak berhubungan seksual?", "Di mana saya bisa diperiksa tanpa orang lain tahu?". 4. Tunjukkan reaksi yang wajar terhadap informasi yang disampaikan, seperti merasa lega atau masih memiliki keraguan.
9	Dialog PS	**Peserta:** "Selamat siang, silakan duduk. Saya adalah tenaga kesehatan yang akan membantu Anda hari ini. Boleh saya tahu nama Anda dan apa yang membawa Anda ke sini?" **PS:** "Selamat siang. Nama saya Budi. Saya... saya agak malu untuk bicara, tapi teman saya menyarankan saya datang. Saya mendengar teman-teman bicara tentang penyakit menular seksual dan HIV, tapi saya tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah." **Peserta:** "Tidak perlu malu, Budi. Di sini Anda bisa bertanya apa saja dan semua yang Anda sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya. Apa yang ingin Anda ketahui lebih lanjut?"

No.	Komponen	Isi
		PS: "Terima kasih. Saya ingin tahu, apakah saya bisa terkena HIV jika saya bersalaman, berpelukan, atau makan bersama orang yang memiliki virus itu? Dan apakah penyakit ini hanya menular melalui hubungan seksual?" **Peserta:** "Itu pertanyaan yang bagus. Saya jelaskan ya. HIV dan sebagian besar IMS hanya menular melalui cairan tubuh tertentu, yaitu darah, cairan kelamin, dan air susu ibu. Jadi, bersalaman, berpelukan, makan bersama, menggunakan toilet bersama, atau berenang di kolam yang sama tidak akan menularkan penyakit ini. Selain hubungan seksual yang tidak aman, penularan juga bisa terjadi melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau dari ibu hamil yang positif ke janinnya." **PS:** "Oh, jadi saya tidak perlu takut bergaul dengan orang yang terkena ya. Tapi kalau saya terkena, apa tanda-tandanya? Apakah pasti terlihat segera?" **Peserta:** "Tidak selalu. Beberapa IMS dan HIV pada awalnya mungkin tidak memiliki gejala apa pun, tetapi tetap bisa menularkan ke orang lain. Jika ada gejala, biasanya berupa gatal-gatal, nyeri saat buang air kecil, keluar cairan yang tidak wajar dari kelamin, luka atau benjolan di area kelamin, atau demam dan nyeri tubuh. Karena sering tidak ada gejala, pemeriksaan adalah cara terbaik untuk memastikan." **PS:** "Kalau begitu, bagaimana cara saya melindungi diri saya? Apakah hanya dengan tidak berhubungan seksual saja?" **Peserta:** "Tidak berhubungan seksual adalah cara yang paling efektif, tetapi ada juga cara lain. Kita bisa menggunakan prinsip ABCDE: A adalah menahan diri dari hubungan seksual sebelum menikah, B adalah setia pada satu pasangan yang sehat, C adalah menggunakan kondom dengan benar jika berhubungan seksual, D adalah tidak menggunakan narkoba atau alat suntik

No.	Komponen	Isi
		bersama, dan E adalah terus belajar dan mendapatkan informasi yang benar." **PS:** "Bagus sekali. Kalau saya ingin diperiksa, di mana saya bisa pergi? Apakah orang lain akan tahu?" **Peserta:** "Anda bisa datang kembali ke sini atau ke fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki layanan kesehatan ramah remaja. Semua layanan ini menjaga kerahasiaan pasien, jadi tidak ada orang lain yang akan tahu kecuali Anda yang memberitahukan. Pemeriksaannya juga tidak sakit dan prosesnya cepat." **PS:** " "Terima kasih banyak. Saya merasa lebih paham dan tidak takut lagi sekarang."
10	Kebutuhan manikin	Tidak diperlukan dalam stasiun ini
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: Tidak diperlukan dalam stasiun ini, namun jika pasien setuju untuk diperiksa, laboran harus siap melakukan prosedur pengambilan dan pengolahan sampel sesuai standar.
12	Kebutuhan alat dan Bahan	1. Ruang percakapan yang tertutup dan nyaman untuk menjaga kerahasiaan. 2. Meja dan kursi. 3. Brosur atau materi edukasi tentang IMS dan HIV yang disesuaikan untuk remaja. 4. Alat tulis. 8. Daftar alamat fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan ramah remaja.
13	Penulis	Bdn. Ermaya Sari Bayu Ningsih, SST., M.Kes., M.Keb
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Remaja. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan IMS/HIV/AIDS bagi Remaja. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2022.

No.	Komponen	Isi
		3. World Health Organization. Adolescent-friendly Health Services: An Imperative for Universal Health Coverage. Geneva: WHO; 2025. 4. World Health Organization. Global Health Sector Strategy on Sexually Transmitted Infections, 2021–2030. Geneva: WHO; 2021

c. Rujukan tentang IMS & HIV

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	07
2	Judul	Asuhan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi
3	Kasus	Rujukan tentang Kasus IMS & HIV Pada Remaja
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta ujian mampu menentukan indikasi rujukan, menyusun dokumen rujukan yang lengkap dan akurat, serta menjelaskan proses rujukan kepada remaja dengan pendekatan yang ramah, sensitif, dan menjaga kerahasiaan, sehingga pasien dapat menerima dan mengikuti proses rujukan dengan baik.
5	Kompetensi	1. Mampu mengidentifikasi indikasi rujukan IMS dan HIV pada remaja sesuai dengan pedoman pelayanan kesehatan. 2. Mampu menyusun surat rujukan yang memuat data lengkap pasien, riwayat klinis, hasil pemeriksaan, dan tujuan rujukan dengan jelas. 3. Mampu menjelaskan alasan rujukan, tempat tujuan, prosedur yang akan dilakukan, dan pentingnya mengikuti proses rujukan kepada pasien dengan bahasa yang mudah dipahami. 4. Mampu menangani kekhawatiran, ketakutan, atau penolakan pasien terkait rujukan, serta menjamin kerahasiaan data dan informasi. 5. Mampu mengkoordinasikan rujukan dengan fasilitas kesehatan tujuan dan memberikan informasi tentang hak dan dukungan yang tersedia bagi remaja.

6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang remaja perempuan berusia 17 tahun telah diperiksa di Puskesmas. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kecurigaan infeksi sifilis dan hasil tes cepat HIV menunjukkan reaktif. Puskesmas tidak memiliki fasilitas untuk pemeriksaan lanjutan dan pengobatan yang lengkap, serta tidak memiliki tenaga ahli yang terlatih untuk menangani kasus ini pada remaja. Pasien merasa takut, malu, dan khawatir akan diketahui orang lain, serta ragu apakah harus pergi ke tempat tujuan rujukan. Pasien juga bertanya apakah ia harus datang sendiri atau boleh didampingi, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. TUGAS PESERTA UJIAN 1. Menjelaskan alasan rujukan kepada pasien dengan jujur, jelas, dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan usianya, tanpa menimbulkan ketakutan yang berlebihan. 2. Menyusun surat rujukan yang lengkap, meliputi data identitas pasien, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium, diagnosis sementara, serta tujuan dan permintaan tindakan dari fasilitas kesehatan tujuan. 3. Menjelaskan tempat tujuan rujukan, cara menuju ke sana, jam pelayanan, dan prosedur yang akan dilakukan di sana. 4. Menjawab semua pertanyaan dan keraguan pasien, termasuk tentang kerahasiaan, pendampingan, dan biaya pelayanan. 5. Memastikan pasien memahami dan menyetujui proses rujukan, serta memberikan informasi tentang dukungan atau layanan pendampingan yang tersedia. 6. Menutup percakapan dengan sikap yang mendukung dan memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya kembali.

7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi - 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta. b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Bacakan skenario dan tugas peserta ujian dengan jelas dan lengkap sebelum peserta memulai tugas. 2. Amati dan nilai kinerja peserta berdasarkan rubrik penilaian yang telah ditetapkan, meliputi aspek komunikasi, pengetahuan, keterampilan klinis, dan perilaku profesional. 3. Jangan memberikan petunjuk atau bantuan kepada peserta selama pelaksanaan tugas, kecuali jika peserta mengalami kesulitan yang berlebihan atau situasi yang berbahaya. 4. Catat semua hal yang penting dan relevan selama pelaksanaan tugas. 5. Setelah selesai, berikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta tentang kinerjanya KEBUTUHAN

		1. Berpakaian seperti remaja pada umumnya. 2. Memahami skenario dan peran yang harus dimainkan dengan baik, termasuk kondisi kesehatan dan perasaan yang dialami. 3. Menjawab pertanyaan peserta sesuai dengan skenario, dan dapat menambahkan jawaban yang wajar sesuai dengan situasi. 4. Dapat mengekspresikan perasaan takut, malu, ragu, atau khawatir seperti yang dijelaskan dalam skenario. 5. Dapat mengajukan pertanyaan kepada peserta terkait proses rujukan dan hal-hal yang dikhawatirkan. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Bacakan skenario dan tugas peserta ujian dengan jelas dan lengkap sebelum peserta memulai tugas. 2. Amati dan nilai kinerja peserta berdasarkan rubrik penilaian yang telah ditetapkan, meliputi aspek komunikasi, keakuratan informasi, kemampuan menjelaskan, dan perilaku profesional
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. Datang ke ruang pemeriksaan dengan sikap yang cemas dan agak menunduk. 2. Jawab pertanyaan peserta dengan jujur sesuai peran, tetapi jika peserta berbicara dengan cara yang kasar atau tidak pantas, Anda dapat mengekspresikan ketidaknyamanan atau menolak berbicara lebih lanjut. 3. Tanyakan hal-hal seperti: "Mengapa saya harus pindah ke tempat lain? Apakah penyakit saya sangat parah?", "Apakah orang di sana akan tahu tentang penyakit saya?", "Bolehkah saya membawa teman saya bersama?", "Apakah biayanya mahal? Saya tidak punya banyak uang". 4. Tunjukkan reaksi yang wajar terhadap penjelasan peserta, seperti mulai merasa tenang atau masih memiliki keraguan yang perlu dijelaskan lagi.

		5. Terakhir, nyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rujukan berdasarkan penjelasan yang diterima.
9	Dialog PS	**Peserta:** "Selamat siang, Rina. Sebelumnya saya sudah menjelaskan hasil pemeriksaanmu ya. Sekarang saya ingin bicara tentang langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan. Apakah kamu siap mendengarkan?" **PS:** "Selamat siang... Baiklah, Dokter. Tapi tolong bicara dengan jelas ya, saya sudah sangat takut sejak tadi." **Peserta:** "Tentu saja. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menemukan tanda-tanda infeksi dan hasil tes HIV menunjukkan reaktif. Di Puskesmas ini, kami tidak memiliki alat dan tenaga ahli yang cukup untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memberikan pengobatan yang tepat untuk kasusmu. Oleh karena itu, kami perlu mengirimkanmu ke Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki layanan khusus dan tenaga yang terlatih untuk menangani remaja dengan kondisi seperti ini. Ini bukan berarti penyakitmu tidak bisa diobati, justru ini agar kamu mendapatkan penanganan yang paling baik. **PS:** "Oh... jadi penyakit saya parah ya? Saya takut sekali. Apakah orang di sana akan tahu semua hal tentang saya? Saya tidak mau orang lain tahu." **Peserta:** "Saya mengerti kekhawatiranmu. Tapi saya pastikan, kondisi ini bisa ditangani dengan baik jika mendapatkan penanganan yang tepat. Dan mengenai kerahasiaan, semua fasilitas kesehatan wajib menjaga informasi pasien, terutama untuk remaja. Hanya tenaga kesehatan yang menangani kamu yang akan mengetahui, dan tidak akan diberitahukan kepada siapa pun tanpa izinmu, kecuali situasi darurat yang membahayakan nyawa." **PS:** "Kalau begitu... bolehkah saya membawa teman saya yang sudah menemani saya hari ini? Saya lebih berani jika ada dia."

		Peserta: "Tentu saja boleh, bahkan kami sangat menyarankan kamu didampingi orang yang kamu percaya agar kamu merasa lebih tenang. Tapi jika kamu tidak ingin, kamu juga bisa datang sendiri. Di sana juga ada konselor yang siap membantu dan mendengarkanmu." **PS:** "Terima kasih. Lalu bagaimana dengan biayanya? Saya dan orang tua saya tidak punya banyak uang." **Peserta:** "Jangan khawatir soal biaya. Kasus ini termasuk dalam pelayanan kesehatan yang didukung oleh pemerintah, dan bisa ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional atau program bantuan lainnya. Kami juga akan mencantumkan hal ini dalam surat rujukan agar kamu mendapatkan kemudahan. Kamu tidak perlu membayar biaya yang memberatkan." **PS:** "Oh, itu bagus sekali. Jadi kapan saya harus pergi ke sana dan apa yang harus saya bawa?" **Peserta:** "Kami sarankan kamu pergi dalam waktu 3 hari ke depan agar penanganan bisa segera dilakukan. Kamu hanya perlu membawa surat rujukan yang akan saya buatkan ini, serta kartu identitas atau kartu kesehatan jika ada. Di sana jam pelayanannya dari Senin sampai Jumat, pukul 08.00 hingga 14.00, dan ada layanan khusus remaja yang lebih nyaman." **PS:** ""Baiklah Dokter, saya mengerti dan saya akan pergi. Terima kasih sudah menjelaskan semuanya dengan baik, saya tidak terlalu takut lagi sekarang."
10	Kebutuhan manikin	Tidak diperlukan dalam stasiun ini
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: 1. Telah menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium yang akurat dan lengkap kepada peserta ujian sebagai dasar rujukan. 2. Siap memberikan informasi tambahan atau klarifikasi terkait hasil pemeriksaan jika diminta oleh peserta atau penguji.

		3. Menyimpan data pemeriksaan dengan aman dan rahasia sesuai peraturan yang berlaku.
12	Kebutuhan alat dan Bahan	1. Ruang percakapan yang tertutup dan nyaman untuk menjaga kerahasiaan. 2. Meja dan kursi. 3. Formulir surat rujukan resmi. 4. Alat tulis. 5. Daftar alamat, jam pelayanan, dan informasi kontak fasilitas kesehatan tujuan. 6. Brosur atau materi informasi tentang layanan kesehatan ramah remaja dan hak pasien. 7. Hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium pasien yang telah dicetak atau ditulis.
13	Penulis	Bdn. Ermaya Sari Bayu Ningsih, SST., M.Kes., M.Keb
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Rujukan Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Penatalaksanaan Infeksi Menular Seksual dan HIV/AIDS pada Remaja. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2021. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Remaja. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2020. 4. World Health Organization. Health Service Delivery Guidelines for Adolescents. Geneva: WHO; 2022.

F. Rubrik Penilaian Dan Kelulusan

Stase 5: Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Identifikasi Faktor Risiko pada remaja (Menilai perilaku seksual berisiko seperti seks pranikah, berganti pasangan, tidak menggunakan kondom)		
2. Riwayat paparan NAPZA		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
3. Riwayat kontak dengan pasangan yang berisiko		
4. Riwayat keluarga dengan HIV/IMS		
5. Gejala yang dirasakan		
6. Stigma/ kekhawatiran terkait pengobatan		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3 = Jika peserta ujian melakukan semua 6 langkah dengan benar.
- 2 = Jika peserta melakukan 4–5 dari 8 langkah dengan benar.
- 1 = Jika peserta melakukan 1–3 dari 8 langkah dengan benar.
- 0 = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi remaja (pasien)		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Skrining risiko		
- Menilai riwayat perilaku seksual berisiko dengan menggunakan formulir standar (usia pertama seks, jumlah pasangan, penggunaan kondom).		
- Menilai riwayat paparan NAPZA		
- Menilai riwayat IMS/ HIV pada diri atau pasangan		
- Menilai gejala yang dirasakan (misalnya keluarnya cairan genital, nyeri saat BAK)		
- Menilai katagori tingkat risiko (rendah, sedang, tinggi) untuk menentukan pemeriksaan berikutnya.		

- Menilai hasil pemeriksaan fisik (pemeriksaan umum dan pemeriksaan genital/anal (dengan persetujuan) untuk melihat tanda-tanda IMS seperti luka, kemerahan, atau pembengkakan).		
- Menilai Tes Diagnostik berdasarkan risiko (tes cepat HIV, tes darah untuk sifilis dan hepatitis, tes urine atau swab untuk klamidia dan gonore. Jelaskan proses tes dan waktu tunggu hasil).		
b. Edukasi		
- **Edukasi Selama Pemeriksaan**: Sampaikan informasi sesuai kondisi remaja, seperti cara penularan, pencegahan (penggunaan kondom yang benar, vaksinasi HPV), manfaat tes dini, dan dampak kesehatan. Jawab pertanyaan dengan jelas dan berikan materi edukasi yang mudah dipahami.		
- **Pemberian Hasil**: Berikan hasil dengan cara sensitif dan jelas. Jelaskan makna hasil (positif/negatif), dampak kesehatan, dan langkah selanjutnya.		
3. Pasca tindakan		
a. Untuk Hasil Negatif		
- **Edukasi**: Jelaskan bahwa hasil negatif tidak menjamin keamanan sepanjang waktu, terutama jika ada perilaku berisiko berkelanjutan. Tekankan pentingnya pencegahan dengan abstinensi, kesetiaan pasangan, dan penggunaan kondom (prinsip ABCDE)		
- **Pencegahan Lanjutan**: Bagi remaja yang aktif secara seksual atau memiliki perilaku berisiko tinggi, jelaskan tentang Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) jika tersedia secara lokal, serta pentingnya pemeriksaan rutin.		
- **Rujukan**: Jika diperlukan, rujuk ke konselor untuk edukasi lebih lanjut atau dukungan psikologis, terutama jika ada riwayat kekerasan atau trauma seksual.		
b. Untuk Hasil Positif		
- **Konseling Pasca Diagnosis**: Berikan informasi tentang pengobatan (obat antiretroviral/ARV yang perlu		

diminum seumur hidup dengan kepatuhan tinggi), pencegahan transmisi (penggunaan kondom, tidak berbagi alat suntik), dan hak akses ke layanan kesehatan.		
- **Rujukan Medis**: Segera rujuk ke spesialis penyakit dalam atau kandungan yang menangani IMS/HIV untuk pengelolaan lebih lanjut. Untuk kasus IMS seperti sifilis atau gonore, berikan pengobatan antibiotik sesuai dosis dan durasi yang tepat.		
- **Dukungan Psikososial**: Rujuk ke konselor atau lembaga dukungan sosial untuk membantu remaja mengatasi stigma, depresi, atau masalah psikologis lainnya. Selain itu, dorong untuk memberitahu pasangan seksual agar melakukan pemeriksaan dan pengobatan jika diperlukan.		
- **Pemantauan**: Jadwalkan kunjungan kontrol secara berkala untuk memantau respons pengobatan, kepatuhan minum obat, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan.		
c. Untuk Kasus Paparan Akidental		
- Jika remaja mengalami paparan berisiko (seperti hubungan seks tanpa pelindung, pelecehan seksual), jelaskan tentang Post-Exposure Prophylaxis (PEP) yang harus dimulai sesegera mungkin (idealnya dalam 1-36 jam dan maksimal 72 jam setelah paparan) dengan kursus 28 hari obat ARV. Lakukan tes HIV awal dan pemeriksaan lanjutan sesuai jadwal.		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3 = Jika peserta ujian melakukan 16–23 langkah dengan tepat dan sistematis.
- 2 = Jika peserta melakukan 14–15 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- 1 = Jika peserta melakukan 1–13 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- 0 = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi remaja/ pasien dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
4. Menjelaskan perlunya kolaborasi/rujukan segera		
5. Menenangkan remaja dan melibatkan keluarga/pendamping		
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3 = Jika peserta ujian melakukan semua 6 langkah dengan benar.
- 2 = Jika peserta melakukan 4–5 dari 6 langkah dengan benar.
- 1 = Jika peserta melakukan 1–3 dari 6 langkah dengan benar.
- 0 = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons pasien (remaja)		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3 = Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2 = Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1 = Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0 = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Infeksi Menular Seksual dan HIV pada Remaja: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan
(World Health Organization, 2025)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Menular Seksual dan HIV pada Remaja: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada remaja (pasien), lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan tindakan awal Tindakan skrining risiko, edukasi, rujukan pada kasus IMS dan HIV.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal yang aman, cepat, dan sistematis pada remaja berdasarkan skrining Risiko, edukasi dan rujukan serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat. WHO menekankan pentingnya asuhan berdasarkan evidence-based.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang skrining Risiko IMS dan HIV, tetapi dari kemampuannya menilai kondisi remaja, membaca data hasil skrining, melakukan edukasi, dan menjelaskan kebutuhan kolaborasi atau rujukan.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya	Seorang remaja putri berusia 17 tahun, datang ke puskesmas B dengan keluhan ringan nyeri saat buang air kecil dan keluarnya

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Menular Seksual dan HIV pada Remaja: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan
	pengenalan prolonged atau obstructed labour, identifikasi tanda bahaya, penggunaan format standar skrining IMS dan HIV, serta pengambilan keputusan awal. Strategi WHO yang merupakan sektor kesehatan global untuk IMS dan HIV dengan tujuan mengurangi infeksi gonore dan sifilis sebesar 90% pada tahun 2030, dengan menekankan peningkatan layanan pencegahan, diagnostik, dan pengobatan.	cairan tidak normal dari alat kelamin selama 3 hari terakhir. Hasil anamnesis: Dia merasa ragu untuk memberitahu orang tuanya dan hanya memberitahu sahabatnya yang kemudian menyarankan dia untuk mencari bantuan medis, dan mengakuin bahwa dia telah aktif secara seksual selama 6 bulan dengan satu pasangan, namun mereka tidak selalu menggunakan kondom. Dia juga tidak mengetahui status kesehatan seksual pasangannya dan pernah merasa khawatir setelah melihat informasi tentang IMS di media sosial. Hasil Pemeriksaan: terdapat kemerahan pada area kelamin. Hasil tes lab: menunjukkan pasien positif terhadap klamidia, namun negatif terhadap HIV dan sifilis.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum remaja, tanda vital, Anamnesis risiko, tanda dan gejala IMS dan HIV. WHO menekankan peningkatan	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi remaja melalui skrining risiko, lalu menjelaskan edukasi yang tepat dan deteksi dini bila perlu rujukan segera.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Menular Seksual dan HIV pada Remaja: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan
	layanan pencegahan, diagnostik, dan pengobatan.	
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan skrining Risiko, edukasi dan rujukan terhadap infeksi menular seksual dan HIV.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal. Pada persalinan lama atau obstruktif, WHO layanan skrining dengan pendekatan inovatif seperti tes cepat dan layanan berbasis komunitas, serta menekankan penerapan prinsip 5C (persetujuan, kerahasiaan, konseling, hasil tes yang benar, dan hubungan dengan layanan pencegahan dan perawatan).	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi risiko tinggi berdasarkan hasil skrining risiko, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan atau menyiapkan rujukan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan melakukan skrining Risiko tetapi masih perlu meningkatkan keterampilan dalam

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Menular Seksual dan HIV pada Remaja: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan
	assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	menyampaikan edukasi dan tindakan rujukan bila diperlukan.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kegawatan, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus partus lama dan distosia, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan skrining risiko, edukasi dan rujukan pada remaja terhadap kasus IMS dan HIV secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

Tabel Portofolio pada Infeksi Menular seksual dan HIV pada remaja: Skrining Risiko, Edukasi, Rujukan.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Menular Seksual dan HIV pada Remaja: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik skrining risiko, edukasi serta rujukan kasus IMS dan HIV pada remaja memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian data skrining risiko, edukasi yang tepat dan rujukan ke fasilitas lanjutan dengan melakukan tindakan awal yang tepat, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani skrining risiko, tetapi juga menunjukkan kemampuan memberikan edukasi sesuai kebutuhan pasien dan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi data perilaku berisiko dengan melakukan skrining risiko, pemeriksaan lab dan edukasi tentang IMS dan HIV. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian hasil anamnesis risiko berdasarkan skrining resiko apakah

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Menular Seksual dan HIV pada Remaja: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan
		membutuhkan rujukan kepasilitas lanjutan.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah remaja, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus remaja putri berusia 17 tahun dengan keluhan nyeri saat buang air kecil, keluar cairan abnormal, lesi kulit, lemas dan demam. Tindakan awal skrining Risiko, pemeriksaan tes lab dan keputusan rujukan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya skrining risiko dan memberikan edukasi serta melakukan rujukan ke spesialis atau Lembaga pendukung awal (untuk memberian antibiotic IMS, rencana pemberian ART untuk HIV)
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali risiko berdasarkan hasil skrining IMS dan HIV, melakukan edukasi serta melakukan tes lab cepat untuk mendapatkan hasil awal untuk Tindakan rujukan ke fasilitas layanan lanjutan.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus pasien dengan risiko IMS dan HIV, namun mahasiswa mampu melakukan skrining Risiko, edukasi dengan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Menular Seksual dan HIV pada Remaja: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan
		tepat dan rencana rujukan yang akurat.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan skrining risiko tindakan awal, edukasi tentang IMS dan HIV dan merencanakan rujukan ke fasilitas lanjutan
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik infeksi menular seksual dan HIV, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata seperti melakukan skrining risiko, edukasi dan rujukan.

Tabel Case Report pada Infeksi Menular seksual dan HIV pada remaja: Skrining Risiko, Edukasi, Rujukan.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Menular Seksual dan HIV pada Remaja: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang remaja dengan perilaku seksual berisiko dengan melakukan skrining

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Menular Seksual dan HIV pada Remaja: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan
	sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	risiko, edukasi dan rujukan dengan IMS dan HIV.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kesehatan dan kebidanan, rencana tindakan, implementasi, serta evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data remaja, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan pada kasus IMS dan HIV setelah intervensi awal seperti skrining.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan/kesehatan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan hasil skrining risiko, melakukan edukasi tentang IMS dan HIV serta keputusan rujukan ke fasilitas lanjutan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mendeteksi Risiko IMS dan HIV berdasarkan skrining Risiko dan melakukan edukasi serta rujukan segera ke fasilitas lanjutan.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan	Berdasarkan kasus IMS dan HIV pada remaja, mahasiswa belajar bahwa skrining Risiko dan edukasi IMS dan HIV serta

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Menular Seksual dan HIV pada Remaja: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan
	merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	rencana rujukan ke fasilitas lanjutan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep IMS dan HIV tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan ataupun kesehatan secara utuh.

Tabel Refleksi Patient Safety pada Infeksi Menular seksual dan HIV pada remaja: Skrining Risiko, Edukasi, Rujukan.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Menular Seksual dan HIV pada Remaja: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus IMS dan HIV, mahasiswa merefleksikan bahwa skrining risiko dan menjaga kerahasiaan penting dilakukan guna menjaga privasi pasien.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan/ kesehatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah membaca hasil lab dan skrining Risiko IMS dan HIV serta menunda rujukan ke fasilitas lanjutan.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Infeksi Menular Seksual dan HIV pada Remaja: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan
	penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	adalah skrining Risiko tepat, edukasi akurat dan keterlambatan penanganan rujukan ke fasilitas lanjutan dengan pencegahan penyebaran kasus.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain terlambat deteksi dini kasus IMS dan HIV, skrining Risiko yang tidak akurat dan keterlambatan rujukan.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya penggunaan skrining risiko, pemeriksaan tes dan eduksi IMS-HIV serta rujukan tepat waktu ke fasilitas yang lebih mampu.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada skrining risiko, edukasi tentang IMS dan HIV, pengambilan keputusan cepat, dan keberanian melakukan Tindakan rujukan dalam praktik bidan yang aman ke fasilitas kesehatan lanjutan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap professional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan dan kesehatan secara berkelanjutan.

G. Tabel Red Flags & Eskalasi

Infeksi Menular seksual dan HIV pada remaja: Skrining Risiko, Edukasi, Rujukan.

Kondisi	Kondisi Klinis	Tanda Klinis (Red Flags)	Tatalaksana Awal	Kriteria Rujukan (Eksalasi)
IMS Umum	- Infeksi pada saluran reproduksi, alat kelamin, atau bagian tubuh lain yang terpapar melalui kontak seksual. - Bisa bersifat akut atau kronis, tergantung jenis dan durasi infeksi.	- Keputihan abnormal (warna, bau, konsistensi tidak normal). - Nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil. - Luka, lepuhan, atau ruam di area genital atau sekitarnya. - Gatal pada area genital. - Perdarahan di luar siklus menstruasi atau setelah hubungan seksual. - Nyeri panggul atau saat berhubungan seksual. - Pembengkakan atau kemerahan di area genital. - Gejala spesifik tergantung jenis IMS (misalnya, luka tanpa rasa sakit pada sifilis, lepuhan berisi cairan pada herpes genital).	- Anamnesis menyeluruh tentang riwayat seksual dan keluhan. - Pemeriksaan fisik dan pengambilan spesimen untuk tes laboratorium (misalnya, tes kultur, PCR, tes darah). - Pemberian antibiotik atau obat antivirus sesuai jenis IMS (misalnya, penisilin untuk sifilis, azitromisin untuk klamidia). - Edukasi tentang perilaku seksual sehat, penggunaan kondom, dan pentingnya pengobatan pasangan seksual. - Pemberian kondom dan anjuran pemakaian secara konsisten. - Pencatatan dan pelaporan kasus sesuai peraturan lokal.	- Kasus yang tidak menanggapi pengobatan awal. - Kasus dengan komplikasi (misalnya, radang panggul pada wanita, epididimitis pada pria). - Kasus dengan gejala yang tidak jelas atau tidak khas. - Kasus pada kelompok khusus (misalnya, wanita hamil, anak-anak). - Kasus yang memerlukan tes atau pengobatan yang tidak tersedia di fasilitas primer. - Kasus dengan riwayat eksposur yang kompleks atau risiko tinggi penularan.
HIV	- Infeksi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4. - Tahapan Infeksi meliputi fase akut, fase laten klinis, dan fase AIDS jika tidak diobati. - Pada fase akut, virus sangat menular dan	- Fase Akut: Demam, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, ruam, sakit tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, penurunan berat badan, batuk, keringat malam. - Fase Laten Klinis: Biasanya tidak ada gejala yang jelas.	- Diagnosis: Tes HIV (misalnya, tes cepat, tes darah untuk antibodi atau antigen p24). - Pemeriksaan tambahan: Tes muatan virus HIV, hitung sel CD4, tes resistensi obat, pemeriksaan untuk infeksi lain yang menyertai (misalnya, hepatitis, sifilis). - Terapi: Inisiasi terapi antiretroviral (ART) sesegera	- Kasus baru dengan kondisi klinis kompleks: Misalnya, pasien dengan gejala berat pada fase akut atau sudah masuk fase AIDS. - Keputusan terapi: Jika memerlukan penyesuaian regimen ART berdasarkan hasil tes resistensi atau adanya kondisi penyerta (misalnya, penyakit hati, kehamilan).

Kondisi	Kondisi Klinis	Tanda Klinis (Red Flags)	Tatalaksana Awal	Kriteria Rujukan (Eksalasi)
	Bisa menyebabkan gejala mirip flu. - Pada fase laten, Bisa tidak menunjukkan gejala tapi virus tetap aktif dalam tubuh. - Pada fase AIDS, sistem kekebalan sangat lemah dan rentan terhadap Infeksi oportunistik dan kanker.	- Fase AIDS: Demam berulang, diare kronis, pembengkakan kelenjar getah bening yang terus-menerus, infeksi jamur pada mulut (sariawan), herpes zoster, pneumonia infeksius, infeksi oportunistik lainnya (misalnya, tuberkulosis, pneumonia akibat Pneumocystis jirovecii), kanker (misalnya, limfoma, kaposi sarcoma).	mungkin setelah diagnosis. Regimen ART biasanya kombinasi beberapa obat antiretroviral (misalnya, bictegravir/tenofovir alafenamide/emtricitabine, dolutegravir dengan tenofovir atau lamivudine). - Pencegahan infeksi oportunistik: Berdasarkan hitung sel CD4 dan kondisi klinis pasien. - Edukasi: Tentang kepatuhan minum obat, pencegahan penularan, gaya hidup sehat, dan pentingnya pemeriksaan rutin. - Dukungan psikologis: Bantu pasien mengatasi tantangan yang terkait dengan diagnosis HIV.	- Kondisi penyerta serius: Seperti infeksi oportunistik yang berat, kanker, atau penyakit lain yang memerlukan perawatan khusus. - Masalah kepatuhan: Pasien yang kesulitan mengikuti jadwal minum obat atau mengalami efek samping obat yang tidak dapat diatasi di fasilitas primer. - Kebutuhan dukungan khusus: Seperti pasien anak-anak, wanita hamil, atau pasien dengan masalah psikologis yang kompleks. - Kasus yang memerlukan pemantauan lanjutan: Misalnya, pasien dengan muatan virus yang tidak terkontrol atau penurunan sel CD4 yang signifikan meskipun sudah menjalani ART.

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab: Infeksi Menular Seksual dan HIV pada Remaja: Skrining Risiko, Edukasi, Rujukan

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian IMS dan HIV	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa melakukan skrining risiko dalam mengidentifikasi kelompok remaja berisiko tinggi terhadap IMS dan HIV	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan asesmen perilaku seksual dengan cara yang sensitive, konfidensial, dan sesuai usia serta tahapan perkembangan remaja	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menggunakan alat bantu skrining Risiko sesuai untuk mengidentifikasi faktor Risiko IMS dan HIV	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mentukan jadwal, menjelaskan tujuan dan prosedur dan menggunakan tes skrining yang tersedia dengan valid untuk kasus IMS dan HIV	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa memberikan informasi yang akurat, jelas dan sesuai usi tentang IMS dan HIV termasuk cara penularan, gejala, komplikasi dan cara pencegahan (seperti menggunakan kondom)	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menjelaskan tentang hubungan seksual yang sehat dan memberikan informasi tentang vaksin yang tersedia untuk mencegah beberapa jenis IMS	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menangani kekhawatiran dan mitos yang mungkin dimiliki remaja tentang IMS dan HIV dengan cara yang tepat dan mendukung.	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
9	Saya sudah bisa mengidentifikasi kasus yang memerlukan rujukan ketenaga kesehatan spesialis untuk evaluasi dan pengobatan lebih lanjut pada kasus IMS dan HIV	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menjelaskan informasi yang jelas tentang tempat dan cara merujuk remaja ke fasilitas atau tenaga kesehatan yang sesuai kebutuhannya.	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa mengkoordinasikan dengan tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam perawatan remaja untuk memastikan kelancaran proses rujukan,	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa memberikan informasi tentang layanan dukungan yang tersedia bagi remaja yang terdiagnosa menderita IMS ataupun HIV (dukungan konseling psikologi, layanan sosial)	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa menjelaskan pentingnya mengikuti saran rujukan dan melakukan kunjungan ulang atau tindak lanjut yang diperlukan remaja dan orang tua ataupun wali	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa memastikan bahwa rujukan dilakukan dengan cara yang menghormati privasi dan kerahasiaan remaja	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa mencatat kasus yang dirujuk untuk memastikan bahwa remaja menerima perawatan yang tepat dan diperlukan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

H. Rangkuman Materi

Infeksi menular seksual (IMS) adalah kelompok penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, oral, atau anal pada pasangan berbeda maupun sesame jenis dan bisa juga ditularkan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui, dan melalui transfusi darah atau penggunaan jarum yang terkontaminasi dengan bakteri, virus, protozoa, parasit, atau jamur. Gejala IMS meliputi keluarnya cairan tidak normal dari alat kelamin, luka atau benjolan di area genital, sakit atau terbakar saat buang air kecil, gatal atau kemerahan di area genital, sakit perut bagian bawah.

Human Immunodeficiency Virus (HIV) **merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya sel darah putih bernama sel CD4, yang berperan penting dalam melawan infeksi dan penyakit. Tanpa pengobatan, HIV dapat berkembang menjadi *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS), tahap paling lanjut dari infeksi HIV. Gejala bervariasi tergantung tahap infeksi, sistem kekebalan melemah dan dapat menyebabkan gejala seperti pembengkakan kelenjar getah bening, penurunan berat badan, diare, batuk, serta penyakit serius seperti tuberkulosis, meningitis kriptokokus, dan kanker.**

Skrining risiko penting dilakukan secara rutin pada remaja aktif secara seksual atau berisiko tinggi, menggunakan metode yang sensitif dan konfidensial. Tes yang tersedia meliputi tes cepat HIV, tes urine untuk klamidia dan gonore, serta tes darah untuk sifilis dan hepatitis. **Edukasi** dengan memberikan informasi akurat tentang penularan, gejala, komplikasi, dan pencegahan, termasuk penggunaan kondom yang benar, manfaat vaksinasi (HPV, hepatitis B), dan pentingnya hubungan seksual yang sehat dan konsensual.

Rujukan pada remaja dengan HIV perlu segera mendapatkan ART yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kasus yang kompleks atau memerlukan perawatan khusus harus dirujuk ke tenaga kesehatan spesialis. Selain itu, perlu adanya dukungan psikologis dan sosial untuk membantu remaja mengelola kondisi mereka.

Alur asuhan singkat

Remaja dengan perilaku seksual berisiko → **skrining risiko** →identifikasi pada kelompok risiko (pekerja seks, pengguna NAPZA suntik, laki-laki seks dengan laki-laki, melakukan hubungan seks diluar nikah atau memiliki pasangan seks lebih dari satu) → Assesmen sensitive → menggunakan alat bantu kuesioner (faktor risiko) → pemeriksaan dan tes skrining (tes cepat HIV, tes urine) → pemeriksaan visual (luka genital, ruam) → pemberitahuan hasil → **edukasi** tentang IMS dan HIV (informasi dasar, pencegahan, hak dan tanggung jawab, mitos dan kekhawatiran,

berikan brosur leaflet ataupun tautan situs web terpercaya untuk referensi tentang IMS dan HIV) → **Rujukan** → kriteria rujukan (Kasus dengan hasil positif IMS/HIV, remaja dengan komplikasi akibat IMS/HIV, kasus yang mememrlukan tes atau perawatan yang tidak tersedia di fasilitas primer dan remaja dengan korban eksploitasi seksual) → proses rujukan → Dukungan lanjutan terkait dengan konseling dan layanan sosial.

I. Daftar Pustaka

Aguirrebengoa, O.A. *et al.* (2023) 'Risk factors associated with sexually transmitted infections and HIV among adolescents in a reference clinic in Madrid', *PLoS ONE*, 11(3), p. 1. Available at: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228998.

Agung, A. *et al.* (2024) 'Edukasi Mengenai Infeksi Menular Seksual Pada Remaja Awal di SMPK Kusuma Mataram', *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Original*, 7(3), pp. 923–927.

Gamelia, E. *et al.* (2023) 'Systematic review: risk sexual behavior, sexually transmitted infections, and adolescent pregnancy prevention interventions', *Journal of Public Health in Africa (JPHIA)*, 1(14), p. 12. Available at: https://doi.org/10.4081/jphia.2023.2672.

Manumara, T.M. *et al.* (2025) 'Cerdas seksual , cegah HIV : Edukasi penyakit HIV / AIDS pada Kalangan Remaja Sebagai Salah Satu Kelompok Berisiko di SMAN 1 Banjaran', *Jurnal Medika: Medika*, 4(4), pp. 1671–1678.

Mariani, A., Devi, R. and Abdullah, A. (2023) 'Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immunodeficiency Syndrom (AIDS)', *Jurnal Keperawan Profesional*, 4(2), pp. 151–157.

Melo, L.D. de *et al.* (2022) 'Prevention of sexually transmitted infections among young people and the importance of health education', *Mi SciELO*, 21. Available at: https://doi.org/https://dx.doi.org/10.6018/eglobal.481541.

Menkes RI (2022) 'Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunno Deficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual'. Jakarta: Kemenkes RI.

Nationwide Childrens (2025) 'Screening Adolescents for Sexually Transmitted Infections'. America (USA): NationwideChildrens.org/Lab, p. 1.

Nela, F.V. *et al.* (2023) 'Skrining infeksi menular seksual dan diagnostik tes sifilis dan hiv pada pekerja seks komersial di kabupaten kediri', *Jurnal Sintesis*, 4(2), pp. 146–152.

Rini, S.P. (2025) 'Scoping Review HIV pada Remaja di Indonesia', *Jurnal Medika Nusantara*, 3(1), p. 3. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.59680/medika.v3i1.1702.

Sugianto, R. *et al.* (2025) *Skrining, Diagnosis, dan Tatalaksana Infeksi Menular Seksual pada Kehamilan*. 1st edn. Semarang: RSUP Dr. Kariadi.

Whiskerz (2024) 'Konsep ilustrasi Hari AIDS Sedunia'. Jakarta: IStock, p. 1. Available at: https://www.istockphoto.com/id/vektor/konsep-ilustrasi-hari-aids-sedunia-template-vektor-vektor-datar-dokter-medis-dengan-gm1896241528-

554112844?searchscope=image%2Cfilm.

World Health Organization (2025) 'Guidelines for the management of asymptomatic sexually transmitted infections Guidelines for the management of asymptomatic sexually transmitted infections', in *Web Annex*. Switzerland: WHO, p. 1. Available at: www.who.int.

BAB 2

KESEHATAN MENTAL REMAJA TERKAIT REPRODUKSI: STRES, CITRA TUBUH, DAN PERILAKU BERISIKO

Capaian Pembelajaran:

CPL 2

Menerapkan komunikasi terapeutik dan konseling ramah remaja yang berpusat pada klien, sensitif budaya, dan menjaga kerahasiaan.

CPL 4

Melakukan pengkajian, analisis masalah, dan perencanaan intervensi promotif–preventif pada isu kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi berbasis evidence.

CPL 5

Merancang dan melaksanakan edukasi kesehatan serta pemberdayaan individu/keluarga/komunitas untuk pencegahan masalah reproduksi dan stunting antar generasi.

CPL 6

Mengelola dokumentasi, pencatatan–pelaporan, jejaring layanan, dan refleksi perbaikan mutu dalam layanan remaja dan prakonsepsi.

CPMK

CPMK 5: Merancang intervensi promotif–preventif terkait kesehatan mental untuk pencegahan masalah reproduksi dan stunting antar generasi.

Sub CPMK

Menganalisis keterkaitan stres, citra tubuh, dan perilaku berisiko dengan kesehatan reproduksi remaja.

5.1 Menganalisis keterkaitan stres, citra tubuh, dan perilaku berisiko dengan kesehatan reproduksi remaja.

5.2 Merancang dukungan awal dan rujukan untuk masalah kesehatan mental terkait reproduksi berbasis faktor risiko/protektif.

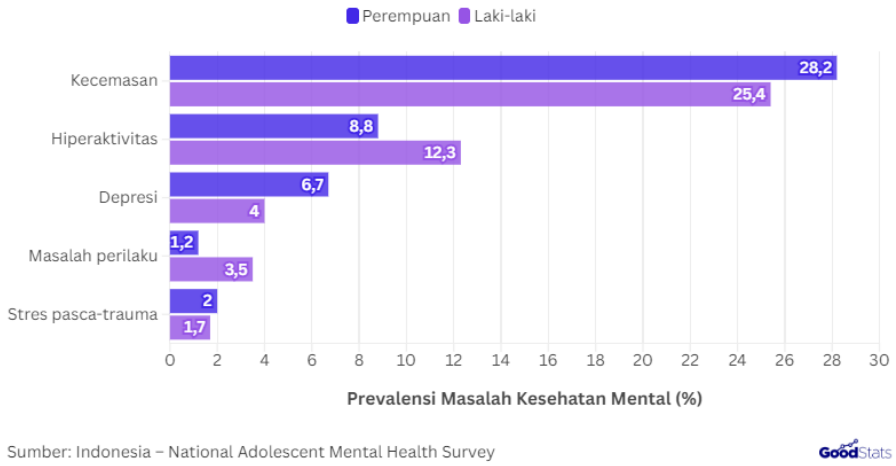
Uraian Materi

A. Stres Pada Remaja dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi

Masa remaja merupakan periode transisi dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan. Pada fase ini, remaja menghadapi berbagai tuntutan perkembangan seperti pencarian identitas diri, penyesuaian terhadap perubahan fisik, serta tekanan akademik dan sosial, sehingga menjadikan remaja sebagai kelompok yang rentan mengalami stres (Laurence Steinberg, 2022).

Stres pada remaja merupakan respons fisiologis dan psikologis terhadap tekanan yang dirasakan melebihi kemampuan individu dalam mengatasinya. Sumber stres dapat berasal dari berbagai aspek, seperti konflik keluarga, tekanan teman sebaya, tuntutan akademik, serta pengaruh media sosial. Jika tidak dikelola dengan baik, stres dapat berkembang menjadi gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan masalah perilaku (George M. Slavich, 2020).

Di Indonesia, prevalensi masalah kesehatan mental remaja menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hasil Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) melaporkan bahwa sekitar 34,9% remaja atau setara dengan 15,5 juta remaja mengalami masalah kesehatan mental, dan sekitar 5,5% mengalami gangguan mental dalam 12 bulan terakhir (Pusat Kesehatan Reproduksi Universitas Gadjah Mada, 2022).



Gambar 1.1: Prevalensi Kesehatan Mental pada Remaja di Indonesia

Kecemasan merupakan masalah kesehatan mental paling banyak dialami remaja di Indonesia, dengan prevalensi lebih tinggi pada perempuan (28,2%) dibanding laki-laki (25,4%). Sebaliknya, gangguan hiperaktivitas atau pemusatan perhatian lebih banyak dialami laki-laki (12,3%) dibanding perempuan (8,8%).

Depresi juga ditemukan lebih tinggi pada remaja perempuan (6,7%) dibanding laki-laki (4,0%).

Selain itu, masalah perilaku lebih sering terjadi pada laki-laki (3,5%) dibanding perempuan (1,2%), sedangkan stres pascatrauma sedikit lebih tinggi pada perempuan (2,0%) dibanding laki-laki (1,7%). Survei I-NAMHS juga menunjukkan bahwa sebagian besar remaja mengalami masalah dalam hubungan sosial, terutama dengan keluarga (64,7%), diikuti teman sebaya (41,1%), sekolah atau pekerjaan (39,3%), serta distres personal (27,2%).

Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa kesehatan mental remaja merupakan isu yang penting dan perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kesehatan remaja menjadi sangat krusial sebagai upaya preventif dan promotif untuk mendukung perkembangan yang optimal serta mencegah dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan sosial di masa depan.

1. Konsep Stres pada Remaja

a. Definisi Stres

Stres merupakan respons fisiologis dan psikologis individu terhadap tuntutan yang dipersepsikan melebihi kapasitas adaptasinya. Pada masa remaja, stres sering muncul sebagai akibat dari interaksi kompleks antara perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang sedang berlangsung. Secara umum, stres juga dipahami sebagai respons tubuh yang bersifat nonspesifik terhadap berbagai tekanan hidup, yang ditandai dengan munculnya gejala somatik (fisik) serta keluhan psikologis (Hawari, 2016).

Lebih lanjut, stres dapat dipandang sebagai suatu sindrom yang melibatkan perubahan dalam berbagai sistem biologis tubuh yang tidak selalu spesifik (Townsend, 2015). Kondisi ini dapat dipicu oleh peristiwa yang mengancam keseimbangan fisik, mental, maupun spiritual, sehingga menimbulkan serangkaian respons adaptif baik secara psikologis maupun fisiologis (Murharyati et al., 2021).

Menurut teori stres transaksional, stres terjadi sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya, khususnya ketika situasi tersebut dinilai sebagai ancaman atau melebihi kemampuan coping yang dimiliki. Dalam prosesnya, respons stres melibatkan sistem neuroendokrin, terutama aktivasi sumbu hipotalamus–hipofisis–adrenal (*Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis*), yang berperan dalam regulasi hormon stres (Guyton & Hall, 2021).

b. Mekanisme Stres

Stres terjadi ketika individu merasakan adanya tekanan yang tidak mampu diatasi secara efektif (Musradinur, 2016). Kondisi ini dipengaruhi oleh kerja sistem saraf yang merespons berbagai stresor, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun luar (eksternal) individu. Stresor tersebut akan mengaktifkan sistem hormonal dan kelenjar tubuh, khususnya yang berpusat di otak.

Aktivasi ini memicu kerja sistem saraf simpatik yang menyebabkan berbagai perubahan fisiologis, seperti peningkatan denyut jantung, penurunan nafsu makan, serta peningkatan produksi keringat. Respons ini merupakan bagian dari mekanisme adaptasi tubuh dalam menghadapi tekanan atau ancaman (Mahmud & Uyun, 2016).

c. Sumber Stres pada Remaja

Remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap stres karena berada pada fase transisi perkembangan. Sumber stres meliputi: perubahan hormonal saat pubertas, tekanan akademik, hubungan sosial dan tekanan teman sebaya, konflik keluarga dan paparan media social.

Penelitian menunjukkan bahwa stres akademik memiliki hubungan signifikan dengan gangguan kesehatan pada remaja (Indriyani, 2023).

2. Jenis-jenis stress

Masa remaja merupakan periode perkembangan yang ditandai oleh perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan. Perubahan tersebut menjadikan remaja lebih rentan mengalami stres, baik yang bersifat adaptif maupun maladaptif. Stres pada remaja tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki berbagai bentuk dan karakteristik yang berbeda, tergantung pada sumber, durasi, serta respons individu terhadap stresor. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jenis-jenis stres pada remaja menjadi penting sebagai dasar dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan, khususnya kesehatan mental dan reproduksi.

a. Stres Berdasarkan Sifat (Valensi Stres)

1) Eustress (Stres Positif)

Eustress merupakan stres yang bersifat adaptif dan memberikan dampak positif terhadap individu. Stres ini mendorong motivasi, meningkatkan fokus, serta membantu individu mencapai performa optimal. Eustres adalah bentuk stres yang memberikan dampak positif, memotivasi, dan meningkatkan performa remaja. Eustress merupakan bentuk stres yang bersifat adaptif dan memberikan dampak positif bagi individu. Kondisi ini dapat meningkatkan motivasi, memperbaiki fokus,

serta membantu individu mencapai performa optimal. Pada remaja, eustress muncul ketika tuntutan dipersepsikan sebagai tantangan yang dapat diatasi dan mendukung perkembangan diri (O'Sullivan, 2021)

Karakteristik eustress: bersifat jangka pendek, memberikan energi dan semangat, meningkatkan kemampuan problem solving, tidak menimbulkan gangguan kesehatan

Contoh: persiapan ujian dengan motivasi belajar, presentasi penting dan kompetisi akademik.

Eustress berperan dalam meningkatkan performa hingga mencapai tingkat optimal, sebagaimana dijelaskan dalam hukum Hukum Yerkes-Dodson, yang menunjukkan adanya hubungan berbentuk kurva antara tingkat stres dan kinerja individu (Teigen, 2021)

2) Distress (Stres Negatif)

Distress adalah stres yang bersifat maladaptif karena melebihi kemampuan coping individu. Distress dapat menyebabkan gangguan fisik, emosional, dan perilaku.

Distres terjadi ketika stresor dianggap mengancam dan berada di luar kendali remaja, yang jika dibiarkan dapat memicu gangguan kecemasan atau depresi (Santrock, 2019).

a) Stres Akut: Muncul secara tiba-tiba dan hilang dengan cepat, seperti saat menghadapi ujian lisan.
b) Stres Kronis: Tekanan yang berlangsung lama dan terus-menerus, seperti tinggal di lingkungan keluarga yang penuh konflik atau kemiskinan

Karakteristik distress: Bersifat berkepanjangan, menurunkan fungsi tubuh dan mental, menimbulkan kecemasan, depresi, mengganggu aktivitas sehari-hari

Dampak fisiologis: peningkatan kortisol kronis, gangguan sistem imun, ketidakseimbangan hormon

b. Stres Berdasarkan Durasi

1) Stres Akut

Stres akut adalah bentuk stres jangka pendek yang muncul akibat tekanan atau situasi tertentu dan bersifat sementara.

Karakteristik: durasi singkat, respon cepat, tidak menyebabkan kerusakan jangka panjang

Respon tubuh dapat berupa peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah, aktivasi sistem "fight or flight"

Stres akut umumnya tidak berbahaya dan dapat membantu individu merespon situasi darurat (American Psychological Association, 2020).

2) Stres Kronis

Stres kronis adalah stres yang berlangsung lama dan terus-menerus tanpa penyelesaian.

Karakteristik: Berkepanjangan, sulit diatasi, menyebabkan kelelahan fisik dan mental

Dampak: gangguan hormon (kortisol tinggi), gangguan reproduksi , penyakit kronis (hipertensi, depresi)

Stres kronis berkaitan dengan konsep *allostatic load*, yaitu akumulasi beban biologis akibat paparan stres yang berlangsung lama dan berulang, yang dapat berdampak pada gangguan fungsi fisiologis tubuh (Guidi et al., 2021).

c. Stres Berdasarkan Sumber (Stressor)

1) Stres Fisiologis

Stres yang berasal dari kondisi fisik atau biologis tubuh.

Sumber stress antara lain penyakit, kurang tidur, perubahan hormonal, kelelahan. Dalam hal ini mengalami mekanisme: stres fisiologis memengaruhi sistem endokrin dan metabolisme tubuh (Guyton & Hall, 2021).

2) Stres Psikologis

Stres yang muncul akibat persepsi individu terhadap situasi tertentu.

Biasanya disebabkan kecemasan, ketakutan, konflik internal dan tekanan emosional

Menurut teori *appraisal*, individu mengevaluasi suatu situasi untuk menentukan apakah kondisi tersebut merupakan ancaman atau justru tantangan, yang kemudian memengaruhi respons stres yang muncul (Richard S. Lazarus, 2020)

3) Stres Sosial

Stres akibat interaksi sosial dan lingkungan yang dapat bersumber dari adanya konflik keluarga, tekanan teman sebaya, bullying dan masalah ekonomi.

Stres sosial berperan besar pada remaja karena tingginya kebutuhan akan penerimaan sosial serta sensitivitas terhadap evaluasi dari lingkungan. Faktor seperti tekanan teman sebaya dan bullying terbukti berhubungan dengan peningkatan stres dan gangguan kesehatan mental pada remaja (Karen M. King et al., 2022).

4) Stres Lingkungan

Stres yang berasal dari kondisi lingkungan fisik contoh: kebisingan, polusi, kepadatan lingkungan, perubahan iklim. Lingkungan yang tidak kondusif dapat meningkatkan respons stres tubuh secara kronis.

d. Stres Berdasarkan Respons Tubuh (General Adaptation Syndrome/GAS)

Teori General Adaptation Syndrome (GAS) oleh Selye menjelaskan respons tubuh terhadap stres dalam tiga tahap:

1) Tahap Alarm
   a) Respon awal terhadap stresor
   b) Aktivasi sistem saraf simpatik
   c) Pelepasan adrenalin dan kortisol

   Gejala: jantung berdebar, napas cepat dan tegang
2) Tahap Resistance
   a) Tubuh beradaptasi terhadap stres
   b) Fungsi tubuh tetap berjalan tetapi dalam tekanan

   Ciri: energi masih tersedia dan individu tampak "baik-baik saja"
3) Tahap Exhaustion
   a) Terjadi jika stres berlangsung lama
   b) Energi tubuh habis

   Dampak: penurunan imun, gangguan hormonal, risiko penyakit meningkat. Tahap ini mencerminkan dampak serius dari stres kronis terhadap kesehatan fisik dan psikologis (Bruce S. McEwen, 2020).

3. Tingkatan Stress

Tingkatan stres menggambarkan derajat intensitas stres yang dialami individu, mulai dari kondisi ringan hingga berat, yang memengaruhi fungsi fisik, psikologis, dan perilaku. Tingkatan ini sangat dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap stresor serta kemampuan coping yang dimiliki (American Psychological Association, 2023).

Dalam pendekatan kesehatan, tingkat stres penting untuk diidentifikasi karena berkaitan langsung dengan risiko gangguan kesehatan, termasuk kesehatan mental dan reproduksi (McEwen & Akil, 2020).

a. Stres Ringan (Mild Stress)

Stres ringan merupakan kondisi stres dengan intensitas rendah yang masih dalam batas adaptif dan tidak mengganggu fungsi sehari-hari.

Memiliki karakteristik bersifat sementara, tidak mengganggu aktivitas, individu masih mampu mengontrol emosi, dapat meningkatkan motivasi

Respon Fisiologis: sedikit peningkatan denyut jantung dan kewaspadaan meningkat. Stres ringan seringkali bersifat adaptif dan dapat meningkatkan performa individu.

b. Stres Sedang (Moderate Stress)

Stres sedang terjadi ketika tekanan mulai meningkat dan mulai memengaruhi fungsi kognitif dan emosional.

Memiliki karakteristik: mulai mengganggu konsentrasi, muncul kecemasan ringan hingga sedang dan penurunan performa.

Stres tingkat sedang ditandai dengan kelelahan, gangguan tidur, dan iritabilitas sebagai respons psikofisiologis terhadap tekanan. Berbagai studi menunjukkan bahwa kondisi ini berhubungan dengan penurunan kualitas tidur dan peningkatan distress psikologis, yang berpotensi berkembang menjadi stres berat apabila tidak dikelola secara adekuat (Andiani et al., 2024)

c. Stres Berat (Severe Stress)

Stres berat merupakan kondisi ketika individu tidak mampu lagi mengatasi tekanan yang dialami, sehingga mengganggu fungsi sehari-hari. Karakteristik: mengganggu aktivitas harian, emosi tidak stabil, perasaan putus asa.

Gejala: gangguan tidur berat, penurunan nafsu makan atau berlebihan, gejala psikosomatis, risiko depresi.

Stres berat berhubungan dengan peningkatan risiko gangguan kesehatan mental dan fisik (McEwen & Akil, 2020).

d. Stres Sangat Berat (Extreme Stress / Distress Berat)

Pada tingkat ini, stres dapat menyebabkan gangguan serius pada fungsi psikologis dan fisiologis.

Adapun karakteristiknya ketidakmampuan menjalankan aktivitas normal, gangguan mental serius dan risiko perilaku berbahaya.

Dampak: depresi berat, gangguan kecemasan berat, risiko bunuh diri.

Paparan stres ekstrem yang berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan sistem neurobiologis (*toxic stress*) (McEwen & Akil, 2020).

4. Perspektif Neuroendokrin Stres

Stres merupakan respons kompleks yang melibatkan interaksi antara sistem saraf dan sistem endokrin. Secara utama, respons stres diatur oleh dua sistem besar, yaitu HPA axis (Hypothalamic – Pituitary –Adrenal axis) dan sistem saraf simpatik (Sympathetic – Adreno - Medullary system/SAM).

a. HPA Axis (Hypothalamic – Pituitary – Adrenal Axis)

HPA axis merupakan jalur utama dalam respons stres jangka panjang.

CRH → ACTH → KortisolCRH\rightarrow ACTH\rightarrow KortisolCRH → ACTH → Kortisol

Mekanisme:

1) Stresor merangsang hipotalamus → melepaskan CRH (Corticotropin-Releasing Hormone)
2) CRH menstimulasi hipofisis anterior → menghasilkan ACTH (Adrenocorticotropic Hormone)
3) ACTH merangsang korteks adrenal → menghasilkan kortisol

Adapun fungsi kortisol antara lain: meningkatkan glukosa darah (energi cepat), mengatur metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat dan menekan respons inflamasi.

Jika berlangsung kronis: terjadi hiperkortisolisme, gangguan regulasi hormon tubuh dan disrupsi ritme sirkadian.

Kortisol kronis terbukti mengganggu keseimbangan hormon tubuh dan meningkatkan risiko penyakit metabolik serta gangguan reproduksi (Russell & Lightman, 2019).

b. Sistem Saraf Simpatik (SAM System)

Sistem ini berperan dalam respons stres akut (fight or flight).

Mekanisme:

1) Aktivasi hipotalamus → sistem saraf simpatik
2) Stimulasi medula adrenal → pelepasan adrenalin (epinefrin) dan noradrenalin

Terdapat efek fisiologis antara lain peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah, dilatasi bronkus, peningkatan kewaspadaan.

Sistem ini penting untuk respons cepat, tetapi jika aktif terus-menerus dapat menyebabkan kelelahan fisiologis dan gangguan sistem tubuh.

5. Dampak Aktivasi Stres Berkepanjangan

Jika kedua sistem ini aktif secara terus-menerus (stres kronis), maka akan terjadi:

a. Ketidakseimbangan hormone menyebabkan : gangguan regulasi HPA axis, penurunan sensitivitas reseptor hormon, disrupsi hormon lain (tiroid, insulin, hormon seks).
b. Gangguan sistem reproduksi, seperti: kortisol menghambat pelepasan GnRH (Gonadotropin - Releasing Hormone), penurunan LH dan FSH, gangguan siklus menstruasi (amenore, oligomenore), penurunan kesuburan.

Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara stres kronis dan disfungsi reproduksi (Bruce S. McEwen, 2020).

c. Penurunan fungsi imun: kortisol bersifat imunosupresif, penurunan produksi sel imun (limfosit), peningkatan kerentanan terhadap infeksi
   Stres kronis berkontribusi terhadap penurunan daya tahan tubuh dan peningkatan risiko penyakit kronis (Slavich, 2020).

6. Mekanisme Biologis Stres terhadap Sistem Reproduksi

Stres memicu respons biologis melalui sistem neuroendokrin, terutama melalui aktivasi sumbu hipotalamus–hipofisis–adrenal (HPA axis). Aktivasi ini berperan penting dalam mempertahankan homeostasis tubuh, namun jika berlangsung kronis dapat mengganggu sistem lain, termasuk sistem reproduksi (McEwen & Akil, 2020).

Sistem reproduksi sendiri dikendalikan oleh sumbu hipotalamus–hipofisis–gonad (HPO axis), sehingga terdapat interaksi erat antara sistem stres dan sistem reproduksi (Guyton & Hall, 2021).

Stres kronis akan memengaruhi sistem reproduksi melalui gangguan pada HPO axis:

a. Penekanan GnRH
   Kortisol tinggi menghambat pelepasan GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone) dari hipotalamus.
b. Penurunan FSH dan LH
   Penurunan GnRH menyebabkan penurunan FSH (Follicle Stimulating Hormone) dan penurunan LH (Luteinizing Hormone).
c. Gangguan Hormon Reproduksi
   Akibatnya: produksi estrogen dan progesteron terganggu dan ovulasi tidak terjadi optimal
d. Dampak akhir yang dapat ditimbulkan antara lain siklus menstruasi tidak teratur, amenore / oligomenore dan angguan fertilitas. (Guyton & Hall, 2021)



Gambar 2.2: Mekanisme Biologis Stres

7. Dampak Stres terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja

a. Gangguan Siklus Menstruasi

Stres berhubungan dengan berbagai gangguan menstruasi seperti: Amenore, Oligomenore, Dismenore, Siklus tidak teratur

Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara tingkat stres dengan gangguan siklus menstruasi pada remaja (Seran, 2024).

b. Sindrom Pramenstruasi (PMS)

Stres dapat memperberat gejala PMS baik secara fisik maupun emosional. Remaja dengan tingkat stres tinggi cenderung mengalami PMS yang lebih berat (Maulidya, 2024).

c. Gangguan Ovulasi dan Fertilitas

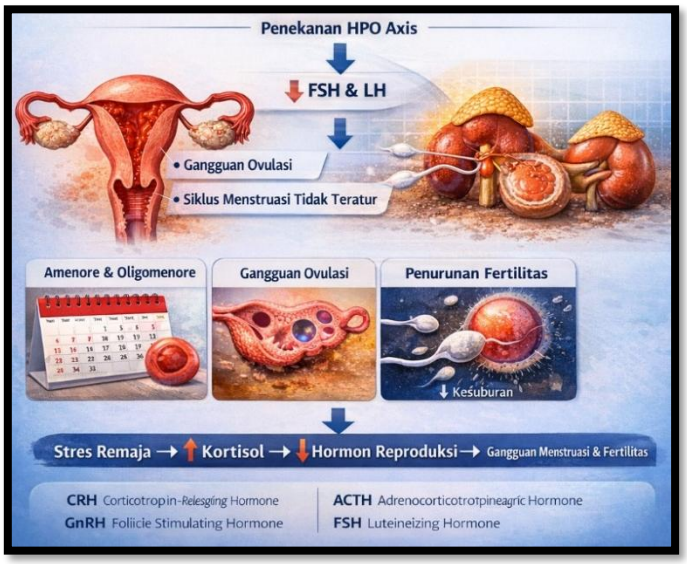
Stres kronis dapat menghambat ovulasi dan menurunkan kesuburan akibat ketidakseimbangan hormon reproduksi. Kondisi ini juga dapat menyebabkan amenore hipotalamik (Guyton & Hall, 2021).

d. Dampak Psikoseksual

Stres juga berdampak pada aspek psikoseksual remaja, seperti: penurunan libido, perilaku seksual berisiko, pengambilan keputusan yang tidak sehat terkait reproduksi

e. Dampak Jangka Panjang

Jika tidak ditangani, stres dapat menyebabkan: gangguan reproduksi kronis, risiko infertilitas, gangguan mental seperti depresi dan kecemasan (WHO, 2023)



Gambar 2.3: Dampak Stress pada Sistem Reproduksi

8. Interaksi Stres dengan Faktor Lain

Stres tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan berbagai faktor lain seperti: status gizi, aktivitas fisik, pola tidur, dukungan sosial. Kombinasi faktor tersebut dapat memperburuk gangguan menstruasi pada remaja (Maedy, 2022).

9. Upaya Penanganan dan Pencegahan

Upaya penanganan dan pencegahan stres pada remaja perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan individu, keluarga, dan tenaga kesehatan. Penanganan yang tepat dapat membantu remaja mengelola emosi, meningkatkan kemampuan adaptasi, serta mencegah dampak negatif terhadap kesehatan mental dan reproduksi.

a. Intervensi Individu

Pada tingkat individu, remaja perlu dibantu untuk mengenali dan mengelola stres dengan baik. Manajemen stres dapat dilakukan melalui teknik relaksasi, *mindfulness*, olahraga, serta kegiatan positif yang membantu menenangkan pikiran. Selain itu, penerapan pola hidup sehat seperti tidur cukup, konsumsi gizi seimbang, dan aktivitas fisik teratur juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental remaja. Edukasi kesehatan reproduksi turut diperlukan agar remaja memiliki pemahaman yang benar dalam menghadapi perubahan fisik dan emosional selama masa pubertas.

b. **Intervensi Keluarga**

Keluarga memiliki peran penting dalam membantu remaja menghadapi stres. Dukungan emosional dari orang tua dapat membuat remaja merasa dihargai, aman, dan tidak sendirian dalam menghadapi masalahnya. Selain itu, komunikasi yang terbuka antara orang tua dan remaja membantu menciptakan hubungan yang lebih dekat sehingga remaja lebih mudah menyampaikan keluhan atau tekanan yang dialami.

c. **Intervensi Tenaga Kesehatan**

Tenaga kesehatan, khususnya bidan, berperan dalam melakukan *screening* kesehatan mental untuk mendeteksi dini masalah psikologis pada remaja. Selain itu, tenaga kesehatan memberikan konseling remaja dan edukasi berbasis *evidence* mengenai kesehatan mental, kesehatan reproduksi, serta cara menghadapi stres secara sehat. Pendekatan yang ramah remaja dan suportif dapat membantu remaja lebih percaya diri dalam menjaga kesehatan mentalnya.

B. Citra Tubuh *(Body Image)* Pada Remaja

1. Konsep dan Definisi Citra Tubuh

Citra tubuh (*body image*) adalah persepsi, pikiran, dan perasaan individu terhadap bentuk, ukuran, dan penampilan tubuhnya. Konsep ini bersifat multidimensional karena mencakup aspek persepsi, sikap, dan perilaku terhadap tubuh (Ganesan et al., 2018).

Selain itu, citra tubuh juga didefinisikan sebagai representasi mental individu tentang tubuhnya yang dipengaruhi oleh pengalaman subjektif dan penilaian sosial (Zanlorenci et al., 2022).

Model modern menjelaskan bahwa citra tubuh terdiri dari tiga komponen utama:

a. Persepsi (bagaimana individu melihat tubuhnya)
b. Sikap/afeksi (perasaan terhadap tubuh)
c. Perilaku (tindakan terkait tubuh, seperti diet atau olahraga).

2. Perkembangan Citra Tubuh pada Remaja

Masa remaja merupakan periode penting dalam kehidupan seseorang, di mana individu mulai mengenal, menilai, dan membentuk persepsi terhadap dirinya sendiri—termasuk bagaimana ia memandang tubuhnya. Citra tubuh (body image) adalah gambaran mental, perasaan, serta sikap individu terhadap bentuk dan penampilan tubuhnya (Cash & Smolak, 2011).

Pada fase ini, perubahan fisik yang terjadi secara cepat akibat pubertas sering kali menjadi sumber perhatian utama. Remaja mulai membandingkan tubuhnya dengan standar ideal yang ada di lingkungan sekitar, baik dari teman sebaya, keluarga, maupun media sosial. Proses ini tidak selalu berjalan mulus, karena tidak semua remaja merasa nyaman dengan perubahan yang dialaminya. Masa remaja merupakan periode kritis dalam pembentukan citra tubuh karena adanya:

a. Perubahan fisik yang cepat (pubertas)
b. Perkembangan identitas diri
c. Peningkatan kesadaran terhadap penampilan

Remaja mulai membandingkan dirinya dengan standar sosial dan teman sebaya, sehingga rentan mengalami ketidakpuasan tubuh (Rodgers et al., 2023)

Penelitian menunjukkan bahwa perhatian terhadap citra tubuh meningkat signifikan pada usia 10–18 tahun, seiring dengan perubahan biologis dan sosial (Ferreira et al., 2023)

3. Faktor yang Mempengaruhi Citra Tubuh Remaja

a. Faktor Biologis: perubahan hormon pubertas, perubahan bentuk tubuh (berat badan, tinggi badan, perkembangan payudara). Perubahan ini seringkali menyebabkan ketidaksesuaian antara persepsi diri dan realitas tubuh.

b. Faktor Psikologis: meliputi harga diri (*self-esteem*), kepercayaan diri, dan kecenderungan melakukan perbandingan sosial. Remaja dengan citra tubuh negatif umumnya memiliki harga diri yang lebih rendah dan rentan terhadap masalah kesehatan mental (Helga Dittmar et al., 2020)

   Remaja dengan self-esteem rendah cenderung lebih kritis terhadap tubuhnya dan lebih mudah mengalami citra tubuh negatif (Griffiths et al., 2018). Artinya: bukan hanya "bagaimana tubuhnya", tapi "bagaimana ia menilai tubuhnya".

c. Faktor Sosial dan Lingkungan: mencakup tekanan teman sebaya, komentar dari keluarga, serta bullying terkait penampilan. Pengaruh yang sering terjadi dari keluarga:
   1) Komentar orang tua tentang berat badan atau penampilan
   2) Modeling (orang tua yang sering diet atau tidak puas dengan tubuhnya)
   3) Pola asuh (otoriter vs suportif)

d. Lingkungan sosial memiliki peran besar dalam membentuk persepsi tubuh remaja, terutama melalui interaksi langsung maupun media sosial (Amy Orben et al., 2020). Pada masa remaja, penerimaan sosial menjadi kebutuhan utama, hal itu menyebabkan remaja sering:
   1) Membandingkan tubuh dengan teman
   2) Mengalami tekanan untuk sesuai standar kelompok
   3) Terpapar ejekan atau bullying terkait fisik

   Tekanan dari teman sebaya terbukti meningkatkan risiko ketidakpuasan tubuh dan gangguan makan (Holland & Tiggemann, 2016).

e. Media dan Sosial Mediam

   Media massa dan sosial media: menampilkan standar kecantikan ideal (tubuh kurus, kulit putih, dll), Paparan konten tersebut memicu: *social comparison*, ketidakpuasan tubuh, body shame

   Paparan ini meningkatkan ketidakpuasan tubuh pada remaja secara global (Raut, 2025)

4. Bentuk Citra Tubuh

a. Citra Tubuh Positif

   Ditandai dengan: penerimaan diri, kepuasan terhadap tubuh, perilaku sehat. Citra tubuh positif berhubungan dengan kesehatan mental yang lebih baik (Ahuja et al., 2024)

b. Citra Tubuh Negatif

Ditandai dengan: ketidakpuasan terhadap tubuh, distorsi persepsi tubuh, Fokus berlebihan pada kekurangan fisik. Citra tubuh negatif sering terjadi akibat ketidaksesuaian antara tubuh nyata dan standar ideal (Ganesan et al., 2018).

5. Dampak Citra Tubuh terhadap Kesehatan Remaja

a. Dampak Psikologis: depresi, kecemasan, rendah diri. Citra tubuh negatif berhubungan kuat dengan gangguan mental dan kesejahteraan psikologis (Ahuja et al., 2024)
b. Gangguan Perilaku Makan: anoreksia nervosa, bulimia nervosa, diet ekstrem. Ketidakpuasan tubuh mendorong perilaku makan tidak sehat pada remaja (Ferreira et al., 2023)
c. Dampak terhadap Kesehatan Reproduksi
   Citra tubuh negatif dapat berdampak pada: gangguan hormonal akibat diet ekstrem, ketidakseimbangan nutrisi → gangguan menstruasi, ketidakpercayaan diri dalam kesehatan seksual. Selain itu, citra tubuh juga berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk kepercayaan diri dalam hubungan (Wilson et al., 2021)
d. Perilaku Berisiko pada remaja juga dapat dengan penggunaan produk tidak aman (pelangsing, pemutih), perilaku seksual berisiko untuk validasi diri, olahraga berlebihan.

6. Upaya Intervensi dan Pencegahan

a. Edukasi dan Literasi Media: mengkritisi standar kecantikan dan mengurangi perbandingan sosial
b. Pendekatan Psikologis: peningkatan self-esteem, konseling remaja, terapi kognitif perilaku
c. Dukungan Sosial: peran keluarga, lingkungan sekolah suportif, peer support
d. Promosi Body Positivity
   Pendekatan ini menekankan: penerimaan tubuh, fokus pada fungsi tubuh, bukan hanya penampilan

C. Perilaku Berisiko Pada Remaja

1. Konsep dan Definisi Perilaku Berisiko

Perilaku berisiko (*risk behavior*) adalah tindakan yang dapat membahayakan kesehatan fisik, mental, maupun sosial individu, termasuk kesehatan reproduksi. Pada remaja, perilaku ini sering muncul karena fase

perkembangan yang ditandai dengan eksplorasi diri dan kecenderungan mencoba hal baru.

Perilaku berisiko didefinisikan sebagai perilaku yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan individu (Soejarwo et al., 2025).

Selain itu, perilaku berisiko pada remaja merupakan tindakan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang akibat keterbatasan kontrol diri dan pengalaman (Indraswari, 2022).

2. Karakteristik Perilaku Berisiko pada Remaja

Masa remaja memiliki karakteristik khusus yang memicu munculnya perilaku berisiko, antara lain: rasa ingin tahu tinggi, pencarian identitas diri, emosi yang belum stabil, pengaruh kuat dari teman sebaya.

Remaja cenderung mengambil keputusan impulsif tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang (Indraswari, 2022).

3. Bentuk-Bentuk Perilaku Berisiko pada Remaja

a. Perilaku Seksual Berisiko

Perilaku seksual berisiko mencakup hubungan seksual di usia dini, berganti pasangan, dan tidak menggunakan kontrasepsi. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI, 2017) mencatat bahwa sekitar 2% remaja putri dan 8% remaja putra sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Risiko yang ditimbulkan antara lain kehamilan tidak direncanakan, IMS, dan HIV/AIDS (BKKBN, 2019). Perilaku seksual berisiko dapat menyebabkan kehamilan tidak diinginkan, aborsi, dan infeksi menular seksual (Ungsianik & Yuliati, 2017)

Bentuk-Bentuk Perilaku Seksual Berisiko

1) Seks Pranikah: hubungan seksual sebelum menikah yang berisiko menyebabkan kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual (IMS), dan gangguan psikologis.
2) Berganti-Ganti Pasangan Seksual: memiliki banyak pasangan seksual meningkatkan risiko penularan IMS seperti HIV/AIDS, sifilis, dan gonore (CDC, 2022).
3) Hubungan Seksual Tanpa Perlindungan: hubungan seksual tanpa penggunaan alat pelindung, seperti kondom, dapat menyebabkan kehamilan tidak direncanakan dan penularan penyakit seksual.

4) Sexting: perilaku mengirim pesan, foto, atau video seksual melalui media digital yang dapat berdampak pada cyberbullying dan eksploitasi seksual digital (Kosenko et al., 2017).
5) Konsumsi Pornografi: paparan pornografi dapat memengaruhi perilaku seksual remaja dan meningkatkan kecenderungan melakukan perilaku seksual berisiko (Peter & Valkenburg, 2016).

b. Penyalahgunaan Zat

1) Merokok

Merokok adalah perilaku menghisap produk tembakau yang mengandung nikotin dan zat berbahaya lainnya. Banyak remaja mulai merokok karena pengaruh teman sebaya, rasa penasaran, atau ingin dianggap dewasa.

Dampak Merokok pada Remaja: gangguan paru-paru dan jantung, penurunan daya tahan tubuh, ketergantungan nikotin, gangguan kesehatan reproduksi.

Pada remaja perempuan, merokok dapat memengaruhi keseimbangan hormon reproduksi dan siklus menstruasi (CDC, 2022). Merokok merupakan salah satu bentuk perilaku berisiko yang sering terjadi akibat pengaruh lingkungan sosial (Alfiani & Wulansari, 2023) .

2) Konsumsi alkohol

Alkohol merupakan zat adiktif yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan kesadaran seseorang. Remaja yang mengonsumsi alkohol cenderung memiliki kontrol diri yang lebih rendah.

Dampak Konsumsi Alkohol: gangguan fungsi otak dan konsentrasi, perilaku impulsif dan agresif, risiko kecelakaan dan kekerasan, gangguan kesehatan mental

Konsumsi alkohol pada usia remaja juga meningkatkan risiko perilaku seksual berisiko (WHO, 2021).

3) Penggunaan narkoba

Narkoba adalah zat yang dapat memengaruhi kerja otak dan menyebabkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba pada remaja sering dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dan stres psikologis.

Dampak Penggunaan Narkoba: kerusakan otak dan organ tubuh, gangguan emosi dan perilaku, ketergantungan, penurunan prestasi akademik, risiko gangguan kesehatan reproduksi, penggunaan narkoba jangka panjang dapat menyebabkan gangguan mental serius dan meningkatkan risiko kematian (UNODC, 2022).

c. Perilaku Sosial Negatif

1) Tawuran

Tawuran merupakan bentuk perilaku kekerasan kolektif yang melibatkan kelompok remaja atau pelajar yang saling menyerang secara fisik. Tawuran biasanya dipicu oleh konflik antarkelompok, solidaritas kelompok yang berlebihan, atau provokasi sosial. Menurut penelitian, tawuran pada remaja berkaitan erat dengan rendahnya kontrol diri, tekanan kelompok sebaya, dan lemahnya kemampuan penyelesaian konflik secara sehat (Fitriani & Hastuti, 2021)

Beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya tawuran pada remaja meliputi:

a) Faktor Keluarga: Kurangnya pengawasan orang tua, konflik keluarga, pola asuh keras atau permisif
b) Faktor Teman Sebaya dimana remaja sering terlibat tawuran karena: solidaritas kelompok dan tekanan untuk diterima dalam kelompok
c) Faktor Lingkungan Sosial: Lingkungan yang permisif terhadap kekerasan dan paparan media kekerasan
d) Faktor Psikologi: emosi tidak stabil, impulsivitas tinggi, kesulitan mengelola amarah.

Tawuran dapat menyebabkan: cedera fisik, trauma psikologis, gangguan hubungan sosial, penurunan prestasi akademik.

Dalam jangka panjang, perilaku kekerasan dapat meningkatkan risiko perilaku kriminal pada masa dewasa (WHO, 2020).

2) Bullying

Bullying adalah perilaku menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun digital, dengan adanya ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban (UNESCO, 2019).

Bullying menjadi salah satu masalah kesehatan mental terbesar pada remaja modern karena dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Bentuk-Bentuk Bullying

a) Bullying Fisik: memukul, menendang, mendorong
b) Bullying Verbal: mengejek, menghina, memberi julukan buruk
c) Bullying Sosial: mengucilkan, menyebarkan rumor
d) *Cyberbullying* - *Bullying* melalui media digital: komentar negatif, penyebaran foto/video memalukan, pelecehan di media sosial

Cyberbullying meningkat seiring tingginya penggunaan media sosial pada remaja (Keles et al., 2020). Faktor Penyebab *Bullying* dipengaruhi

oleh: rendahnya empati, pengaruh lingkungan sosial, pengalaman menjadi korban kekerasan, budaya senioritas. Selain itu, kebutuhan untuk merasa dominan dalam kelompok juga memicu perilaku *bullying*.

Faktor Penyebab Bullying: Rendahnya empati, pengaruh lingkungan sosial, pengalaman menjadi korban kekerasan, budaya senioritas

Selain itu, kebutuhan untuk merasa dominan dalam kelompok juga memicu perilaku bullying.

3) Perilaku agresif

Perilaku agresif adalah tindakan yang bertujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Agresi dapat muncul sebagai respons terhadap frustrasi, kemarahan, atau tekanan sosial.

Menurut Anderson dan Bushman (2018), agresivitas pada remaja dipengaruhi oleh interaksi faktor biologis, psikologis, dan lingkungan.

Bentuk Perilaku Agresif

a) Agresi Fisik: memukul, menendang, merusak barang
b) Agresi Verbal: membentak, mengancam, menghina
c) Agresi Relasional: manipulasi hubungan sosial, mengucilkan seseorang.

d. Perilaku Gaya Hidup Tidak Sehat

1) Pola Makan Tidak Sehat

Remaja sering mengonsumsi makanan cepat saji, tinggi gula, garam, dan lemak, tetapi rendah nutrisi.

Dampak: obesitas, anemia, gangguan metabolisme, penurunan kesehatan reproduksi, pola makan tidak sehat juga dapat memengaruhi konsentrasi dan pertumbuhan remaja.

2) Kurang aktivitas fisik

Kemajuan teknologi menyebabkan remaja lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget dibanding aktivitas fisik. Dampak: penurunan kebugaran tubuh, obesitas, gangguan postur tubuh, risiko penyakit kronis

3) Kurang Tidur

Remaja sering mengalami gangguan pola tidur akibat penggunaan media sosial, tugas sekolah, atau kebiasaan begadang.

Dampak: mudah lelah, sulit konsentrasi, gangguan emosi, penurunan daya tahan tubuh, kurang tidur berkaitan dengan meningkatnya stres, gangguan kesehatan mental pada remaja.

4) Penggunaan Gadget Berlebihan

Penggunaan gadget secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan digital. Dampak: menurunnya interaksi sosial, gangguan penglihatan, gangguan tidur, kecemasan dan stres, paparan media digital

yang berlebihan juga meningkatkan risiko cyberbullying dan citra tubuh negatif.

5) Kebiasaan Sedentary Lifestyle

Sedentary lifestyle adalah kebiasaan duduk terlalu lama dengan aktivitas fisik minimal. Contoh: bermain game berjam-jam dan menonton layar terlalu lama. Dampak: obesitas, nyeri otot dan tulang, gangguan metabolisme

4. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Berisiko

Perilaku berisiko pada remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri remaja maupun lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan dapat meningkatkan kecenderungan remaja melakukan perilaku yang berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi dan mental.

a. Faktor Individu

Faktor individu berkaitan dengan kondisi pribadi remaja, seperti rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, rendahnya *self-esteem*, serta adanya sifat *sensation seeking* atau keinginan mencari sensasi dan mencoba hal baru tanpa mempertimbangkan risiko. Remaja dengan kontrol diri yang rendah cenderung lebih mudah terlibat dalam perilaku berisiko. Kepribadian seperti pencarian sensasi diketahui berhubungan dengan meningkatnya perilaku berisiko pada remaja (Agung, 2014).

b. Faktor **Keluarga**

Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku remaja. Kurangnya pengawasan orang tua, komunikasi yang tidak terbuka, serta pola asuh yang kurang efektif dapat meningkatkan risiko remaja terlibat dalam perilaku negatif. Sebaliknya, hubungan yang dekat dan suportif dengan orang tua dapat menjadi faktor pelindung bagi remaja. Kelekatan orang tua terbukti berperan penting dalam menurunkan perilaku berisiko pada remaja (Utami et al., 2023).

c. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial juga sangat memengaruhi perilaku remaja. Pengaruh teman sebaya, paparan media sosial, serta lingkungan pergaulan yang tidak sehat dapat mendorong remaja meniru perilaku negatif agar diterima dalam kelompoknya. Teman sebaya menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi munculnya perilaku berisiko pada remaja (Fatoni & Situmorang, 2019).

d. Faktor Sosiodemografi

Faktor sosiodemografi seperti usia, jenis kelamin, status ekonomi, tingkat pendidikan, dan akses informasi turut memengaruhi perilaku remaja. Remaja dengan akses informasi yang kurang memadai atau berada pada lingkungan sosial ekonomi tertentu memiliki risiko lebih tinggi melakukan perilaku berisiko. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kecenderungan remaja dalam mengambil keputusan terkait kesehatan dan perilaku sehari-hari (Wahdini et al., 2020).

5. Dampak Perilaku Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi

Perilaku berisiko pada remaja dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan reproduksi, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kurangnya pengetahuan, pengaruh lingkungan, dan rendahnya kontrol diri dapat meningkatkan kemungkinan remaja melakukan perilaku yang membahayakan kesehatan reproduksinya.

a. Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)

Kehamilan tidak diinginkan dapat terjadi akibat hubungan seksual tanpa perlindungan atau kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Kondisi ini dapat memengaruhi pendidikan, kondisi psikologis, serta masa depan remaja.

b. Infeksi Menular Seksual (IMS)

Perilaku seksual tidak aman dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi menular seksual (IMS), termasuk HIV/AIDS. IMS dapat menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang apabila tidak ditangani dengan baik.

c. Gangguan Kesehatan Reproduksi

Perilaku berisiko juga dapat menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi, seperti: infertilitas atau gangguan kesuburan dan angguan organ reproduksi akibat infeksi atau perilaku tidak sehat.

d. Dampak Psikologis

Selain dampak fisik, perilaku berisiko dapat menimbulkan dampak psikologis, seperti stres, depresi, rasa bersalah, kecemasan, trauma, hingga penurunan rasa percaya diri.

Perilaku berisiko tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik remaja, tetapi juga berdampak pada kondisi mental dan kehidupan sosialnya (Bella et al., 2019).

6. Upaya Pencegahan dan Penanganan

a. Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Pendidikan kesehatan reproduksi merupakan upaya pemberian informasi dan pemahaman kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi, perubahan pubertas, hubungan sosial, serta perilaku hidup sehat. Edukasi yang tepat dapat membantu remaja mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan menurunkan risiko perilaku berbahaya, seperti seks bebas, penyalahgunaan zat, dan kekerasan seksual

b. Pendekatan Peer Education

Peer education merupakan metode edukasi yang dilakukan oleh teman sebaya yang telah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Pendekatan ini efektif karena remaja cenderung merasa lebih nyaman dan terbuka ketika berdiskusi dengan teman seusianya.

Melalui pendidikan sebaya, remaja dapat dengan bertukar pengalaman, mendapat dukungan emosional, meningkatkan pengetahuan kesehatan, mengurangi perilaku berisiko.

Menurut Hasbi (2019), pendekatan pendidikan sebaya efektif meningkatkan pemahaman remaja terkait kesehatan reproduksi dan perilaku sehat karena komunikasi berlangsung lebih santai dan tidak menghakimi.

Selain itu, *peer education* juga membantu membangun rasa percaya diri dan keterampilan komunikasi pada remaja.

c. Peran Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan perilaku remaja. Dukungan keluarga yang baik dapat menjadi faktor protektif terhadap berbagai perilaku berisiko.

1) Pengawasan

Pengawasan orang tua penting untuk memastikan remaja berada dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Pengawasan dapat dilakukan dengan:

a) Mengetahui aktivitas dan pergaulan anak
b) Mengawasi penggunaan media sosial
c) Memberikan batasan yang sehat

Pengawasan yang baik bukan berarti membatasi secara berlebihan, tetapi memberikan perhatian dan pendampingan secara konsisten.

2) Komunikasi Terbuka

Komunikasi yang terbuka membantu remaja merasa didengar dan dipahami.

Orang tua perlu:

a) Mendengarkan tanpa menghakimi
b) Memberikan kesempatan anak menyampaikan pendapat

c) Membahas kesehatan reproduksi secara positif

Komunikasi yang baik terbukti menurunkan risiko perilaku seksual berisiko dan penyalahgunaan zat pada remaja (Widman et al., 2016).

3) Pendidikan Nilai

Keluarga berperan dalam menanamkan nilai moral, agama, dan sosial sebagai dasar pengambilan keputusan remaja.

Nilai yang diajarkan meliputi: tanggung jawab, menghargai diri sendiri, pengendalian diri, etika pergaulan

Pendidikan nilai membantu remaja memiliki prinsip dan kemampuan menolak pengaruh negatif lingkungan.

d. Peran Bidan

1) Peran Bidan sebagai Edukator

Dalam pelayanan kebidanan, bidan berperan sebagai edukator yang memberikan pendidikan kesehatan kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi, pubertas dan perubahan fisik, menstruasi sehat, pencegahan kehamilan remaja, bahaya perilaku seksual berisiko, pencegahan infeksi menular seksual (IMS), serta bahaya merokok, alkohol, dan narkoba.

Edukasi dapat dilakukan melalui penyuluhan di sekolah, kelas remaja, konseling individu, maupun media edukasi kesehatan. Pemberian informasi yang tepat membantu remaja memahami perubahan tubuhnya, meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi, serta mendorong terbentuknya perilaku hidup sehat dan bertanggung jawab (Kemenkes RI, 2022).

2) Peran Bidan sebagai Konselor Remaja

Bidan memberikan konseling pada remaja yang mengalami: stres dan kecemasan, gangguan citra tubuh, masalah menstruasi, bullying konflik keluarga atau sosial dan perilaku berisiko.

Dalam konseling, bidan menggunakan komunikasi terapeutik dengan prinsip berempati, tidak menghakimi, menjaga privasi dan kerahasiaan mendengarkan aktif

Pelayanan yang nyaman membuat remaja lebih terbuka dalam menyampaikan masalah kesehatan reproduksi dan psikologisnya.

3) Peran Bidan dalam Deteksi Dini

Bidan melakukan skrining atau deteksi dini terhadap masalah kesehatan remaja, seperti: Anemia remaja, gangguan menstruasi, tanda stres atau depresi, risiko kekerasan seksual, penyalahgunaan zat dan perilaku seksual berisiko.

Deteksi dini penting agar masalah dapat segera ditangani sebelum menimbulkan dampak yang lebih berat terhadap kesehatan reproduksi maupun mental remaja.

4) Peran Bidan dalam Pelayanan PKPR

Dalam pelayanan kebidanan, bidan berperan aktif dalam Program PKPR (*Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja*) sebagai upaya meningkatkan kesehatan remaja secara menyeluruh. Pelayanan yang diberikan meliputi konseling kesehatan reproduksi, pelayanan menstruasi sehat, edukasi gizi remaja, pencegahan anemia, konseling kesehatan mental, serta pencegahan pernikahan dini.

Melalui program ini, bidan membantu remaja memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan yang benar, aman, dan sesuai kebutuhan perkembangan usianya. Program PKPR bertujuan menciptakan pelayanan kesehatan yang ramah remaja, nyaman, mudah diakses, serta mampu mendukung tumbuh kembang remaja secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial.

5) Peran Bidan sebagai Pendamping dan Motivator

Dalam pelayanan kebidanan remaja, bidan berperan sebagai pendamping dan motivator yang membantu remaja menghadapi berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial. Bidan memberikan dukungan emosional melalui komunikasi yang empatik, ramah, dan tidak menghakimi sehingga remaja merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan masalahnya.

Selain itu, bidan membantu memotivasi remaja untuk menerapkan pola hidup sehat, meningkatkan rasa percaya diri, serta mendampingi remaja dalam mengambil keputusan yang sehat dan bertanggung jawab. Pendekatan yang suportif dan penuh perhatian dapat membantu remaja lebih percaya diri serta menghindari perilaku berisiko yang dapat berdampak pada kesehatan reproduksi dan mentalnya.

6) Peran Bidan dalam Kolaborasi dan Rujukan

Jika ditemukan masalah yang memerlukan penanganan lanjutan, bidan melakukan kolaborasi dan rujukan dengan: psikolog, dokter, konselor remaja, ahli gizi, pusat perlindungan perempuan dan anak.

Rujukan dilakukan pada kondisi: depresi berat, kekerasan seksual, kehamilan remaja berisiko, ketergantungan narkoba dan gangguan mental serius

D. Mapping CP Bab → CPMK → CPL

CP Bab	CPMK	CPL
Bab 10. Kesehatan Mental Remaja terkait Reproduksi: Stres, Citra Tubuh, dan Perilaku Berisiko	Merancang intervensi promotif–preventif terkait gizi, anemia/KEK/obesitas, kesehatan mental, dan faktor risiko lain untuk pencegahan masalah reproduksi dan stunting antar generasi.	CPL-5

E. Latihan Soal

Mini-Case Tertulis (Diskusi Kelompok)

Tema: Kesehatan Mental dan Perilaku Berisiko pada Remaja

Tujuan Pembelajaran

Setelah melakukan diskusi kasus, mahasiswa mampu:

1. Mengidentifikasi masalah kesehatan mental dan perilaku berisiko pada remaja.
2. Menentukan faktor penyebab dan faktor risiko.
3. Menjelaskan penatalaksanaan awal pada remaja.
4. Menentukan kebutuhan rujukan.
5. Mengidentifikasi *red flags* yang memerlukan penanganan segera.

Kasus

Seorang remaja perempuan usia 16 tahun datang ke UKS sekolah ditemani temannya. Remaja tersebut tampak murung, mudah menangis, dan mengaku sulit tidur sejak beberapa bulan terakhir. Ia juga mengatakan sering merasa tidak percaya diri karena bentuk tubuhnya dianggap "gendut" oleh teman-temannya di media sosial.

Dalam wawancara lebih lanjut, remaja mengaku:

1. sering diejek oleh teman sekolah (*body shaming*),
2. mulai malas makan dan terkadang hanya makan satu kali sehari,
3. nilai sekolah menurun,
4. lebih sering menyendiri di kamar,
5. pernah mencoba merokok karena ajakan teman agar dianggap "gaul".

Temannya juga mengatakan bahwa akhir-akhir ini remaja tersebut sering mengunggah status sedih dan mengatakan "capek dengan hidup".

Tugas Diskusi Kelompok

1. Identifikasi Masalah

   Diskusikan masalah yang ditemukan pada kasus di atas:

   a. Masalah kesehatan mental
   b. Masalah citra tubuh

c. Perilaku berisiko
d. Faktor penyebab

2. Identifikasi *Red Flags*
   Sebutkan tanda bahaya (*red flags*) yang ditemukan pada kasus tersebut Tentukan
3. Penatalaksanaan Awal
   Jelaskan langkah penanganan awal yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau bidan, meliputi:
   a. Pendekatan komunikasi terapeutik
   b. Edukasi kesehatan mental
   c. Dukungan psikososial
   d. Edukasi perilaku sehat
4. Tentukan Kebutuhan Rujukan
   Apakah remaja memerlukan rujukan?
   Jika ya, rujuk ke mana dan jelaskan alasannya.

Panduan Jawaban (Untuk Dosen)

1. Identifikasi Masalah
   Masalah yang ditemukan:
   a. Stres psikologis
   b. Citra tubuh negatif (*negative body image*)
   c. Risiko gangguan makan
   d. Bullying/body shaming
   e. Isolasi sosial
   f. Percobaan merokok
   g. Risiko depresi
2. Red Flags
   a. Menarik diri dari lingkungan
   b. Unggahan bernada putus asa
   c. Gangguan makan
   d. Sulit tidur berkepanjangan
   e. Penurunan fungsi akademik
   f. Percobaan perilaku adiktif (merokok)
3. Penatalaksanaan Awal
   a. Bangun komunikasi empatik dan tidak menghakimi
   b. Berikan edukasi tentang body image positif
   c. Anjurkan pola makan sehat
   d. Libatkan keluarga untuk dukungan emosional

e. Dorong aktivitas positif dan interaksi sosial sehat
f. Edukasi bahaya merokok

4. Rujukan

Rujukan diperlukan apabila: gejala depresi semakin berat, ada gangguan makan serius, risiko menyakiti diri atau bunuh diri

Rujukan dapat dilakukan ke:

a. Psikolog
b. Dokter
c. PKPR
d. Konselor remaja

F. Simulasi / Skill Lab Asuhan Kebidanan pada Remaja

Tema:

Asuhan Kebidanan pada Remaja dengan Masalah Kesehatan Mental dan Perilaku Berisiko

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti skill lab, mahasiswa mampu:

1. Melakukan komunikasi terapeutik pada remaja.
2. Melakukan pengkajian dasar masalah kesehatan remaja.
3. Mengidentifikasi perilaku berisiko dan *red flags*.
4. Memberikan edukasi dan konseling sederhana pada remaja.
5. Menentukan tindakan aman dan kebutuhan rujukan.

Skenario Kasus

Seorang remaja perempuan usia 15 tahun datang ke pelayanan kesehatan ditemani ibunya. Remaja tampak diam, kurang kontak mata, dan sering menunduk. Ibu mengatakan anaknya menjadi mudah marah, sering menyendiri, sulit tidur, serta nilai sekolah menurun sejak beberapa bulan terakhir.

Saat dilakukan wawancara, remaja mengaku sering diejek teman karena bentuk tubuhnya. Remaja juga mengatakan pernah mencoba merokok karena mengikuti teman sebaya dan merasa stres dengan kondisi dirinya.

Tugas Mahasiswa dalam Skill Lab

Mahasiswa melakukan simulasi asuhan kebidanan remaja dengan fokus:

1. Urutan tindakan
2. Komunikasi terapeutik
3. Keselamatan dan kenyamanan remaja

Urutan Tindakan Simulasi

1. Persiapan

Mahasiswa:

a. Menyiapkan alat dan ruang konseling yang nyaman
b. Menjaga privasi remaja
c. Mencuci tangan dan menerapkan komunikasi profesional

2. Membina Hubungan Saling Percaya

Mahasiswa:

a. Memberi salam dan memperkenalkan diri
b. Menggunakan bahasa ramah remaja
c. Menjelaskan tujuan pemeriksaan/konseling
d. Memberikan rasa aman dan tidak menghakimi

Contoh komunikasi:

"Kakak di sini untuk membantu, jadi adik tidak perlu takut bercerita."

3. Pengkajian Remaja

Mahasiswa melakukan pengkajian:

a. Identitas dan kondisi umum
b. Keluhan utama
c. Kondisi psikologis dan emosional
d. Hubungan sosial dan keluarga
e. Perilaku berisiko (merokok, bullying, stres)
f. Pola tidur, makan, dan aktivitas

4. Identifikasi Masalah dan Red Flags

Mahasiswa mengidentifikasi:

a. Stres remaja
b. Citra tubuh negatif
c. Risiko perilaku adiktif
d. Dampak bullying

Red flags yang perlu diperhatikan:

a. Menarik diri ekstrem
b. Gangguan makan berat
c. Pernyataan putus asa
d. Self-harm atau ide bunuh diri

5. Edukasi dan Konseling

Mahasiswa memberikan edukasi:

a. Manajemen stres sederhana
b. Body image positif
c. Bahaya merokok

d. Pentingnya dukungan keluarga dan teman sehat

Mahasiswa juga memberikan dukungan emosional dan motivasi positif.

6. Menentukan Tindak Lanjut / Rujukan

Mahasiswa menentukan:

a. Apakah remaja perlu pemantauan ulang
b. Apakah perlu dirujuk ke psikolog/dokter/PKPR

7. Penutup

Mahasiswa:

a. Menyimpulkan hasil konseling
b. Memberikan kesempatan bertanya
c. Mengucapkan terima kasih
d. Mendokumentasikan hasil asuhan

Penilaian Skill Lab

Aspek	Penilaian
Komunikasi terapeutik	☐
Sikap empatik dan profesional	☐
Ketepatan pengkajian	☐
Identifikasi masalah	☐
Identifikasi red flags	☐
Edukasi dan konseling	☐
Keselamatan dan privasi remaja	☐
Ketepatan rujukan	☐

G. Rubrik OSCE Ringkas

Asuhan Kebidanan pada Kesehatan Mental Remaja

1. Nomor Station	-
2. Judul Station	Konseling Asuhan Kebidanan pada Kesehatan Mental Remaja
3. Waktu yang Dibutuhkan	10 menit
4. Tujuan Station	Peserta ujian mampu melakukan pengkajian, komunikasi terapeutik, konseling kesehatan mental remaja, identifikasi red flags, serta menunjukkan perilaku profesional.
5. Kompetensi	1. Pengumpulan data subjektif 2. Identifikasi masalah psikologis remaja

	3. Konseling kesehatan mental remaja 4. Edukasi kesehatan reproduksi dan perilaku sehat 5. Penentuan rujukan/eskalasi 6. Pendokumentasian 7. Perilaku profesional
6. Kategori	Remaja/Pranikah : Deteksi dini dan promosi kesehatan
7. Instruksi Peserta Ujian	Skenario Klinik: Seorang remaja perempuan usia 16 tahun datang ke pelayanan kesehatan ditemani ibunya. Remaja tampak murung, mudah menangis, sulit tidur, dan sering menyendiri sejak beberapa bulan terakhir. Remaja mengaku sering diejek teman karena bentuk tubuhnya dan pernah mencoba merokok karena ajakan teman. Tugas: 1. Lakukan pengkajian singkat pada remaja 2. Berikan konseling kesehatan mental remaja 3. Identifikasi red flags bila ditemukan 4. Jelaskan tindak lanjut atau rujukan bila diperlukan 5. Serahkan hasil dokumentasi kepada penguji
8. Instruksi Penguji	1. Nilai kemampuan komunikasi terapeutik peserta. 2. Amati kemampuan peserta melakukan pengkajian psikologis dan perilaku berisiko. 3. Nilai kemampuan peserta memberikan edukasi dan konseling. 4. Perhatikan identifikasi red flags dan keputusan rujukan. 5. Nilai perilaku profesional dan keselamatan pasien.
9. Kebutuhan Pasien Simulasi	Ada
10. Tipe Ruangan	Ruang Konseling
11. Kebutuhan Manekin	Tidak ada

12. Kebutuhan Alat	1. Lembar dokumentasi 2. ATK 3. Kursi dan meja konseling
13. Penulis	Cynthia Puspariny
14. Referensi	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman PKPR. World Health Organization. (2021). Adolescent mental health.

H. Rubrik Penilaian

Rubrik ini digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan konseling asuhan kebidanan pada remaja dengan perilaku merokok, meliputi komunikasi terapeutik, pengkajian, edukasi, keselamatan pasien, dan tindak lanjut.

Komponen Penilaian	4	3	2	1	Bobot
Identifikasi pasien & menjaga privasi	Melakukan identifikasi lengkap, menjaga privasi dan kenyamanan secara konsisten	Identifikasi baik, privasi cukup terjaga	Identifikasi kurang lengkap atau privasi kurang diperhatikan	Tidak melakukan identifikasi dan mengabaikan privasi	2
Komunikasi terapeutik	Empatik, aktif mendengarkan, bahasa jelas dan ramah remaja	Komunikasi baik namun kurang mendalam	Kurang empatik atau komunikasi kurang jelas	Komunikasi buruk/menghakimi	3
Pengkajian perilaku merokok	Menggali frekuensi merokok, alasan merokok, pengaruh teman, durasi, dan dampak kesehatan	Menggali sebagian besar data penting	Pengkajian kurang lengkap	Tidak mampu melakukan pengkajian	3
Identifikasi masalah & faktor risiko	Mampu mengidentifikasi stres, pengaruh teman sebaya, dan perilaku berisiko dengan tepat	Sebagian besar masalah teridentifikasi	Masalah teridentifikasi namun kurang tepat	Tidak mampu mengidentifikasi masalah	2
Edukasi bahaya merokok	Menjelaskan dampak merokok terhadap	Edukasi cukup jelas namun	Edukasi kurang sistematis	Tidak memberikan edukasi	3

	kesehatan reproduksi, paru, jantung, dan mental secara jelas	kurang lengkap			
Konseling perubahan perilaku	Memberikan motivasi berhenti merokok, strategi coping sehat, dan dukungan positif	Konseling cukup baik	Konseling kurang sesuai kebutuhan remaja	Tidak mampu melakukan konseling	3
Identifikasi red flags & eskalasi	Mampu mengenali tanda bahaya dan menentukan rujukan dengan tepat	Mengenali sebagian besar red flags	Kurang tepat menentukan tindak lanjut	Tidak mengenali red flags	2
Profesionalisme & patient safety	Sikap profesional, aman, menjaga kenyamanan pasien secara konsisten	Profesional dengan kesalahan kecil	Kurang sistematis atau kurang menjaga kenyamanan	Tidak aman dan tidak profesional	2

Critical Items (Wajib Lulus)

Critical Items	Ya	Tidak
Melakukan identifikasi pasien dan menjaga privasi remaja	☐	☐
Melakukan edukasi bahaya merokok pada remaja	☐	☐
Melakukan komunikasi terapeutik tanpa menghakimi	☐	☐
Mengidentifikasi red flags dan menentukan rujukan bila diperlukan	☐	☐

Keputusan Akhir

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR
☐	☐	☐	☐

I. DOPS (*Direct Observation of Procedural Skills*) — DOES

DOPS di Lahan Praktik

Asuhan Kebidanan pada Remaja dengan Masalah Kesehatan Mental dan Perilaku Berisiko

No	Komponen Penilaian	Ya	Tidak	Umpan Balik
1	Menyiapkan lingkungan yang aman dan menjaga privasi remaja	☐	☐	
2	Memperkenalkan diri dan membangun hubungan terapeutik	☐	☐	
3	Menggunakan komunikasi ramah remaja dan tidak menghakimi	☐	☐	
4	Melakukan pengkajian masalah psikologis dan sosial remaja	☐	☐	
5	Mengidentifikasi perilaku berisiko pada remaja	☐	☐	
6	Mengidentifikasi tanda bahaya (*red flags*)	☐	☐	
7	Memberikan konseling kesehatan mental remaja	☐	☐	
8	Memberikan edukasi kesehatan reproduksi sesuai kebutuhan remaja	☐	☐	
9	Memberikan dukungan emosional dan motivasi positif	☐	☐	
10	Melibatkan keluarga secara tepat dalam asuhan	☐	☐	
11	Menentukan kebutuhan rujukan bila diperlukan	☐	☐	
12	Melakukan dokumentasi asuhan kebidanan dengan benar	☐	☐	

Keputusan Penilaian

Hasil Evaluasi	Keterangan
☐ Kompeten	Mahasiswa mampu melakukan asuhan secara mandiri dan sesuai prosedur
☐ Supervisi	Mahasiswa mampu melakukan sebagian tindakan tetapi masih memerlukan bimbingan
☐ Remedial	Mahasiswa belum mampu melakukan tindakan sesuai kompetensi yang diharapkan

Portofolio

Bukti Pencapaian Kompetensi Mahasiswa

Portofolio digunakan sebagai dokumentasi perkembangan kompetensi mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan pada remaja. Penilaian dilakukan secara

berkelanjutan melalui pengumpulan berbagai bukti performa selama proses pembelajaran dan praktik klinik.

Komponen Bukti yang Dikumpulkan

No	Komponen Portofolio	Deskripsi Bukti	Status
1	**OSCE (Objective Structured Clinical Examination)**	Hasil penilaian keterampilan komunikasi, pengkajian, edukasi, dan konseling remaja pada simulasi stasiun OSCE	☐
2	**DOPS (Direct Observation of Procedural Skills)**	Hasil observasi langsung keterampilan mahasiswa dalam praktik asuhan kebidanan remaja di lahan praktik	☐
3	**Catatan Kasus Singkat**	Dokumentasi kasus remaja yang pernah ditangani meliputi pengkajian, masalah, tindakan, dan evaluasi	☐
4	**Refleksi Patient Safety**	Refleksi mahasiswa mengenai keselamatan pasien, komunikasi efektif, privasi, dan etika pelayanan remaja	☐
5	**Feedback CI/Dosen**	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen terkait sikap profesional, komunikasi, dan keterampilan klinik	☐

Format Catatan Kasus Singkat

Komponen	Isi
Identitas Kasus	.....
Masalah Utama	.....
Hasil Pengkajian	.....
Tindakan/Konseling	.....
Red Flags	.....
Tindak Lanjut/Rujukan	.....
Evaluasi	.....

Format Refleksi Patient Safety

Hal yang Sudah Dilakukan dengan Baik

.....

.....

Risiko Keselamatan yang Ditemukan

.....

.....

Rencana Perbaikan

.....

.....

Format Feedback CI/Dosen

Aspek Penilaian	**Baik**	**Cukup**	**Perlu Perbaikan**
Komunikasi terapeutik	☐	☐	☐
Sikap profesional	☐	☐	☐
Pengkajian remaja	☐	☐	☐
Edukasi dan konseling	☐	☐	☐
Keselamatan pasien	☐	☐	☐
Dokumentasi	☐	☐	☐

Komentar CI/Dosen

.....

.....

J. Rangkuman Materi

1. Capaian Pembelajaran Bab

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

a. Menjelaskan konsep kesehatan mental pada remaja.
b. Mengidentifikasi faktor penyebab stres dan gangguan citra tubuh pada remaja.
c. Menjelaskan bentuk-bentuk perilaku berisiko pada remaja.
d. Menganalisis dampak perilaku berisiko terhadap kesehatan reproduksi remaja.
e. Melakukan edukasi kesehatan reproduksi dan promosi perilaku sehat pada remaja.
f. Mengidentifikasi tanda bahaya (*red flags*) masalah kesehatan mental dan perilaku berisiko pada remaja.
g. Menerapkan komunikasi terapeutik dan pendekatan ramah remaja dalam 2. kebidanan.

2. Alur (*Flow)*



Gambar 2.3: Alur Asuhan Kebidanan pada kesehatan Mental Remaja

3. Red Flags & Eskalasi

Tanda Bahaya (Red Flags) pada Remaja

Mahasiswa atau tenaga kesehatan perlu waspada apabila ditemukan:

a. Tanda Psikologis
   1) Menarik diri dari lingkungan sosial
   2) Sedih berkepanjangan
   3) Mudah marah atau agresif
   4) Kecemasan berat

5) Gangguan tidur berat

b. Tanda Perilaku Berisiko
   1) Penyalahgunaan alkohol/narkoba
   2) Perilaku seksual berisiko
   3) Tawuran atau bullying
   4) Self-harm atau menyakiti diri

c. Tanda Fisik
   1) Penurunan berat badan drastis
   2) Luka mencurigakan
   3) Kelelahan berlebihan
   4) Gangguan menstruasi akibat stres berat

4. Eskalasi / Rujukan

Segera lakukan rujukan apabila:

a. Ada risiko bunuh diri
b. Kekerasan seksual
c. Ketergantungan zat
d. Gangguan mental berat
e. Kehamilan remaja dengan masalah psikososial

Rujukan dapat dilakukan ke:

a. Psikolog
b. Dokter spesialis
c. PKPR
d. Konselor remaja
e. Pusat layanan perlindungan anak/perempuan

5. Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab: **Kesehatan Mental Remaja Terkait Reproduksi**

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Kompetensi	Sudah
1	Menjelaskan kesehatan mental remaja	☐
2	Mengidentifikasi faktor penyebab stres remaja	☐
3	Menjelaskan citra tubuh pada remaja	☐
4	Mengidentifikasi perilaku berisiko	☐

5	Melakukan komunikasi terapeutik pada remaja	☐
6	Memberikan edukasi kesehatan reproduksi	☐
7	Mengidentifikasi red flags kesehatan mental	☐
8	Menentukan kebutuhan rujukan	☐
9	Melakukan konseling dasar remaja	☐
10	Menjelaskan peran keluarga dan peer education	☐

K. Daftar Pustaka

Ahuja, K., Sharma, P., & Verma, R. (2024). Social media exposure and body image dissatisfaction among adolescents. *Journal of Adolescent Health*, 74(2), 155–163.

Alfiani, D., & Wulansari, A. (2023). Perilaku berisiko pada remaja dan faktor yang memengaruhinya. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*, 14(1), 33–41.

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). American Psychological Association.

Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2018). Media violence and aggressive behavior in children and adolescents. *Annual Review of Psychology*, 69, 651–673.

Andiani, R., Putri, D. A., & Lestari, N. (2024). Hubungan stres dengan kesehatan reproduksi pada remaja. *Jurnal Kesehatan Remaja Indonesia*, 8(1), 25–33.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2019). *Remaja dan kesehatan reproduksi*. BKKBN.

Bella, N., Sari, M., & Fitriani, D. (2019). Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perilaku kesehatan reproduksi remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 14(2), 85–92.

Cash, T. F., & Smolak, L. (2011). *Body image: A handbook of science, practice, and prevention* (2nd ed.). Guilford Press.

Centers for Disease Control and Prevention. (2022). *Youth risk behavior surveillance system (YRBSS)*. CDC.

Fatoni, Z., & Situmorang, A. (2019). Peran keluarga dalam pencegahan perilaku berisiko pada remaja. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 7(1), 44–52.

Ferreira, C., Pinto-Gouveia, J., & Duarte, C. (2023). Body image dissatisfaction and psychological adjustment among adolescents. *Body Image*, 44, 120–129.

Ganesan, S., Ravishankar, S. L., & Ramalingam, S. (2018). Are body image issues affecting our adolescents? A cross-sectional study among college going adolescent girls. *Indian Journal of Community Medicine*, 43(Suppl 1), S42–S46.

Griffiths, S., Murray, S. B., & Touyz, S. (2018). Disordered eating and body image concerns among adolescents. *Current Opinion in Psychiatry*, 31(6), 455–460.

Guidi, J., Lucente, M., Sonino, N., & Fava, G. A. (2021). Allostatic load and its impact on health: A systematic review. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 90(1), 11–27.

Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2021). *Textbook of medical physiology* (14th ed.). Elsevier.

Hasbi, M. (2019). Efektivitas *peer education* terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi remaja. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 14(2), 120–128.Hawari, D. (2016). *Manajemen stres, cemas dan depresi* (Edisi revisi). Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Holland, G., & Tiggemann, M. (2016). A systematic review of the impact of the use of social networking sites on body image and disordered eating outcomes. *Body Image*, 17, 100–110.

Indraswari, D. (2022). Perilaku kesehatan remaja dan faktor risiko sosial. *Jurnal Promosi Kesehatan*, 10(1), 55–63.

Indriyani, R. (2023). Kesehatan mental remaja dan faktor risiko psikososial. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat*, 12(2), 115–123.

Karen M. King, Chassin, L., & Thompson, K. (2022). Adolescent stress and risk behaviors: Developmental perspectives. *Journal of Adolescent Health*, 70(4), 550–558.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR)*. Kemenkes RI.

Kosenko, K., Luurs, G., & Binder, A. R. (2017). Sexting and sexual behavior among adolescents. *Journal of Adolescent Health*, 61(5), 615–621.

Lazarus, R. S. (2020). *Stress and emotion: A new synthesis*. Springer Publishing Company.

Maedy, F. (2022). Citra tubuh dan kesehatan mental remaja perempuan. *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, 11(2), 88–97.

Mahmud, R., & Uyun, Z. (2016). Mekanisme stres dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental remaja. *Jurnal Psikologi Pendidikan Indonesia*, 5(1), 45–53.

Maulidya, N. (2024). Faktor psikososial yang memengaruhi stres pada remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 19(1), 45–53.

McEwen, B. S. (2020). The brain on stress: Toward an integrative approach to brain, body, and behavior. *Perspectives on Psychological Science*, 15(5), 1261–1273.

McEwen, B. S., & Akil, H. (2020). Revisiting the stress concept: Implications for affective disorders. *Journal of Neuroscience*, 40(1), 12–21.

Murharyati, A., Wulandari, D., & Prasetyo, B. (2021). Respons stres pada remaja terhadap perubahan psikososial. *Jurnal Kesehatan Holistik*, 15(3), 210–218.

Musradinur. (2016). Stres dan cara mengatasinya dalam perspektif psikologi. *Jurnal Edukasi*, 2(2), 183–200.

O'Sullivan, G. (2021). *The biology of stress and mental health in adolescents*. Oxford University Press.

Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2016). Adolescents and pornography: A review of 20 years of research. *The Journal of Sex Research*, 53(4–5), 509–531.

Raut, S. (2025). Digital lifestyle and adolescent mental health challenges. *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 37(1), 1–9.

Rodgers, R. F., Paxton, S. J., & Wertheim, E. H. (2023). Body image concerns in adolescents: Advances in prevention and intervention. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 7(3), 210–218.

Russell, G., & Lightman, S. (2019). The human stress response. *Nature Reviews Endocrinology*, 15(9), 525–534.

Santrock, J. W. (2019). *Adolescence* (17th ed.). McGraw-Hill Education.

SDKI. (2017). *Survei demografi dan kesehatan Indonesia 2017: Kesehatan reproduksi remaja*. BPS, BKKBN, Kemenkes, dan ICF.

Seran, M. (2024). Dampak stres psikologis terhadap kesehatan mental remaja. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 7(1), 66–74.

Slavich, G. M. (2020). Social safety theory: A biologically based evolutionary perspective on life stress, health, and behavior. *Annual Review of Clinical Psychology*, 16, 265–295.

Soejarwo, T., Rahmawati, E., & Lestari, A. (2025). Hubungan perilaku agresif dengan penggunaan media digital pada remaja. *Jurnal Psikologi Remaja Indonesia*, 9(1), 12–20.

Teigen, K. H. (2021). Stress, coping, and adolescent adjustment. *Journal of Adolescence*, 89, 45–56.

Townsend, M. C. (2015). *Psychiatric mental health nursing: Concepts of care in evidence-based practice* (8th ed.). F.A. Davis Company.

Ungsianik, T., & Yuliati, T. (2017). Pola perilaku berisiko pada remaja di Indonesia. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 20(3), 139–146.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2019). *International technical guidance on sexuality education*. UNESCO.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *World drug report 2022*. UNODC.

Utami, R., Lestari, D., & Pratiwi, A. (2023). Hubungan dukungan sosial dengan kesehatan mental remaja. *Jurnal Keperawatan Jiwa Indonesia*, 11(1), 30–38.

Wahdini, S., Nurhayati, E., & Rahman, F. (2020). Perilaku berisiko dan kesehatan reproduksi pada remaja. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 11(3), 201–209.

Widman, L., Choukas-Bradley, S., Helms, S. W., & Prinstein, M. J. (2016). Parent-adolescent sexual communication and adolescent safer sex behavior. *JAMA Pediatrics*, 170(1), 52–61.

Wilson, R. E., Latner, J. D., & Hayashi, K. (2021). Peer influence and body dissatisfaction among adolescents. *Body Image*, 37, 1–9.

World Health Organization. (2021). *Adolescent health*. WHO.

World Health Organization. (2023). *Mental health of adolescents*. WHO.

Zanlorenci, L. H., Santos, M. A., & Custódio, E. M. (2022). Body image dissatisfaction and emotional symptoms among adolescents. *Trends in Psychology*, 30(4), 890–905.

BAB 3

SISTEM TRIAGE DAN MANAJEMEN ALUR PASIEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT

Capaian Pembelajaran

1. CPL yang Berkontribusi
   a. CPL 1: Profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam pelayanan prakonsepsi.
   b. CPL 3: Keselamatan dan rujukan aman.
   c. CPL 4: Pengkajian dan perencanaan intervensi berbasis evidence.
   d. CPL 6: Dokumentasi dan pengelolaan layanan.
2. CPMK Utama
   a. CPMK 6: Melakukan skrining prakonsepsi dan menyusun rencana intervensi serta tindak lanjut.
3. CPMK Penguat
   a. CPMK 1: Konsep, determinan, dan kerangka etik legal.
   b. CPMK 7: Pengorganisasian layanan berbasis jejaring dan evidence.

SubCPMK

1. Menjelaskan tujuan, sasaran, dan komponen paket pelayanan prakonsepsi pada individu atau pasangan.
2. Mengidentifikasi determinan kesiapan prakonsepsi dan prioritas masalah untuk perencanaan intervensi.

Uraian Materi

A. Pendahuluan

Pelayanan prakonsepsi merupakan bagian integral dari pendekatan **continuum of care** dalam kesehatan ibu dan anak yang dimulai sejak masa remaja hingga sebelum terjadinya kehamilan. Selama ini, intervensi kesehatan lebih banyak difokuskan pada masa kehamilan dan persalinan, padahal banyak faktor risiko yang sudah ada sebelum konsepsi dan tidak dapat diperbaiki secara optimal saat antenatal care dimulai (Dean et al., 2014). Intervensi pada fase ini terbukti berkontribusi signifikan dalam menurunkan risiko komplikasi kehamilan serta angka kematian ibu dan bayi.

Secara global, pendekatan prakonsepsi berkembang sebagai strategi preventif untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu dan bayi, terutama di negara berkembang. Intervensi pada periode sebelum kehamilan terbukti mampu mengurangi morbiditas dan mortalitas maternal serta neonatal melalui modifikasi faktor risiko sejak dini (Kurniawati et al., 2023; Mason et al., 2014).

Pendekatan prakonsepsi yang berfokus pada **pencegahan faktor risiko sebelum kehamilan terjadi**, sehingga memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan ibu, bayi, dan generasi berikutnya. Dengan demikian, pelayanan prakonsepsi tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga mencakup intervensi **biomedis, perilaku, dan sosial** yang terintegrasi untuk meningkatkan outcome kesehatan reproduksi.

B. Materi Pembelajaran

1. Tujuan, Sasaran, dan Komponen Paket Pelayanan Prakonsepsi

a. Konsep dan Definisi Prakonsepsi

Pelayanan prakonsepsi merupakan serangkaian intervensi biomedis, perilaku, dan sosial yang diberikan sebelum terjadinya kehamilan untuk meningkatkan kesehatan perempuan dan pasangan serta mengoptimalkan luaran kehamilan. Konsep ini menekankan bahwa prakonsepsi adalah bagian dari upaya meningkatkan kesehatan generasi mendatang secara berkelanjutan (Fikire et al., 2024).

Literatur terbaru menunjukkan bahwa prakonsepsi tidak hanya terbatas pada periode menjelang kehamilan, tetapi merupakan bagian dari pendekatan ***life course***, yaitu intervensi sejak remaja hingga usia reproduksi aktif. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi dan modifikasi faktor risiko lebih dini sebelum berdampak pada kehamilan (Cassinelli et al., 2024).

b. Tujuan Pelayanan Prakonsepsi

1) Tujuan Umum

Meningkatkan kesehatan calon ibu dan pasangan untuk mencapai kehamilan yang sehat dan aman.

2) Tujuan Khusus

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian dan *guideline*:

- Mengidentifikasi dan mengendalikan faktor risiko sebelum kehamilan
- Meningkatkan kesiapan fisik, psikologis, dan sosial
- Mengurangi kejadian kehamilan tidak direncanakan
- Menurunkan komplikasi maternal dan neonatal
- Meningkatkan kesehatan lintas generasi

Penelitian menunjukkan bahwa prakonsepsi berkontribusi pada peningkatan kesehatan orang tua, bayi, dan generasi berikutnya melalui pendekatan preventif komprehensif (Dorney & Black, 2024).

c. Sasaran Pelayanan Prakonsepsi

1) Sasaran Utama

a) Perempuan usia reproduksi.

Perempuan usia reproduksi tetap menjadi sasaran utama dalam pelayanan prakonsepsi karena memiliki peran langsung dalam kehamilan dan *outcome maternal neonatal*. Banyak sumber dalam jurnal menunjukkan bahwa sebagian besar program dan materi edukasi prakonsepsi masih difokuskan pada perempuan, terutama yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit kronis (Cassinelli et al., 2024).

b) Pasangan usia subur dan laki-laki.

Jurnal menunjukkan bahwa hanya sekitar 37,1% sumber yang secara eksplisit menyebutkan laki-laki atau pasangan sebagai target layanan prakonsepsi .

Hal ini menunjukkan bahwa:

- Keterlibatan laki-laki masih terbatas
- Faktor paternal (misalnya gaya hidup, kesehatan reproduksi) juga memengaruhi outcome kehamilan (Cassinelli et al., 2024).

Kesehatan paternal sebelum konsepsi dapat berperan signifikan terhadap outcome kehamilan, termasuk komplikasi maternal. Faktor gaya hidup laki-laki seperti merokok, status gizi (BMI), konsumsi alkohol, dan nutrisi berhubungan dengan outcome kehamilan dan

kesehatan anak, termasuk cacat lahir dan berat badan lahir. Menegaskan bahwa kesehatan prakonsepsi pria berperan dalam keberhasilan kehamilan dan kesehatan offspring. (Carter et al., 2023).

Pelayanan prakonsepsi modern mengarah pada pendekatan *couple based care* yaitu pelayanan yang tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi melibatkan pasangan secara aktif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi prakonsepsi yang diberikan kepada pasangan lebih efektif dalam meningkatkan perilaku kesehatan, kesiapan kehamilan, serta outcome maternal dan neonatal dibandingkan pendekatan individual. Selain itu, faktor paternal seperti gaya hidup dan status kesehatan juga berkontribusi terhadap keberhasilan kehamilan dan kesehatan anak, sehingga keterlibatan pasangan menjadi komponen penting dalam pelayanan prakonsepsi (Carter et al., 2023; Dennis et al., 2024; Du et al., 2021).

2) Sasaran Sekunder

a) Remaja.

Remaja merupakan sasaran strategis dalam pelayanan prakonsepsi karena berada pada fase kritis dalam pendekatan *life course*, di mana faktor biologis, perilaku, dan lingkungan mulai terbentuk dan akan memengaruhi kesehatan reproduksi di masa depan. Pada masa ini, berbagai faktor risiko seperti malnutrisi, anemia, kurang aktivitas fisik, perilaku merokok, serta kesehatan mental mulai berkembang dan dapat berdampak jangka panjang terhadap kesuburan, kehamilan, dan kesehatan ibu serta bayi. Oleh karena itu, intervensi prakonsepsi pada remaja menjadi sangat penting karena lebih efektif dilakukan sebelum faktor risiko tersebut menetap dan sulit diubah (Padhani et al., 2024).

b) Calon pengantin.

Pelayanan prakonsepsi juga perlu melibatkan pasangan, khususnya laki-laki, karena faktor paternal seperti gaya hidup, status gizi, dan kesehatan reproduksi terbukti berkontribusi terhadap outcome kehamilan dan kesehatan anak. Pendekatan berbasis pasangan (*couple based care*) terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesiapan kehamilan dan perubahan perilaku kesehatan dibandingkan pendekatan individual (Carter et al., 2023).

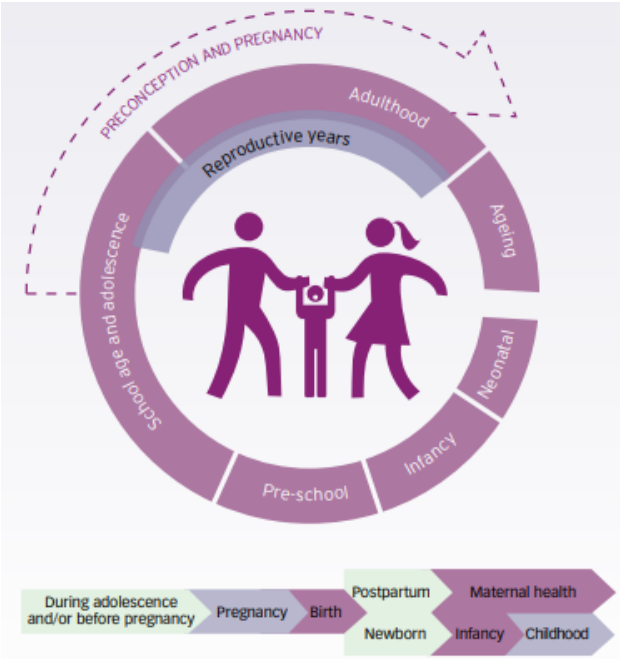
c) Masyarakat

Masyarakat merupakan sasaran penting dalam pelayanan prakonsepsi karena banyak faktor risiko kesehatan reproduksi ditemukan secara luas di masyarakat, bahkan pada individu yang belum merencanakan kehamilan. Pendekatan ini dikenal sebagai *population based approach*, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan secara menyeluruh melalui intervensi promotif dan preventif.

Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar individu memiliki satu atau lebih faktor risiko prakonsepsi, seperti pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, atau perilaku berisiko, yang seringkali tidak disadari dan tidak ditangani sebelum kehamilan terjadi. Oleh karena itu, intervensi berbasis populasi menjadi penting untuk menjangkau kelompok yang lebih luas dan mencegah munculnya risiko sejak dini. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui:

- Edukasi kesehatan masyarakat
- Promosi gaya hidup sehat
- Program kesehatan reproduksi berbasis komunitas
- Integrasi dalam layanan kesehatan primer

Dengan demikian, pelayanan prakonsepsi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merupakan strategi kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi secara luas dan berkelanjutan (Cassinelli et al., 2024).



Gambar 3.1: Preconception Care
Sumber: (WHO, 2013)

3) Sasaran Risiko Tinggi

Kelompok risiko tinggi merupakan sasaran prioritas dalam pelayanan prakonsepsi karena memiliki kemungkinan lebih besar mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Pendekatan ini dikenal sebagai *risk based approach*, yaitu strategi yang menitikberatkan pada identifikasi dan penanganan faktor risiko sebelum terjadinya kehamilan. Kelompok risiko tinggi dalam prakonsepsi meliputi:

a) Perempuan dengan penyakit kronis.

Seperti diabetes, hipertensi, epilepsi, dan penyakit jantung. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, termasuk preeklamsia, kelainan kongenital, dan kematian maternal.

b) Status gizi tidak normal.

Baik kekurangan gizi (anemia, KEK) maupun kelebihan gizi (overweight/obesitas) berhubungan dengan risiko prematuritas, BBLR, dan komplikasi metabolik.

c) Riwayat obstetri buruk.

Seperti abortus berulang, persalinan prematur, atau bayi dengan berat lahir rendah, yang menunjukkan adanya risiko berulang pada kehamilan berikutnya.

d) Perilaku berisiko.

Termasuk merokok, konsumsi alkohol, dan penggunaan zat adiktif yang dapat memengaruhi kesuburan dan perkembangan janin.

e) Faktor sosial ekonomi dan lingkungan.

Kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan keterbatasan akses layanan kesehatan juga meningkatkan risiko kehamilan yang tidak sehat.

Penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko prakonsepsi seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi terjadi secara bersamaan (clustered), sehingga meningkatkan risiko secara kumulatif terhadap outcome kehamilan. Oleh karena itu, pendekatan prakonsepsi pada kelompok ini harus bersifat komprehensif dan terintegrasi (Cassinelli et al., 2024).

C. Komponen Paket Pelayanan Prakonsepsi

Pelayanan prakonsepsi bersifat komprehensif dan multidimensional, meliputi intervensi biomedis, nutrisi, perilaku, psikososial, dan reproduksi.

Tabel 3.1: Intervensi Biomedis Asuhan Prakonsepsi (Sumber: (Dorney & Black, 2024)

Komponen	Subkomponen	Tindakan/ Intervensi	Dasar Fisiologis	Dampak Patologis Jika Tidak Ditangani	Rekomendasi /Dosis
Skrining Penyakit Kronis	Diabetes mellitus	Pemeriksaan HbA1c, kontrol glikemik	Glukosa memengaruhi organogenesis embrio	Cacat kongenital, abortus, makrosomia	Target HbA1c <6,5%
	Hipertensi	Pengukuran tekanan darah, evaluasi organ target	Perfusi uteroplasenta bergantung tekanan darah optimal	IUGR, preeklamsia, stillbirth	Stabil sebelum konsepsi
	Obesitas	Pengukuran BMI, konseling berat badan	Metabolisme & inflamasi memengaruhi implantasi	GDM, preeklamsia, komplikasi persalinan	BB ideal sebelum hamil
	Penyakit kronis lain	Evaluasi komorbid & terapi	Stabilitas sistem organ mendukung kehamilan	Komplikasi maternal-fetal	Optimasi sebelum hamil
Skrining Infeksi	Infeksi wajib	HIV, Hepatitis B/C, sifilis	Patogen dapat transmisi vertikal	Infeksi kongenital, kematian janin	Skrining sebelum hamil
	Infeksi risiko	Klamidia, gonore	Infeksi genital memengaruhi fertilitas	PID, infertilitas	Skrining berbasis risiko
	Infeksi TORCH/CMV	Edukasi & skrining selektif	Virus dapat melewati plasenta	Gangguan neurologis janin	Edukasi higiene
	Imunisasi	Rubella, varisela, dll	Imunitas melindungi janin	Sindrom kongenital	Tunda hamil ≥28 hari pasca vaksin
Kesehatan Reproduksi	Perencanaan kehamilan	Reproductive life plan, konseling	Sinkronisasi kesiapan biologis & sosial	Kehamilan tidak direncanakan	Diskusi aktif
	Riwayat obstetri	Evaluasi kehamilan sebelumnya	Menentukan risiko kehamilan berikutnya	Risiko berulang (preeklamsia, GDM)	Stratifikasi risiko
	Skrining serviks	Pap smear/self-collection	Deteksi dini lesi serviks	Kanker serviks	Sesuai program skrining
	Kesehatan payudara	Pemeriksaan payudara	Deteksi dini kelainan	Keterlambatan diagnosis	Edukasi SADARI
	Kesehatan seksual	Evaluasi fungsi & riwayat seksual	Fungsi reproduksi optimal	Infertilitas, IMS	Konseling

Paparan & Obat	Obat-obatan	Review obat resep & OTC	Obat memengaruhi organogenesis	Teratogenik	Hentikan/ganti obat berisiko
	Lingkungan	Paparan bahan kimia, logam	Endocrine disruptor	Gangguan hormonal & janin	Hindari paparan
Nutrisi terkait biomedis	Asam folat	Suplementasi	Sintesis DNA & penutupan tabung saraf	Neural tube defect	400 mcg/hari (5 mg risiko tinggi)
	Iodium	Suplementasi	Hormon tiroid → perkembangan otak	Gangguan kognitif	150 mcg/hari
	Pembatasan	Vit A, kafein, merkuri	Keseimbangan metabolik	Teratogenik, neurotoksik	Vit A ≤800 mcg, kafein ≤200 mg

Tabel 3.2: Intervensi Nutrisi Asuhan Prakonsepsi (Sumber: (Dorney & Black, 2024))

Komponen	Subkomponen	Intervensi	Dasar Fisiologis	Dampak Patologis Jika Tidak Ditangani	Rekomendasi/Dosis
Suplementasi Mikronutrien	Asam folat	Pemberian suplemen sebelum konsepsi	Sintesis DNA, pembelahan sel, penutupan tabung saraf (hari 21–28)	Neural tube defect (spina bifida, anensefali), gangguan pertumbuhan embrio	400 mcg/hari; 5 mg/hari pada risiko tinggi
	Iodium	Suplementasi iodium	Sintesis hormon tiroid → perkembangan otak janin	Gangguan neurokognitif, hipotiroid janin	150 mcg/hari
	Zat besi	Pemenuhan kebutuhan Fe	Pembentukan hemoglobin & transport oksigen	Anemia → hipoksia janin, BBLR, prematuritas	Sesuai kebutuhan, berbasis skrining
	Kalsium & Vitamin D	Asupan adekuat	Mineralisasi tulang & fungsi neuromuskular	Gangguan pertumbuhan tulang janin	Asupan cukup harian
Pencegahan Anemia	Skrining Hb	Deteksi dini anemia	Menjamin kapasitas oksigen adekuat	Hipoksia jaringan ibu-janin	Pemeriksaan sebelum hamil

	Diet kaya zat besi	Konsumsi makanan tinggi Fe	Mendukung eritropoiesis	Anemia defisiensi besi	Kombinasi dengan vitamin C
	Edukasi nutrisi	Pola makan seimbang	Optimalisasi absorpsi nutrien	Gangguan metabolisme	Hindari teh/kopi berlebih
Perbaikan Status Gizi	Penilaian BMI	Evaluasi status gizi	Status metabolik memengaruhi fertilitas & implantasi	Obesitas: GDM, preeklamsia; Kurus: IUGR, BBLR	Target berat badan ideal
	Diet seimbang	Perbaikan pola makan	Keseimbangan hormon & metabolisme	Gangguan perkembangan janin	Nutrisi makro & mikro adekuat
	Aktivitas fisik	Olahraga teratur	Meningkatkan sensitivitas insulin	Risiko metabolik meningkat	≥150 menit/minggu
Pembatasan Nutrisi	Vitamin A	Pembatasan retinol	Menghindari efek teratogenik	Kelainan kongenital	≤800 mcg/hari
	Kafein	Pembatasan konsumsi	Pengaruh pada sistem saraf & plasenta	Risiko keguguran, gangguan janin	≤200 mg/hari
	Merkuri (ikan tertentu)	Hindari paparan	Neurotoksik pada janin	Gangguan perkembangan otak	Hindari ikan tinggi merkuri

Tabel 3.3: Intervensi Nutrisi Asuhan Prakonsepsi
(Sumber: (Dorney & Black, 2024))

Komponen	Subkomponen	Intervensi	Dasar Fisiologis	Dampak Patologis Jika Tidak Ditangani	Rekomendasi
Berhenti Merokok	Rokok konvensional	Skrining status merokok, konseling berhenti, dukungan terapi	Nikotin → vasokonstriksi; CO → ↓ kapasitas Hb membawa oksigen	Hipoksia janin, BBLR, prematuritas, kematian perinatal	Hentikan total sebelum konsepsi
	Rokok elektronik (vape)	Edukasi risiko dan penghentian	Paparan zat kimia toksik memengaruhi sistem reproduksi	Risiko gangguan perkembangan janin (masih berkembang bukti)	Tidak direkomendasikan
Menghindari Alkohol	Konsumsi alkohol	Skrining (AUDIT-C), edukasi, konseling berhenti	Alkohol melewati plasenta, metabolisme janin terbatas	Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD), gangguan neurologis	Tidak ada batas aman, stop total
Aktivitas Fisik	Aktivitas aerobik	Edukasi olahraga rutin	↑ sensitivitas insulin, regulasi metabolisme	Obesitas, resistensi insulin, komplikasi kehamilan	≥150 menit/minggu
	Latihan otot	Latihan kekuatan & dasar panggul	Mendukung stabilitas otot & fungsi reproduksi	Risiko gangguan muskuloskeletal	Kombinasi latihan rutin
Perilaku Berisiko Lain	NAPZA	Skrining & konseling	Zat psikoaktif memengaruhi perkembangan otak janin	Gangguan neurodevelopmental, ketergantungan neonatal	Hentikan penggunaan
Edukasi & Konseling	Perubahan perilaku	Edukasi berkelanjutan, dukungan sosial	Adaptasi perilaku memengaruhi keseimbangan hormonal	Risiko perilaku tidak sehat berlanjut	Pendekatan individual & berkelanjutan

Tabel 3.4: Intervensi Psikososial Asuhan Prakonsepsi

Komponen	Subkomponen	Intervensi	Dasar Fisiologis	Dampak Patologis Jika Tidak Ditangani	Rekomendasi
Konseling Kesiapan Mental	Skrining kesehatan mental	Anamnesis depresi, kecemasan, stres	Regulasi neuroendokrin (sumbu HPA) memengaruhi hormon reproduksi	Gangguan ovulasi, infertilitas, komplikasi kehamilan	Skrining rutin sebelum konsepsi
	Deteksi kekerasan	Identifikasi intimate partner violence	Stres kronik → ↑ kortisol → gangguan hormonal	Risiko gangguan mental & outcome kehamilan buruk	Skrining sensitif & rahasia
	Konseling psikologis	Edukasi kesiapan mental & coping stress	Stabilitas emosi mendukung keseimbangan hormonal	Perilaku berisiko, kepatuhan rendah	Pendekatan patient-centered
	Rujukan profesional	Psikolog/psikiater bila diperlukan	Intervensi spesifik memperbaiki fungsi mental	Gangguan mental tidak tertangani	Rujuk sesuai indikasi
Dukungan Keluarga	Dukungan pasangan	Libatkan pasangan dalam konseling	Dukungan emosional menurunkan stres	Risiko depresi, kecemasan	Pendekatan family-centered
	Dukungan sosial	Penilaian jejaring sosial	Lingkungan sosial memengaruhi adaptasi stres	Perilaku tidak sehat, isolasi sosial	Perkuat jejaring sosial
	Dukungan ekonomi	Evaluasi akses layanan & finansial	Stabilitas sosial mendukung akses kesehatan	Keterlambatan pelayanan	Identifikasi hambatan akses
	Edukasi keluarga	Penyuluhan kesiapan kehamilan	Lingkungan suportif → keseimbangan psikologis	Kurangnya kesiapan kehamilan	Edukasi berkelanjutan

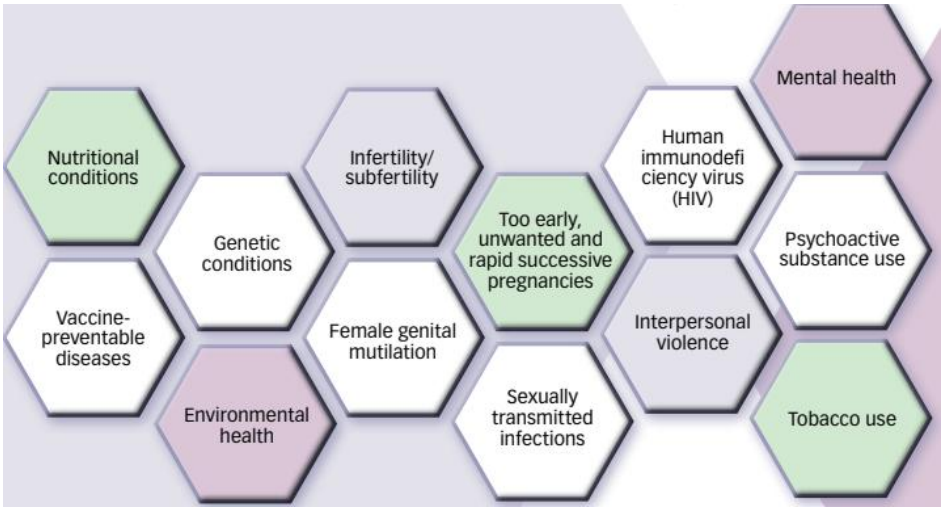
Sumber: (Dorney & Black, 2024)

Tabel 3.5: Intervensi Reproduksi Asuhan Prakonsepsi
(Sumber: (Dorney & Black, 2024)

Komponen	Subkomponen	Intervensi	Dasar Fisiologis	Dampak Patologis Jika Tidak Ditangani	Rekomendasi
Konseling Kontrasepsi	Pemilihan metode	Edukasi jenis, efektivitas, dan keamanan kontrasepsi	Menghambat ovulasi, mengubah mukus serviks & endometrium	Kehamilan tidak direncanakan saat kondisi belum optimal	Gunakan kontrasepsi sampai siap hamil
	Penyesuaian kondisi medis	Pemilihan kontrasepsi sesuai komorbid	Stabilitas kondisi biologis sebelum konsepsi	Risiko komplikasi maternal-fetal	Individualisasi metode
	Waktu penghentian	Edukasi kapan menghentikan kontrasepsi	Pemulihan fungsi ovulasi & siklus menstruasi	Gangguan perencanaan kehamilan	Sesuai jenis kontrasepsi
Perencanaan Kehamilan	Reproductive life plan	Diskusi jumlah & waktu kehamilan	Sinkronisasi kesiapan biologis, nutrisi, dan hormonal	Kehamilan tidak terencana	Diskusi aktif dengan pasien
	Identifikasi niat hamil	Penggunaan tools (misal: One Key Question®)	Membuka intervensi prakonsepsi lebih dini	Terlambat intervensi preventif	Tanyakan rencana kehamilan
	Optimalisasi kondisi	Persiapan kesehatan sebelum konsepsi	Lingkungan intrauterin optimal untuk organogenesis	Cacat kongenital, komplikasi kehamilan	Intervensi sebelum konsepsi
Pengaturan Jarak Kehamilan	Jarak terlalu dekat	Edukasi interval kehamilan	Pemulihan nutrisi & sistem reproduksi	Anemia, BBLR, prematuritas	Hindari jarak terlalu dekat
	Jarak terlalu jauh	Evaluasi risiko obstetri	Perubahan fisiologis maternal	Preeklamsia, komplikasi kehamilan	Perencanaan interval optimal
	Manajemen interval	Penggunaan kontrasepsi untuk pengaturan jarak	Menjaga kesiapan biologis ibu	Risiko kehamilan tidak optimal	Atur jarak kehamilan secara terencana

Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi faktor risiko yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan bayi serta meningkatkan outcome kehamilan secara keseluruhan (Fikire et al., 2024).

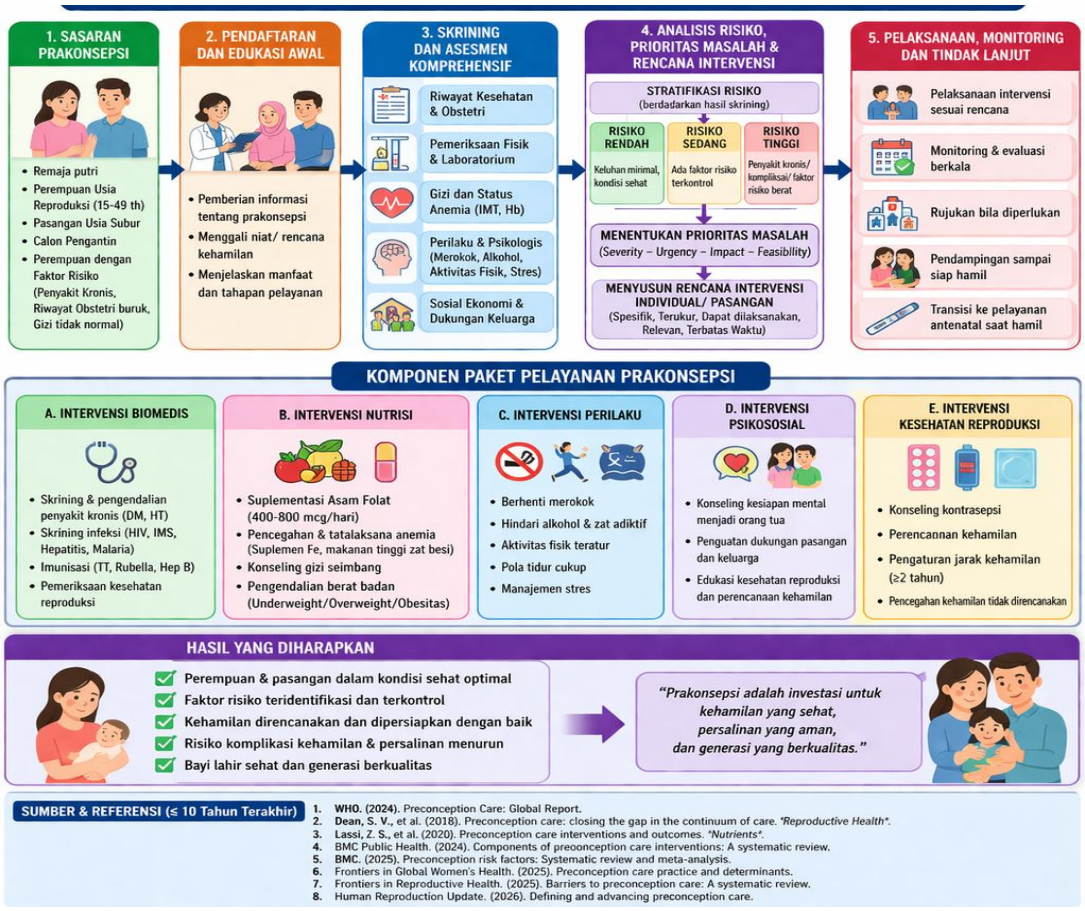
Gambar 3.2: Preconception Care Package



Sumber: (WHO, 2013)

1. Diagram Alur Pelayanan Prakonsepsi

Gambar 3.3: Alur Pelayanan Prakonsepsi



Berikut alur konseptual pelayanan prakonsepsi berbasis praktik kebidanan: Alur ini mencerminkan pendekatan sistematis dalam pelayanan prakonsepsi yang menekankan skrining, analisis risiko, dan intervensi terintegrasi.

Gambar 3.4: Preparation for a Healthy Wanted Pregnancy within a Life-course Approach

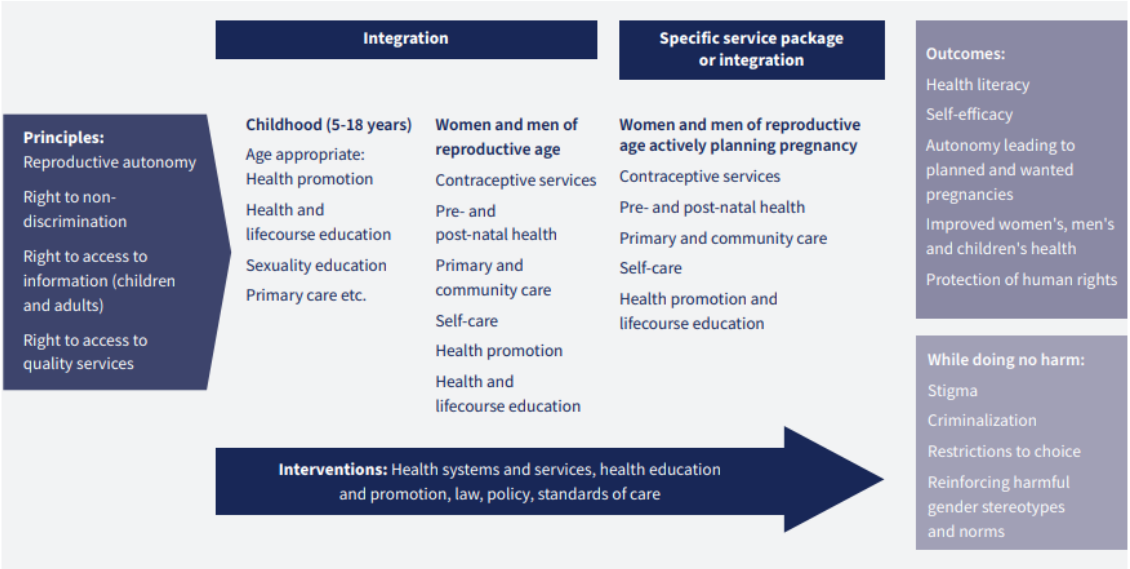


Figure 2: "Preparation for a Healthy Wanted Pregnancy within a Life-course Approach" - example framework discussed in the meeting*
**Note: The framework was suggested by the group and should not be understood as a WHO-endorsed framework on preconception care.*

Sumber: (WHO, 2024)Ref

2. Determinan Kesiapan Prakonsepsi dan Prioritas Masalah

a. Determinan Kesiapan Prakonsepsi

Kesiapan prakonsepsi merupakan kondisi optimal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional.

1) Determinan Biologis
   a) Status gizi
   b) Penyakit kronis
   c) Status imunisasi
2) Determinan Perilaku
   a) Pola makan
   b) Aktivitas fisik
   c) Merokok dan alkohol
3) Determinan Psikologis
   a) Kesiapan mental
   b) Stabilitas emosi
4) Determinan Sosial

a) Pendidikan
b) Dukungan keluarga
c) Status ekonomi

5) Determinan Sistem Kesehatan
a) Akses layanan
b) Ketersediaan tenaga kesehatan

Penelitian menunjukkan bahwa faktor biologis, perilaku, dan sosial saling berinteraksi dan sering muncul secara bersamaan dalam individu, sehingga pendekatan intervensi harus bersifat komprehensif (Cassinelli et al., 2024).

b. Identifikasi Masalah Prakonsepsi

Identifikasi masalah dilakukan melalui:

1) Skrining Komprehensif
a) Riwayat kesehatan
b) Riwayat reproduksi
c) Gaya hidup

2) Analisis Risiko

Contoh:
a) Anemia → risiko BBLR
b) Diabetes → risiko komplikasi kehamilan

3) Stratifikasi Risiko
a) Risiko rendah
b) Risiko sedang
c) Risiko tinggi

Skrining prakonsepsi memungkinkan deteksi dini faktor risiko sehingga dapat dilakukan intervensi sebelum kehamilan terjadi (Fikire et al., 2024).

Tabel. 3.6: Arah Pembaharuan Pelayanan Prakonsepsi

Aspek	WHO 2013	Arah Update 2024–2025
Sasaran	Wanita	Wanita + pria + remaja
Pendekatan	Risk-based	Life-course + system-based
Fokus	Individu	Populasi & sistem
Layanan	Terpisah	Terintegrasi
Peran tenaga kesehatan	Klinis	Multidisiplin

Sumber: (WHO, 2024)

c. Penentuan Prioritas Masalah

Prioritas masalah ditentukan berdasarkan:

1) Tingkat keparahan
2) Dampak terhadap kehamilan
3) Urgensi intervensi
4) Ketersediaan sumber daya

Sebagai contoh:

1) Anemia berat → prioritas tinggi
2) Kurang pengetahuan → prioritas sedang

Pendekatan ini merupakan bagian dari clinical reasoning dalam praktik kebidanan (Fikire et al., 2024).

d. Perencanaan Intervensi Prakonsepsi

Intervensi disusun berdasarkan hasil analisis risiko dan prioritas masalah dengan prinsip **SMART**:

1) Specific

a) Pengertian

Tujuan intervensi harus jelas, terfokus pada masalah utama, dan tidak bersifat umum.

b) Prinsip

Menyebutkan masalah klinis secara spesifik

Mengarah pada perubahan yang diinginkan

Contoh:

"Meningkatkan kesehatan ibu"

"Meningkatkan kadar hemoglobin pada wanita prakonsepsi"

c) Aplikasi dalam Prakonsepsi

- Anemia → peningkatan Hb
- KEK → peningkatan status gizi
- Merokok → penghentian kebiasaan

2) Measurable

a) Pengertian

Tujuan harus memiliki indikator yang dapat diukur secara objektif.

b) Prinsip

- Menggunakan parameter klinis
- Dapat dievaluasi dengan pemeriksaan

  Contoh Indikator
  - Hb ≥ 12 g/dL
  - LILA ≥ 23,5 cm

- IMT normal (18,5–24,9)
- 0 batang rokok/hari

c) Aplikasi

Memudahkan evaluasi keberhasilan intervensi

3) Achievable

a) Pengertian

Tujuan harus realistis sesuai kondisi pasien dan sumber daya layanan**.**

b) Prinsip

- Sesuai kemampuan pasien
- Mempertimbangkan akses layanan
- Tidak terlalu tinggi atau sulit dicapai

  Contoh
  - Peningkatan Hb dalam 3 bulan
  - Target Hb normal dalam 1 minggu

c) Aplikasi

Disesuaikan dengan fasilitas Puskesmas dan kepatuhan pasien

4) Relevant

a) Pengertian

Tujuan harus berkaitan langsung dengan risiko prakonsepsi dan outcome kehamilan.

b) Prinsip

- Fokus pada masalah prioritas
- Berdampak terhadap ibu dan janin

  Contoh:
  - Anemia → relevan karena meningkatkan risiko BBLR
  - Merokok → relevan karena meningkatkan risiko premature

c) Aplikasi

Menghindari intervensi yang tidak prioritas.

5) Time-bound

a) Pengertian

Setiap tujuan harus memiliki batas waktu pencapaian yang jelas**.**

b) Prinsip

- Menentukan periode evaluasi
- Memberikan target waktu realistis

  Contoh

- Hb normal dalam 3 bulan
- berhenti merokok dalam 1–3 bulan
- peningkatan status gizi dalam 3–6 bulan

c) Aplikasi

Mendukung monitoring dan follow-up

Penelitian menunjukkan bahwa intervensi prakonsepsi yang terintegrasi (biomedis, perilaku, sosial) lebih efektif dibandingkan intervensi tunggal. (Fikire et al., 2024).

e. Implikasi dalam Praktik Kebidanan

Bidan memiliki peran utama dalam:

1) Melakukan skrining prakonsepsi
2) Mengidentifikasi faktor risiko
3) Menentukan prioritas masalah
4) Menyusun rencana intervensi
5) Melakukan rujukan

Peran ini menempatkan bidan sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan reproduksi berbasis preventif.

D. Aktivitas 1 — Knows How

Skenario Kasus

Seorang perempuan usia 29 tahun datang ke Puskesmas bersama suaminya untuk konsultasi perencanaan kehamilan. Hasil pengkajian:

Anamnesis

1. Riwayat penyakit: diabetes mellitus sejak 3 tahun
2. Riwayat obstetri: 1 kali abortus
3. Pola makan tidak teratur
4. Aktivitas fisik rendah

Pemeriksaan

1. Hb: 10,2 g/dL
2. IMT: 29 (overweight)
3. HbA1c: 7,8%

Faktor pasangan

1. Suami merokok 1 bungkus/hari

Pertanyaan

1. Tentukan kategori risiko prakonsepsi!
2. Identifikasi masalah prioritas!

3. Susun perencanaan intervensi berbasis SMART!

E. Rubrik Penilaian (Untuk Dosen)

Tabel Penilaian SMART

Komponen	Kriteria Penilaian	Skor
Stratifikasi risiko	Tepat (risiko tinggi)	2
Identifikasi masalah	Lengkap & prioritas benar	3
Specific	Tujuan jelas & sesuai masalah	2
Measurable	Indikator terukur	2
Achievable	Realistis	2
Relevant	Sesuai risiko	2
Time-bound	Ada batas waktu	2
Total		**15**

Interpretasi Skor

Skor	Kategori
13–15	Sangat baik
10–12	Baik
<10	Perlu perbaikan

F. Aktivitas 2 — Shows How

TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	**Komponen**	**Isi**
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Pranikah
3	Kasus	Perencanaan Intervensi Prakonsepsi dengan SMART
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat merencanakan Intervensi Prakonsepsi berbasis SMART
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional

No.	Komponen	Isi
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, usia 24 tahun, P0A0, datang ke Puskesmas untuk merencanakan kehamilan. Hasil anamnesis: belum pernah hamil, pola makan 1x/hari menu seadanya, sering lelah dan lesu, suami merokok. Hasil pemeriksaan: KU Baik, kesadaran komposmentis, TD 120/80 mmHg, N 80 x/menit, P 20 x/menit, S 36,8°C, konjungtiva pucat, Hb: 10 g/dL, IMT 18. TUGAS Identifikasi masalah pasien Tentukan prioritas masalah Susun rencana intervensi prakonsepsi dengan pendekatan SMART Sampaikan rencana kepada pasien secara komunikatif
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS

No.	Komponen	Isi
		Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. INSTRUKSI TAMBAHAN Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: PS berperan sebagai pasien yang ingin merencanakan kehamilan. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dengan scenario. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif.
9	Dialog PS	A. Identitas Pasien Nama: Ny. Rina Usia: 27 tahun Status: Menikah (1 tahun) Pendidikan: SMA Pekerjaan: Ibu rumah tangga B. Keluhan Utama "Saya ingin merencanakan kehamilan, Bu." C. Informasi Dasar (Diberikan jika ditanya) Riwayat Kesehatan Tidak ada penyakit kronis Tidak sedang konsumsi obat Riwayat Reproduksi Belum pernah hamil Menstruasi teratur Pola Makan Makan 2 kali sehari Jarang makan sayur dan daging

No.	Komponen	Isi
		Gaya Hidup Jarang olahraga Tidak merokok Faktor Pasangan Suami merokok ±1 bungkus/hari D. Data Pemeriksaan (Jika diminta mahasiswa) Hb: 10 g/dL IMT: 18 (kurus) E. Sikap & Perilaku Pasien Ramah tetapi kurang paham tentang kesehatan prakonsepsi Sedikit khawatir saat mendengar kata "anemia" Kooperatif jika dijelaskan dengan baik F. Respon Pasien terhadap Pertanyaan Mahasiswa Jika ditanya tentang pola makan "Saya memang jarang makan sayur, Bu, kadang cuma makan nasi sama mie." Jika ditanya tentang suami "Suami saya merokok, tapi di luar rumah biasanya." Jika diberi edukasi anemia "Oh, jadi itu bisa berbahaya ya untuk kehamilan?" Jika ditanya kesiapan berubah "Saya mau mencoba memperbaiki pola makan, Bu."
10	Kebutuhan manikin	Tidak ada
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: Mengganti lembar dokumentasi SMART Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1 Meja dan 2 buah kursi Lembar dokumentasi kosong (SMART) Lembar balik konseling prakonsepsi
13	Penulis	Bdn. Feling Polwandari, M.Kes.
14	Referensi	Dorney, E., & Black, K. (2024). Preconception Care. Australian Journal of General Practice (AJGP), 53(11), 805–812. https://doi.org/10.31128/AJGP-08-23-6927

G. Daftar Pustaka

Carter, T., Schoenaker, D., Adams, J., & Steel, A. (2023). Paternal Preconception Modifiable Risk Factors for Adverse Pregnancy and Offspring Outcomes : A Review Of Contemporary Evidence from Observational Studies. *BMC Public Health*, 1–44. https://doi.org/10.1186/s12889-023-15335-1

Cassinelli, E. H., Mckinley, M. C., Kent, L., Eastwood, K. A., & Schoenaker, D. A. J. M. (2024). Preconception Health and Care Policies , Strategies and Guidelines in The UK and Ireland : A Scoping Review. *BMC Public Health*, *24*(1662), 1–15. https://doi.org/10.1186/s12889-024-19188-0

Dean, S. V, Lassi, Z. S., Imam, A. M., & Bhutta, Z. A. (2014). Preconception Care : Closing the Gap in The Continuum of Care to Accelerate Improvements in Maternal, Newborn and Child Health. *Reproductive Health*, *11*(Suppl 3), S1. https://doi.org/10.1186/1742-4755-11-S3-S1

Dennis, C.-L., Abbass-, J., Birken, C., Grantham, A. D.-, Goyal, D., Singla, D., & Letourneau, N. (2024). Influence of Paternal Preconception Health on Pregnancy , Intrapartum , Postpartum and Early Childhood Outcomes : Protocol for A Parallel Scoping Review. *BMJ Journals*, *14*, 1–4. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-084209

Dorney, E., & Black, K. (2024). Preconception Care. *Australian Journal of General Practice (AJGP)*, *53*(11), 805–812. https://doi.org/10.31128/AJGP-08-23-6927

Du, L., La, X., Zhu, L., Jiang, H., Xu, B., Chen, A., & Li, M. (2021). Utilization of Preconception Care and Its Impacts on Health Behavior Changes Among Expectant Couples in Shanghai. *BMC Pregnancy and Childbirth*, *21*(491), 1–8. https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12884-021-03940-0 RESEARCH

Fikire, B., Sedoro, T., Hasen, H., & Mekango, D. E. (2024). Preconception Care Use and Associated Factors Among HIV Positive Reproductive Age Women Attending ART Clinics at Public Hospitals in The Hadiya Zone , Southern Ethiopia : A Mixed Method Approach. *BMC Public Health*, *24*(2116). https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12889-024-19653-w

Kurniawati, W., Afiyanti, Y., Nasution, L. A., & Juliastuti, D. (2023). Preconception Care Knowledge and Information Delivery Modes Among Adolescent Girls and Women: A Scoping Review. *Korean J Women Health Nurs*, *29*(1), 12–19. https://doi.org/https://doi.org/10.4069/kjwhn.2023.02.28

Mason, E., Chandra-mouli, V., Baltag, V., Christiansen, C., Lassi, Z. S., & Bhutta, Z. A. (2014). Preconception Care : Advancing From 'Important to do and Can Be Done' to ' Is Being Done and Is Making A Difference .' *Reproductive Health*, *11*(Suppl 3), S8. https://doi.org/10.1186/1742-4755-11-S3-S8

Padhani, Z. A., Tessema, G. A., Avery, J. C., Rahim, K. A., Boyle, J. A., & Meherali, S. (2024). Preconception Care Interventions for Adolescents and Young Adults to Prevent Adverse Maternal and Child Health Outcomes : Protocol for an

Evidence Gap Map Corresponding Author : *JMIR RESEARCH PROTOCOLS*, *13*(May), 1–8. https://doi.org/10.2196/56052

WHO. (2013). Preconception Care : Maximizing The Gains for Maternal and Child Health Facts. *Department of Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health*.

WHO. (2024). *Reframing Care and Services to Improve Preconception Health Meeting Report* (Issue May).

BAB 4

KONSELING PRAKONSEPSI: PERENCANAAN KEHAMILAN, KB PRAHAMIL, DAN KESIAPAN KELUARGA

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Bab ini mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Kebidanan sebagai berikut:

CPL-1

Menguasai konsep teoritis kesehatan reproduksi perempuan sepanjang siklus kehidupan secara komprehensif.

CPL-2

Mampu memberikan asuhan kebidanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai kewenangan bidan berdasarkan evidence based practice.

CPL-3

Mampu melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara efektif, empatik, dan profesional.

CPL-4

Mampu melakukan pengkajian, analisis, penegakan diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi asuhan kebidanan secara profesional dan bertanggung jawab.

CPL-5

Mampu mengintegrasikan aspek biologis, psikologis, sosial, budaya, spiritual, dan etik dalam pelayanan kebidanan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari Bab 6, mahasiswa mampu:

CPMK-1

Menjelaskan konsep dasar konseling prakonsepsi.

CPMK-2

Menjelaskan perubahan fisiologis yang terjadi pada masa prakonsepsi.

CPMK-3

Menganalisis kebutuhan kesehatan perempuan dan pasangan pada masa prakonsepsi.

CPMK-4

Mengidentifikasi tanda normal dan tanda bahaya pada masa prakonsepsi.

CPMK-5

Melaksanakan asuhan kebidanan pada konseling prakonsepsi sesuai standar pelayanan kebidanan.

CPMK-6

Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perencanaan kehamilan, KB prahamil, nutrisi prakonsepsi, dan kesiapan keluarga.

CPMK-7

Melakukan dokumentasi asuhan kebidanan pada masa prakonsepsi menggunakan format dokumentasi yang tepat.

CPMK-8

Menerapkan pendekatan agama, budaya, dan keluarga dalam konseling prakonsepsi.

SUB-CPMK

Setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini mahasiswa mampu:

1. menjelaskan pengertian konseling prakonsepsi;
2. menjelaskan tujuan pelayanan prakonsepsi;
3. menjelaskan konsep dasar kesehatan prakonsepsi;
4. menjelaskan perubahan fisiologis masa prakonsepsi;
5. menjelaskan proses ovulasi dan masa subur;
6. menjelaskan kebutuhan nutrisi pada masa prakonsepsi;
7. menjelaskan pentingnya skrining kesehatan sebelum kehamilan;
8. mengidentifikasi faktor risiko sebelum kehamilan;
9. mengidentifikasi tanda normal dan tanda bahaya masa prakonsepsi;
10. menjelaskan metode KB prahamil;
11. menjelaskan kesiapan fisik dan psikologis keluarga;
12. melakukan pengkajian kesehatan prakonsepsi;
13. melakukan konseling prakonsepsi;
14. melakukan dokumentasi asuhan kebidanan prakonsepsi.

Uraian Materi

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan adalah melalui pelayanan prakonsepsi.

Masa prakonsepsi merupakan periode sebelum terjadinya konsepsi yang menjadi fase penting dalam menentukan keberhasilan kehamilan dan kesehatan bayi yang akan dilahirkan. Pada masa ini perempuan dan pasangan mempersi apkan kondisi kesehatan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual agar siap menghadapi kehamilan.

Pelayanan prakonsepsi bertujuan untuk mengidentifikasi dan memodifikasi faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Faktor risiko seperti anemia, diabetes melitus, hipertensi, obesitas, kekurangan gizi, infeksi menular seksual, kebiasaan merokok, serta kurangnya kesiapan mental dapat meningkatkan komplikasi selama kehamilan dan persalinan.

Penelitian menunjukkan bahwa pelayanan prakonsepsi yang optimal dapat menurunkan risiko komplikasi maternal, meningkatkan kesehatan ibu, memperbaiki status gizi sebelum kehamilan, dan meningkatkan kualitas kesehatan bayi yang akan dilahirkan.

Bidan memiliki peran penting dalam pelayanan prakonsepsi melalui:

1. pengkajian kesehatan;
2. deteksi dini faktor risiko;
3. edukasi kesehatan reproduksi;
4. konseling perencanaan kehamilan;
5. konseling keluarga berencana;
6. pendampingan keluarga sebelum kehamilan.

Pelayanan kebidanan prakonsepsi harus dilakukan secara komprehensif, evidence based, serta mempertimbangkan aspek agama, budaya, dan kondisi sosial masyarakat.

B. Definisi Konseling Prakonsepsi

Konseling prakonsepsi adalah proses pemberian bantuan, informasi, edukasi, dan dukungan kepada perempuan usia reproduksi dan pasangannya sebelum kehamilan terjadi untuk mempersiapkan kondisi kesehatan optimal sehingga dapat tercapai kehamilan yang sehat dan aman.

Menurut World Health Organization (WHO), preconception care merupakan intervensi biomedis, perilaku, dan sosial yang diberikan kepada perempuan dan pasangan sebelum konsepsi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi.

Konseling prakonsepsi meliputi:

1. pengkajian kesehatan;
2. identifikasi faktor risiko;
3. edukasi nutrisi;
4. perencanaan kehamilan;
5. pengaturan jarak kehamilan;
6. kesiapan psikologis keluarga;
7. promosi gaya hidup sehat.

C. Tujuan Konseling Prakonsepsi

Tujuan pelayanan prakonsepsi meliputi:

1. meningkatkan kesehatan perempuan sebelum kehamilan;
2. mengurangi risiko komplikasi kehamilan;
3. mencegah kelainan kongenital pada bayi;
4. meningkatkan kesiapan pasangan menjadi orang tua;
5. meningkatkan status gizi sebelum kehamilan;
6. mencegah kehamilan risiko tinggi;
7. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.

D. Konsep Dasar Masa Prakonsepsi

Masa prakonsepsi merupakan periode sebelum terjadinya pembuahan yang dimulai sejak pasangan merencanakan kehamilan hingga terjadinya konsepsi.

Konsep pelayanan prakonsepsi menekankan bahwa kondisi kesehatan perempuan sebelum hamil akan mempengaruhi:

1. kesuburan;
2. pertumbuhan embrio;
3. perkembangan janin;
4. kesehatan ibu selama kehamilan;
5. kesehatan bayi setelah lahir.

Pelayanan prakonsepsi tidak hanya ditujukan kepada perempuan tetapi juga pasangan karena kesehatan laki-laki turut mempengaruhi kualitas reproduksi.

E. Perubahan Fisiologis pada Masa Prakonsepsi

1. Siklus Menstruasi

Siklus menstruasi normal berlangsung 21–35 hari. Siklus menstruasi terdiri dari:

a. fase menstruasi;
b. fase proliferasi;
c. fase ovulasi;
d. fase sekresi.

Siklus menstruasi yang teratur menunjukkan fungsi hormonal reproduksi yang baik.

2. Ovulasi

Ovulasi merupakan proses pelepasan ovum matang dari ovarium. Ovulasi biasanya terjadi sekitar 14 hari sebelum menstruasi berikutnya.

Tanda ovulasi:

a. peningkatan lendir serviks;
b. peningkatan suhu basal tubuh;
c. nyeri ringan pada perut bawah.

3. Perubahan Hormonal

Hormon reproduksi yang berperan:

a. Follicle Stimulating Hormone (FSH);
b. Luteinizing Hormone (LH);
c. estrogen;
d. progesteron.

Ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan gangguan kesuburan.

4. Status Nutrisi

Status gizi yang baik sangat penting untuk:

a. mendukung kesuburan;
b. mempersiapkan kehamilan;
c. mencegah komplikasi maternal.

F. Kebutuhan pada Masa Prakonsepsi

1. Kebutuhan Fisik

a. status gizi baik;
b. berat badan ideal;
c. bebas penyakit kronis;
d. kesehatan reproduksi optimal.

2. Kebutuhan Psikologis

a. kesiapan mental menjadi orang tua;
b. kemampuan mengelola stres;
c. hubungan pasangan harmonis.

3. Kebutuhan Sosial

a. dukungan keluarga;

b. dukungan lingkungan;
c. akses pelayanan kesehatan.

4. Kebutuhan Spiritual

a. kesiapan spiritual;
b. nilai agama;
c. kesiapan tanggung jawab keluarga.

G. Tanda Normal Masa Prakonsepsi

Tanda normal meliputi:

1. siklus menstruasi teratur;
2. status gizi baik;
3. tidak terdapat penyakit kronis;
4. tidak terdapat gangguan reproduksi;
5. kesiapan mental dan emosional baik.

H. Tanda Bahaya Masa Prakonsepsi

Tanda bahaya meliputi:

1. anemia;
2. hipertensi;
3. diabetes melitus;
4. obesitas;
5. infeksi menular seksual;
6. gangguan menstruasi;
7. riwayat keguguran berulang;
8. konsumsi alkohol dan rokok.

I. Tabel Skrining Prakonsepsi

Tabel Skrining Kesehatan Prakonsepsi

Pemeriksaan	Tujuan	Tindakan Lanjut
Pemeriksaan tekanan darah	mendeteksi hipertensi	pengobatan dan kontrol
Pemeriksaan Hb	mendeteksi anemia	suplementasi zat besi
Pemeriksaan gula darah	skrining diabetes	pengelolaan diabetes
Tes IMS	mendeteksi infeksi menular seksual	terapi antibiotik
Pemeriksaan golongan darah	identifikasi rhesus	konseling

Skrining genetik	mendeteksi kelainan genetik	konseling genetik

Tabel Nutrisi pada Masa Prakonsepsi

Nutrisi	Manfaat	Sumber
Asam folat	mencegah cacat tabung saraf	sayuran hijau
Zat besi	mencegah anemia	daging, hati
Kalsium	pembentukan tulang	susu
Protein	pertumbuhan sel	telur, ikan
Vitamin D	kesehatan tulang	sinar matahari

Asam folat direkomendasikan minimal 400 mcg per hari sebelum kehamilan untuk mencegah cacat tabung saraf pada bayi.

Tabel Metode KB Prahamil

Metode	Cara Kerja	Kelebihan
Pil KB	hormon estrogen dan progesteron	efektif
Kondom	menghalangi sperma	mencegah IMS
Suntik KB	hormon progesteron	praktis
IUD	menghambat implantasi	jangka panjang
Implan	hormon progesteron	efektif

KB prahamil digunakan untuk menunda kehamilan sampai pasangan siap secara fisik dan psikologis.

J. Asuhan Kebidanan pada Konseling Prakonsepsi

1. Pengkajian

Meliputi:

a. riwayat kesehatan;
b. riwayat obstetri;
c. status nutrisi;
d. gaya hidup;
e. kesehatan mental;
f. riwayat keluarga.

2. Diagnosis Kebidanan

Contoh:

a. risiko anemia;
b. kurang pengetahuan;
c. risiko kehamilan tinggi.

3. Perencanaan

Meliputi:

a. edukasi kesehatan;
b. konseling nutrisi;
c. perencanaan kehamilan;
d. pengaturan KB.

4. Implementasi

Bidan memberikan:

a. konseling;
b. edukasi;
c. skrining kesehatan;
d. rujukan bila diperlukan.

5. Evaluasi

Menilai:

a. peningkatan pengetahuan;
b. perubahan perilaku sehat;
c. kesiapan pasangan.

K. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Materi KIE meliputi:

1. usia ideal kehamilan;
2. jarak kehamilan;
3. nutrisi prakonsepsi;
4. gaya hidup sehat;
5. kesehatan mental;
6. kesiapan keluarga;
7. KB prahamil.

Prinsip KIE:

1. menggunakan bahasa sederhana;
2. menghargai budaya dan agama;
3. melibatkan pasangan;

4. komunikasi empatik.

L. Dokumentasi Asuhan Prakonsepsi

Dokumentasi dapat menggunakan format SOAP:

S (Subjective)

Data subjektif klien.

O (Objective)

Hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium.

A (Assessment)

Analisis masalah kebidanan.

P (Plan)

Rencana tindakan dan edukasi.

Dokumentasi penting sebagai:

1. bukti pelayanan;
2. evaluasi asuhan;
3. komunikasi antar tenaga kesehatan.

M. Tinjauan Agama dan Budaya

Agama dan budaya mempengaruhi keputusan pasangan dalam merencanakan kehamilan.

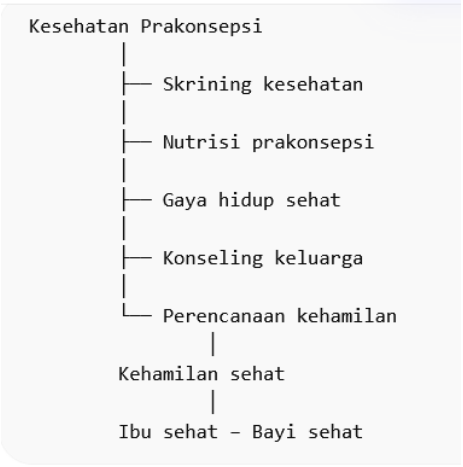
Dalam berbagai agama, menjaga kesehatan sebelum kehamilan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga dan keturunan.

Bidan perlu:

1. menghormati keyakinan klien;
2. memahami budaya lokal;
3. memberikan edukasi berbasis evidence based practice;
4. menggunakan komunikasi yang empatik.

Pendekatan budaya dan agama yang baik akan meningkatkan keberhasilan konseling prakonsepsi.

Diagram Konsep Prakonsepsi



N. Studi Kasus Vignette

Seorang perempuan usia 24 tahun datang ke praktik bidan bersama suaminya dengan rencana hamil dalam waktu dekat. Klien mengeluhkan mudah lelah dan pusing. Hasil pemeriksaan menunjukkan Hb 9,5 g/dL dan IMT 17 kg/m². Klien mengatakan sering terlambat makan dan jarang mengonsumsi makanan bergizi.

O. Pertanyaan

1. Identifikasi masalah kesehatan pada kasus di atas.
2. Apa faktor risiko yang ditemukan pada kasus tersebut?
3. Apa dampak kondisi tersebut terhadap kehamilan?
4. Asuhan kebidanan apa yang perlu diberikan?
5. Edukasi apa yang perlu diberikan kepada klien dan pasangan?

P. Latihan Soal Vignette

Vignette 1

Seorang perempuan usia 23 tahun datang ke PMB bersama suaminya untuk berkonsultasi mengenai rencana kehamilan. Klien mengeluhkan sering lemas dan pusing. Hasil pemeriksaan menunjukkan Hb 9 g/dL dan IMT 17 kg/m².

Pertanyaan

1. Identifikasi masalah kesehatan pada kasus di atas.
2. Apa risiko yang dapat terjadi apabila klien langsung hamil?
3. Asuhan kebidanan apa yang perlu diberikan pada masa prakonsepsi?

4. Edukasi nutrisi apa yang perlu diberikan kepada klien?

Vignette 2

Seorang perempuan usia 29 tahun datang ke klinik untuk program kehamilan. Klien memiliki riwayat hipertensi sejak 3 tahun lalu dan masih rutin mengonsumsi obat antihipertensi.

Pertanyaan

1. Faktor risiko apa yang ditemukan pada kasus di atas?
2. Pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan sebelum kehamilan?
3. Jelaskan peran bidan dalam konseling prakonsepsi pada kasus tersebut.
4. Edukasi apa yang perlu diberikan kepada pasangan?

Vignette 3

Seorang perempuan usia 25 tahun menikah sejak satu tahun yang lalu dan ingin segera memiliki anak. Klien mengatakan tidak mengetahui masa suburnya dan belum pernah mendapatkan edukasi tentang perencanaan kehamilan.

Pertanyaan

1. Jelaskan masalah utama pada kasus tersebut.
2. Bagaimana cara menentukan masa subur pada perempuan dengan siklus menstruasi normal?
3. Informasi apa saja yang perlu diberikan oleh bidan?

Vignette 4

Seorang perempuan usia 31 tahun datang bersama suaminya untuk konsultasi prakonsepsi. Klien memiliki berat badan 82 kg dengan tinggi badan 154 cm. Klien mengaku sering mengonsumsi makanan cepat saji dan jarang berolahraga.

Pertanyaan

1. Hitung IMT klien dan interpretasikan hasilnya.
2. Apa risiko obesitas terhadap kehamilan?
3. Intervensi apa yang dapat diberikan oleh bidan?
4. Edukasi gaya hidup sehat apa yang sesuai pada kasus tersebut?

Vignette 5

Seorang perempuan usia 27 tahun datang ke PMB untuk konsultasi kehamilan. Klien tidak memiliki keluhan, namun suaminya merupakan perokok aktif dan sering merokok di dalam rumah.

Pertanyaan

1. Apa dampak paparan rokok terhadap kesehatan reproduksi?
2. Jelaskan peran bidan dalam memberikan konseling pada pasangan tersebut.
3. Edukasi apa yang perlu diberikan untuk meningkatkan kesiapan keluarga sehat?

Contoh Soal HOTS (Higher Order Thinking Skill)

Seorang perempuan usia 30 tahun memiliki riwayat diabetes melitus dan ingin merencanakan kehamilan. Klien mengaku tidak rutin mengontrol gula darahnya. Apakah prioritas tindakan bidan pada kasus tersebut?

A. Menganjurkan segera hamil

B. Memberikan suplemen zat besi

C. Merujuk untuk pengendalian diabetes sebelum kehamilan

D. Menyarankan penggunaan kontrasepsi permanen

Jawaban: **C. Merujuk untuk pengendalian diabetes sebelum kehamilan**

Q. Rangkuman Materi

Konseling prakonsepsi merupakan pelayanan penting dalam kesehatan reproduksi untuk mempersiapkan pasangan sebelum kehamilan. Pelayanan ini meliputi pengkajian kesehatan, edukasi nutrisi, skrining faktor risiko, perencanaan kehamilan, KB prahamil, kesiapan keluarga, serta pendekatan budaya dan agama.

Bidan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif melalui asuhan kebidanan yang komprehensif, evidence based, profesional, dan berpusat pada kebutuhan perempuan dan keluarga.

R. Daftar Pustaka

Dean, S.V., Lassi, Z.S., Imam, A.M. and Bhutta, Z.A. (2019) 'Preconception care: closing the gap in the continuum of care to accelerate improvements in maternal, newborn and child health', *The Lancet Global Health*, 7(7), pp. e821–e822.

Dorney, E. and Black, K. (2024) 'Preconception care', *Australian Journal of General Practice*, 53(11), pp. 845–851.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022) *Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Kemenkes RI.

Stephenson, J., Heslehurst, N., Hall, J., Schoenaker, D.A.J.M., Hutchinson, J., Cade, J.E., Poston, L., Barrett, G., Crozier, S.R., Barker, M. and Kumaran, K. (2019) 'Before the beginning: nutrition and lifestyle in the preconception period and its importance for future health', *The Lancet*, 391(10132), pp. 1830–1841.

World Health Organization (WHO) (2022) *Preconception Care: Maximizing the Gains for Maternal and Child Health*. Geneva: WHO.

BAB 5

PELAYANAN BERBASIS SEKOLAH DAN KOMUNITAS: JEJARING, EDUKASI, DAN PENCATATAN-PELAPORAN

Pendahuluan

Kesehatan reproduksi remaja merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan kesehatan masyarakat, mengingat remaja merupakan kelompok usia yang berada pada fase transisi dengan kerentanan tinggi terhadap berbagai masalah kesehatan, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Permasalahan seperti anemia, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan menstruasi, perilaku seksual berisiko, serta rendahnya akses terhadap layanan kesehatan yang ramah remaja masih menjadi tantangan utama di berbagai wilayah.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pelayanan kesehatan yang berbasis fasilitas kesehatan saja belum cukup efektif dalam menjangkau remaja secara optimal. Remaja cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan sekolah dan komunitas, sehingga pendekatan berbasis sekolah dan masyarakat menjadi strategi yang lebih relevan dan kontekstual. Penelitian oleh Saparini, Simbolon, dan Ningsih (2023) menunjukkan bahwa layanan kesehatan reproduksi yang terintegrasi dalam lingkungan sekolah mampu meningkatkan akses informasi dan pemanfaatan layanan oleh remaja secara signifikan. Hal ini diperkuat oleh temuan Yukizali et al. (2024) yang menyatakan bahwa lingkungan sosial, khususnya teman sebaya dan institusi pendidikan, memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku kesehatan remaja.

Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung upaya promotif dan preventif melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Namun demikian, implementasi UKS di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti kurangnya inovasi program, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya keterlibatan lintas sektor (Fakhrurozi, 2022). Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan berbasis jejaring yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan, guru, orang tua, serta masyarakat.

Hasil penelitian Sari, Gunarmi, dan Hastuti (2024) menunjukkan bahwa pemberdayaan remaja melalui program Duta UKS sebagai peer educator merupakan salah satu strategi efektif dalam meningkatkan literasi kesehatan reproduksi remaja. Pendekatan

ini memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih terbuka dan efektif, karena remaja cenderung lebih nyaman berdiskusi dengan teman sebaya. Selain itu, keterlibatan aktif remaja dalam program juga mampu meningkatkan rasa kepemilikan (sense of ownership) terhadap program kesehatan yang dijalankan.

Dalam implementasinya, pelayanan berbasis sekolah dan komunitas tidak hanya memerlukan perencanaan program yang baik, tetapi juga sistem pencatatan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi yang sederhana namun efektif. Pencatatan dan pelaporan yang baik menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data, sedangkan monitoring dan evaluasi berperan dalam memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas program. Penelitian Wijaya et al. (2025) menunjukkan bahwa program kesehatan remaja yang didukung dengan sistem monitoring dan evaluasi yang baik memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, Bab 14 ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai perancangan layanan berbasis sekolah dan komunitas, termasuk penguatan jejaring, peran pemangku kepentingan, prinsip inklusivitas, serta sistem pencatatan, pelaporan, dan monitoring evaluasi yang sederhana.

Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah mempelajari Bab 14 ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan konsep pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbasis sekolah dan komunitas secara komprehensif melalui pendekatan jejaring, edukasi, serta pencatatan dan pelaporan yang sederhana, sehingga dapat mendukung pengelolaan program kesehatan yang efektif, berkelanjutan, dan berbasis data.

Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbasis sekolah dan komunitas.
2. Mengidentifikasi kebutuhan kesehatan reproduksi remaja melalui analisis situasi yang sederhana.
3. Merancang program pelayanan berbasis sekolah/komunitas dengan mempertimbangkan prinsip jejaring dan kolaborasi lintas sektor.
4. Mengidentifikasi dan menjelaskan peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program kesehatan remaja.
5. Menerapkan prinsip inklusivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja.
6. Menyusun rencana operasional program secara sistematis dan realistis.

7. Menjelaskan prinsip dan pentingnya pencatatan serta pelaporan dalam program kesehatan berbasis sekolah dan komunitas.
8. Melakukan pencatatan dan pelaporan sederhana sesuai standar program kesehatan remaja.
9. Melaksanakan monitoring program secara berkala menggunakan indikator sederhana.
10. Melakukan evaluasi program dan menginterpretasikan hasilnya untuk perbaikan layanan berbasis data.

Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal serta hak kesehatan reproduksi dalam pelayanan remaja dan prakonsepsi.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan konseling ramah remaja yang berpusat pada klien, sensitif budaya, dan menjaga kerahasiaan.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-5
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan, perlindungan, dan rujukan aman dalam isu reproduksi remaja/prakonsepsi (termasuk IMS/HIV dan kekerasan berbasis gender).	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian, analisis masalah, dan perencanaan intervensi promotif–preventif pada isu kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi berbasis evidence.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Merancang dan melaksanakan edukasi kesehatan serta pemberdayaan individu/keluarga/komunitas untuk pencegahan masalah reproduksi dan stunting antar generasi.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Mengelola dokumentasi, pencatatan–pelaporan, jejaring layanan, dan refleksi perbaikan mutu dalam layanan remaja dan prakonsepsi.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep, determinan, serta kerangka etik–legal layanan kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi sebagai dasar pengambilan keputusan.
CPMK-2	Menganalisis pertumbuhan–perkembangan remaja dan faktor biopsikososial yang memengaruhi risiko serta kebutuhan layanan kesehatan reproduksi.
CPMK-3	Menerapkan pemahaman anatomi–fisiologi reproduksi, kesehatan menstruasi, dan edukasi seksualitas komprehensif sesuai tahap usia untuk promosi kesehatan.
CPMK-4	Melaksanakan komunikasi dan konseling ramah remaja/prakonsepsi secara aman (kerahasiaan, informed choice), termasuk edukasi, skrining risiko awal, dan rujukan sesuai alur layanan.
CPMK-5	Merancang intervensi promotif–preventif terkait gizi, anemia/KEK/obesitas, kesehatan mental, dan faktor risiko lain untuk pencegahan masalah reproduksi dan stunting antar generasi.
CPMK-6	Melakukan skrining prakonsepsi dan menyusun rencana intervensi serta tindak lanjut terkait imunisasi, penyakit kronis, penggunaan obat, dan kebiasaan berisiko.
CPMK-7	Mengorganisasi layanan berbasis sekolah/komunitas melalui jejaring, pencatatan–pelaporan, monitoring–evaluasi sederhana, dan pemanfaatan evidence untuk perbaikan layanan.

Capaian pembelajaran pada Bab 14 ini mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), yaitu Mengorganisasi layanan berbasis sekolah/komunitas melalui jejaring, pencatatan–pelaporan, monitoring–evaluasi sederhana, dan pemanfaatan evidence untuk perbaikan layanan.

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Aspek Pengetahuan (Knowledge)

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbasis sekolah dan komunitas, termasuk jejaring layanan, peran pemangku kepentingan, prinsip inklusivitas, serta sistem pencatatan, pelaporan, dan monitoring evaluasi program.

2. Aspek Keterampilan (Skills)

Mahasiswa mampu:

a. Merancang program kesehatan reproduksi remaja berbasis sekolah/komunitas secara sistematis
b. Menyusun rencana operasional program
c. Melakukan pencatatan dan pelaporan sederhana
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program berbasis data

3. Aspek Sikap (Attitude)

Mahasiswa menunjukkan sikap:

a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan program kesehatan
b. Sensitif terhadap kebutuhan remaja dan kelompok rentan
c. Menghargai prinsip kerahasiaan dan etika dalam pelayanan
d. Mampu bekerja sama dalam jejaring lintas sektor

4. Aspek Keterampilan Umum (General Skills – OBE)

Mahasiswa mampu:

a. Berpikir kritis dalam menganalisis masalah kesehatan remaja
b. Berkomunikasi secara efektif dalam edukasi kesehatan
c. Menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan
d. Berkolaborasi dalam tim multidisiplin

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari:

A. Merancang Layanan/Program Berbasis Sekolah dan Komunitas (Jejaring, Peran Pemangku Kepentingan, dan Inklusivitas): Konsep Layanan Berbasis Sekolah dan Komunitas, Analisis Kebutuhan Program (Needs Assessment), Perencanaan Program Berbasis Sekolah, Jejaring Layanan (Networking), Peran Pemangku Kepentingan (Stakeholders), Prinsip Inklusivitas dalam Program dan Rencana Operasional Program.

B. Melaksanakan pencatatan–pelaporan dan monitoring–evaluasi sederhana untuk perbaikan layanan berbasis data: Konsep Pencatatan dan Pelaporan dalam Program Kesehatan Remaja, Prinsip Pencatatan Data yang Berkualitas, Jenis dan Sumber Data dalam Program Kesehatan Remaja, Pelaporan Program sebagai Dasar Pengambilan Keputusan, Monitoring Program Kesehatan Remaja, Evaluasi Program (Evaluation), Analisis Data dan Pemanfaatannya, Umpan Balik dan Perbaikan Program Berbasis Data, dan Etika dalam Pencatatan dan Pelaporan.

A. Merancang Layanan/Program Berbasis Sekolah dan Komunitas (Jejaring, Peran Pemangku Kepentingan, dan Inklusivitas)

1. Konsep Layanan Berbasis Sekolah dan Komunitas

Layanan Berbasis Sekolah dan Komunitas (LBSK) adalah pendekatan strategis yang menempatkan sekolah sebagai pusat intervensi promotif (peningkatan) dan preventif (pencegahan) yang terintegrasi dengan lingkungan sosial remaja. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan, layanan kesehatan, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku hidup sehat remaja.

Secara konseptual, layanan berbasis sekolah tidak hanya berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga pada pembentukan perilaku, penguatan keterampilan hidup (life skills), serta pemberdayaan remaja sebagai agen perubahan. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan kesehatan remaja yang ramah (youth-friendly services), yaitu layanan yang dapat diakses, diterima, menjaga kerahasiaan, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan remaja.

a. Accessible : Mudah dijangkau di lingkungan sekolah.
b. Acceptable : Dapat diterima secara sosial dan budaya.
c. Confidential : Menjamin kerahasiaan remaja.
d. Developmental : Sesuai dengan tahap perkembangan psikologis remaja.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis sekolah efektif dalam meningkatkan kesehatan reproduksi remaja. Penelitian oleh

Saparini, Simbolon, dan Ningsih (2023) menemukan bahwa intervensi kesehatan reproduksi yang dilakukan di sekolah mampu meningkatkan akses informasi dan pemahaman remaja secara signifikan dibandingkan pendekatan berbasis fasilitas kesehatan saja. Hal ini disebabkan karena sekolah merupakan lingkungan yang paling dekat dan rutin diakses oleh remaja.

Dalam konteks ini, keberadaan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) menjadi landasan utama. UKS tidak hanya berfungsi sebagai layanan kesehatan sederhana, tetapi juga sebagai wahana pendidikan kesehatan yang terintegrasi melalui Trias UKS (pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat). Namun demikian, implementasi UKS di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya inovasi program (Fakhrurozi, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan Sari, Gunarmi dan Hastuti (2024) menunjukkan bahwa optimalisasi UKS melalui pemberdayaan Duta UKS memberikan pendekatan yang lebih efektif dan partisipatif. Duta UKS sebagai peer educator mampu menjembatani kesenjangan komunikasi antara tenaga kesehatan dan remaja, sehingga informasi kesehatan reproduksi dapat diterima dengan lebih baik oleh teman sebaya.

2. Analisis Kebutuhan Program (Needs Assessment)

Perancangan program yang efektif harus diawali dengan analisis kebutuhan yang komprehensif. Analisis kebutuhan bertujuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan reproduksi yang dialami remaja serta menentukan prioritas intervensi yang tepat. Analisis kebutuhan program dalam kesehatan reproduksi remaja menjadi sangat penting karena berbagai permasalahan yang dialami remaja saat ini bersifat kompleks, saling berkaitan, dan sering kali tidak disadari oleh remaja itu sendiri. Tanpa analisis kebutuhan yang tepat, program yang dirancang berisiko tidak menyentuh akar masalah yang sebenarnya.

Masalah kesehatan reproduksi yang paling sering ditemukan pada remaja antara lain:

a. Anemia pada remaja putri, masih memiliki prevalensi cukup tinggi di Indonesia. Data menunjukkan bahwa sekitar 23% remaja putri usia 13–18 tahun mengalami anemia, yang berdampak pada kelelahan, penurunan konsentrasi belajar, serta berisiko terhadap kesehatan reproduksi di masa depan. Penelitian mengungkapkan bahwa anemia pada remaja erat kaitannya dengan pola makan, kebiasaan hidup, serta rendahnya kepatuhan konsumsi tablet tambah darah. Bahkan, pola menstruasi yang tidak normal

juga terbukti berhubungan signifikan dengan kejadian anemia pada remaja putri.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masalah anemia tidak dapat ditangani hanya dengan pemberian suplemen, tetapi memerlukan analisis kebutuhan yang mencakup aspek pengetahuan, perilaku, dan lingkungan remaja. Program yang dirancang harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut agar intervensi menjadi lebih efektif.

b. **Masalah kesehatan menstruasi**, menjadi isu penting pada remaja. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah remaja putri mengalami gangguan siklus menstruasi (59,4%), yang dapat berdampak pada kesehatan reproduksi jangka panjang, seperti infertilitas dan gangguan hormonal. Permasalahan ini sering kali diperburuk oleh kurangnya pengetahuan dan keterbatasan akses informasi yang benar mengenai kesehatan menstruasi. Perilaku remaja dalam menjaga kesehatan saat menstruasi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, sikap, serta ketersediaan fasilitas pendukung.
c. **Perilaku seksual berisiko pada remaja**, menjadi tantangan serius dalam kesehatan reproduksi. Penelitian menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap perilaku seksual pranikah, kehamilan tidak diinginkan, serta infeksi menular seksual, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang benar tentang kesehatan reproduksi. Bahkan, perilaku seksual remaja juga memiliki keterkaitan dengan masalah kesehatan mental, di mana tekanan psikologis dan kurangnya dukungan sosial dapat memperburuk kondisi kesehatan remaja secara keseluruhan.
d. **Masalah gizi remaja,** menjadi isu yang semakin mendapat perhatian. Remaja berada pada fase pertumbuhan pesat yang membutuhkan asupan gizi optimal. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih banyak remaja yang mengalami malnutrisi ganda, yaitu kekurangan gizi (underweight dan anemia) sekaligus kelebihan gizi (overweight dan obesitas). Penelitian oleh Lestari et al. (2023) menunjukkan bahwa pola konsumsi remaja yang tinggi makanan cepat saji dan rendah asupan zat besi serta protein menjadi faktor utama masalah gizi remaja di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan umum, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, seperti gangguan siklus menstruasi dan kesiapan kehamilan di masa depan.
e. **Kesehatan mental remaja**, menjadi isu yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Remaja menghadapi berbagai tekanan, baik dari lingkungan akademik, keluarga, maupun sosial. Penelitian menunjukkan

bahwa tingkat stres, kecemasan, dan depresi pada remaja mengalami peningkatan, yang secara tidak langsung memengaruhi perilaku kesehatan reproduksi mereka. Remaja dengan kondisi kesehatan mental yang buruk cenderung memiliki perilaku berisiko, termasuk kurang menjaga kesehatan diri, rendahnya kepatuhan terhadap perilaku hidup sehat, serta keterlibatan dalam perilaku seksual berisiko (Sari dan Utami, 2023).

f. Fenomena **body image (citra tubuh)** juga menjadi perhatian penting dalam kesehatan remaja. Paparan media sosial yang intens menyebabkan banyak remaja memiliki persepsi tubuh yang tidak realistis, yang kemudian memicu perilaku diet ekstrem, gangguan makan, hingga rendahnya kepercayaan diri. Penelitian oleh Wulandari et al. (2024) menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh berhubungan signifikan dengan perilaku makan tidak sehat pada remaja putri. Hal ini berimplikasi langsung terhadap status gizi dan kesehatan reproduksi mereka.

g. **Gaya hidup sedentari (kurang aktivitas fisik)** yang semakin meningkat akibat penggunaan gadget dan media digital. Remaja cenderung menghabiskan waktu lebih banyak untuk aktivitas pasif seperti bermain media sosial atau game online. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya aktivitas fisik berhubungan dengan peningkatan risiko obesitas, gangguan hormonal, serta masalah kesehatan mental pada remaja (Pratama et al., 2023).

Jika dicermati, berbagai kasus tersebut memiliki benang merah yang sama, yaitu rendahnya literasi kesehatan reproduksi, keterbatasan akses layanan ramah remaja, serta kurangnya dukungan lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan kesehatan reproduksi remaja tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan tunggal, melainkan memerlukan intervensi berbasis kebutuhan yang spesifik dan kontekstual.

Dalam konteks ini, analisis kebutuhan program menjadi langkah awal yang krusial untuk:

a. Mengidentifikasi masalah utama yang paling dominan di suatu wilayah atau sekolah
b. Menentukan faktor penyebab (pengetahuan, perilaku, lingkungan)
c. Menyesuaikan intervensi dengan karakteristik remaja
d. Menentukan prioritas program yang paling berdampak

Dengan demikian, analisis kebutuhan bukan hanya sekadar tahap awal dalam perencanaan program, tetapi merupakan fondasi utama dalam memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar relevan, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan

reproduksi remaja. Analisis kebutuhan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti survei, wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD), serta analisis data sekunder dari sekolah atau puskesmas.

3. Perencanaan Program Berbasis Sekolah

Perencanaan program merupakan tahap krusial dalam memastikan keberhasilan intervensi kesehatan reproduksi remaja. Perencanaan harus dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi, serta indikator keberhasilan.

Tujuan program harus dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Sasaran program dapat meliputi individu remaja, kelompok siswa, maupun komunitas sekolah secara keseluruhan.

Penelitian Askrening dan Khair Anwar (2022) menunjukkan bahwa program pelatihan berbasis sekolah yang dirancang secara sistematis mampu meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi siswa secara signifikan dalam waktu singkat. Hal ini menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dalam menentukan keberhasilan program. Perencanaan program juga harus mencakup penyusunan indikator keberhasilan, baik indikator output (jumlah kegiatan, jumlah peserta) maupun outcome (perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku).

Dalam perencanaan program berbasis sekolah, penting bagi tenaga kesehatan maupun pendidik untuk mengacu pada program yang telah terbukti efektif melalui penelitian maupun yang telah diimplementasikan secara nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dirancang memiliki dasar ilmiah yang kuat serta berpotensi memberikan dampak yang nyata bagi kesehatan remaja.

Berikut beberapa Contoh Program Berbasis Sekolah dalam Kesehatan Reproduksi Remaja**:**

a. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). UKS merupakan program lintas sektor yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Agama, yang bertujuan meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik. Program ini mencakup Trias UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi UKS yang optimal dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa (Fakhrurozi, 2022). Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada inovasi program dan keterlibatan aktif siswa.

b. **Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).** Program yang diintegrasikan dengan sekolah melalui kegiatan penyuluhan, konseling, dan rujukan. PKPR bertujuan memberikan layanan kesehatan yang ramah remaja, termasuk kesehatan reproduksi. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi PKPR dengan kegiatan sekolah dapat meningkatkan akses remaja terhadap layanan kesehatan serta meningkatkan pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi (Wijaya et al., 2025).
c. **Program Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri di sekolah**, merupakan program nasional untuk pencegahan anemia. Program ini dilakukan melalui distribusi TTD secara rutin di sekolah disertai edukasi kesehatan. Penelitian Yuliastuti et al. (2024) menunjukkan bahwa program TTD berbasis sekolah efektif dalam meningkatkan kadar hemoglobin dan pengetahuan remaja putri tentang anemia, meskipun masih terdapat tantangan dalam kepatuhan konsumsi.
d. **Program peer education (pendidikan sebaya)**, yang dalam konteks sekolah sering diwujudkan dalam bentuk kader kesehatan remaja atau Duta UKS. Program ini menekankan peran remaja sebagai agen perubahan dalam menyampaikan informasi kesehatan kepada teman sebaya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa metode peer education lebih efektif dibandingkan metode ceramah biasa karena menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih dekat dengan remaja (Mariana, Putri dan Halim, 2024). Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa program Duta UKS yang dilatih sebagai peer educator mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kepercayaan diri remaja dalam menyampaikan informasi kesehatan reproduksi. Selain itu, program ini juga meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan UKS serta memperkuat jejaring antara sekolah dan tenaga kesehatan (Sari, Gunarmi dan Hastuti 2024)
e. **Program edukasi kesehatan berbasis media digital**, seperti penggunaan aplikasi, video edukasi, dan media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa media digital dapat meningkatkan minat belajar remaja serta memperluas jangkauan edukasi kesehatan reproduksi (Sari et al., 2023). Program ini sangat relevan dengan karakteristik generasi remaja saat ini yang dekat dengan teknologi.
f. **Program Posyandu Remaja berbasis sekolah atau komunitas sekolah**, yang berfungsi sebagai wadah pelayanan kesehatan sederhana, seperti skrining kesehatan, konseling, dan edukasi. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan remaja dalam menjaga kesehatan mereka sendiri

serta memperkuat peran komunitas dalam pelayanan kesehatan (Al Aufa et al., 2020).

Dari berbagai contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa program berbasis sekolah yang efektif umumnya memiliki karakteristik:

1) Berbasis kebutuhan remaja
2) Melibatkan partisipasi aktif siswa
3) Didukung oleh kebijakan dan jejaring lintas sektor
4) Menggunakan pendekatan inovatif (peer education, digital, dll)
5) Memiliki sistem monitoring dan evaluasi

Dengan demikian, dalam merancang program berbasis sekolah dapat mengadaptasi dan mengembangkan program yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.

4. Jejaring Layanan (Networking)

Jejaring layanan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan berbasis sekolah. Jejaring memungkinkan terjadinya kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

Jejaring dalam program kesehatan reproduksi remaja melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, puskesmas, dinas kesehatan, orang tua, serta organisasi masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk memastikan adanya dukungan sumber daya, rujukan layanan, serta kesinambungan program.

Penelitian Wijaya et al. (2025) menunjukkan bahwa program kesehatan remaja berbasis sekolah yang didukung jejaring layanan yang kuat memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan program yang berjalan secara mandiri. Hal ini karena jejaring memungkinkan integrasi layanan promotif, preventif, dan kuratif. Jejaring layanan juga berfungsi sebagai sistem rujukan yang memudahkan remaja untuk mendapatkan pelayanan lanjutan ketika ditemukan masalah kesehatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Selain itu, jejaring memungkinkan optimalisasi sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, fasilitas, maupun informasi.

Berikut beberapa contoh jejaring layanan yang relevan dan dapat diimplementasikan dalam Pelayanan Berbasis Sekolah dan Komunitas:

a. Jejaring Sekolah – Puskesmas (PKPR)

Kerja sama antara sekolah dan puskesmas merupakan bentuk jejaring yang paling umum dan strategis. Puskesmas melalui program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) memberikan layanan seperti:

1) Edukasi kesehatan reproduksi
2) Konseling remaja

3) Skrining kesehatan (anemia, kesehatan mental, dll)
4) Rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan

Penelitian menunjukkan bahwa integrasi PKPR dengan sekolah meningkatkan akses remaja terhadap layanan kesehatan serta meningkatkan pengetahuan mereka secara signifikan (Mumtazah dan Sulistiadi, 2022).

Contoh praktik**:** Sekolah bekerja sama dengan puskesmas untuk melakukan kunjungan rutin (school health visit), di mana tenaga kesehatan memberikan penyuluhan dan membuka layanan konseling di sekolah.

b. Jejaring UKS – Duta UKS – Guru Pembina

Jejaring internal sekolah juga sangat penting, khususnya melalui penguatan UKS. Dalam jejaring ini:

1) Guru pembina UKS sebagai fasilitator
2) Duta UKS/kader remaja sebagai peer educator
3) Siswa sebagai sasaran program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Duta UKS sebagai penghubung antara siswa, guru, dan tenaga kesehatan mampu meningkatkan efektivitas komunikasi serta partisipasi remaja dalam program kesehatan (Sari, Gunarmi dan Hastuti, 2024).

Contoh praktik**:** Duta UKS melakukan edukasi sebaya tentang anemia, kesehatan menstruasi, dan kesehatan mental, kemudian melaporkan kegiatan kepada guru pembina dan puskesmas.

c. Jejaring Sekolah – Orang Tua – Komite Sekolah

Peran keluarga sangat penting dalam membentuk perilaku kesehatan remaja. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua dalam jejaring layanan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Bimbingan orang tua merupakan faktor penting dalam membentuk perilaku remaja. Orang tua berperan sebagai pendamping yang memberikan arahan, pengawasan, serta teladan. Komunikasi terbuka antara orang tua, sekolah dan remaja membantu membangun kepercayaan dan mendorong remaja untuk bersikap lebih kritis.

Penelitian menunjukkan bahwa dukungan orang tua berpengaruh signifikan terhadap perilaku kesehatan remaja, termasuk dalam kepatuhan konsumsi tablet tambah darah dan perilaku hidup sehat (Yukizali et al., 2024).

Contoh praktik**:**

1) Pertemuan orang tua (parent meeting) dengan tema kesehatan remaja
2) Edukasi melalui grup WhatsApp orang tua
3) Kolaborasi dalam pemantauan konsumsi TTD di rumah

d. Jejaring Sekolah – Posyandu Remaja / Kader Kesehatan

Posyandu remaja merupakan inovasi berbasis komunitas yang dapat diintegrasikan dengan sekolah. Program ini menyediakan layanan seperti:

1) Pemeriksaan kesehatan sederhana
2) Edukasi kesehatan
3) Konseling remaja

Penelitian menunjukkan bahwa Posyandu Remaja efektif dalam meningkatkan keterlibatan remaja dalam menjaga kesehatan serta memperkuat layanan berbasis komunitas (Al Aufa et al., 2020).

Contoh praktik**:** Sekolah merujuk siswa ke Posyandu Remaja untuk pemeriksaan lanjutan atau kegiatan kesehatan di luar jam sekolah.

e. Jejaring dengan Lembaga/Organisasi (Lintas Sektor)

Beberapa lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat juga berperan dalam edukasi kesehatan reproduksi remaja, seperti:

1) Program edukasi kesehatan seksual
2) Kampanye kesehatan mental
3) Pelatihan peer educator

Kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan program dan menghadirkan inovasi baru dalam pendekatan edukasi.

Contoh praktik: Sekolah bekerja sama dengan organisasi kesehatan untuk memberikan pelatihan kesehatan reproduksi berbasis media interaktif.

f. Jejaring Digital (Telehealth dan Media Sosial)

Di era digital, jejaring layanan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga virtual. Pemanfaatan teknologi menjadi sangat relevan dengan karakteristik remaja saat ini. Kampanye media sosial yang tepat juga dapat dimanfaatkan sebagai strategi peningkatan literasi digital. Kampanye yang dirancang dengan bahasa dan format yang sesuai dengan karakteristik remaja dapat menyampaikan pesan edukatif secara efektif. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana promosi nilai-nilai positif, keamanan digital, dan penggunaan
teknologi yang produktif.

Sekolah memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi digital remaja melalui integrasi edukasi digital ke dalam proses pembelajaran. Edukasi ini mencakup pemahaman dasar tentang penggunaan teknologi, etika digital, keamanan data pribadi, serta dampak positif dan negatif internet. Pembelajaran yang terstruktur membantu remaja memahami peran teknologi sebagai sarana belajar dan pengembangan diri, bukan sekadar hiburan. Selain itu, pelaksanaan workshop penggunaan internet sehat

menjadi sarana efektif untuk memberikan pengalaman praktis kepada remaja. Melalui workshop, remaja dapat mempelajari cara mengelola waktu layar, melindungi privasi, serta menghindari risiko seperti cyberbullying dan penyebaran informasi palsu.

Jejaring digital dapat berupa:

1) Konseling online
2) Edukasi melalui media sosial
3) Aplikasi kesehatan remaja

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media digital dapat meningkatkan akses informasi kesehatan serta keterlibatan remaja dalam program kesehatan (Sari et al., 2023).

Contoh praktik:

1) Duta UKS membuat konten edukasi di Instagram/TikTok
2) Konseling remaja melalui WhatsApp atau platform digital
3) Webinar kesehatan remaja

5. Peran Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Keberhasilan pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbasis sekolah dan komunitas sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Program yang hanya berfokus pada satu aktor, misalnya tenaga kesehatan saja, cenderung kurang efektif dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan program. Pemangku kepentingan dalam konteks ini tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penggerak, pendukung, sekaligus pengambil keputusan dalam program kesehatan remaja. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan lintas sektor secara signifikan meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan reproduksi remaja, terutama dalam aspek perubahan perilaku dan keberlanjutan program (Kurniasari et al., 2023).

Tenaga kesehatan berperan sebagai fasilitator dan sumber informasi, guru sebagai pendamping dan penguat edukasi, serta orang tua sebagai pendukung utama di lingkungan keluarga. Remaja sendiri, melalui Duta UKS, berperan sebagai agen perubahan yang aktif dalam menyebarkan informasi kesehatan.

a. Tenaga Kesehatan (Puskesmas/PKPR) sebagai Fasilitator dan Sumber Ahli

Tenaga kesehatan memiliki peran utama sebagai penyedia layanan kesehatan yang berbasis evidence dan ramah remaja. Dalam program

berbasis sekolah, tenaga kesehatan tidak hanya memberikan pelayanan kuratif, tetapi juga berperan dalam:

1) Edukasi kesehatan reproduksi
2) Konseling individu maupun kelompok
3) Skrining kesehatan (anemia, kesehatan mental, dll)
4) Pelatihan kader remaja (Duta UKS)

Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan tenaga kesehatan dalam program sekolah meningkatkan kualitas informasi yang diterima remaja serta meningkatkan kepercayaan terhadap layanan kesehatan (Mumtazah dan Sulistiadi, 2022).

Namun demikian, tantangan yang sering dihadapi adalah keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga diperlukan kolaborasi dengan pihak sekolah dan kader remaja untuk memperluas jangkauan layanan.

b. Sekolah dan Guru sebagai Agen Edukasi dan Penguat Lingkungan

Sekolah merupakan lingkungan utama bagi remaja, sehingga memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku kesehatan. Guru, khususnya pembina UKS, berperan sebagai:

1) Fasilitator kegiatan edukasi kesehatan
2) Pendamping kegiatan siswa (Duta UKS)
3) Pengintegrasi materi kesehatan dalam pembelajaran

Penelitian Fakhrurozi (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan program UKS sangat dipengaruhi oleh komitmen dan keterlibatan aktif guru dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan di sekolah.

Selain itu, sekolah juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, seperti penyediaan fasilitas sanitasi yang layak dan kebijakan sekolah sehat.

c. Pemerintah dan Pembuat Kebijakan sebagai Penentu Sistem dan Regulasi

Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan kebijakan, pedoman, serta sumber daya untuk mendukung program kesehatan remaja. Program seperti UKS dan PKPR merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesehatan remaja.

Peran Pemerintah meliputi:

1) Penyusunan kebijakan dan pedoman program
2) Penyediaan anggaran dan fasilitas
3) Monitoring dan evaluasi program

Penelitian menunjukkan bahwa dukungan kebijakan yang kuat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi program kesehatan berbasis sekolah (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

d. Masyarakat dan Organisasi Sosial sebagai Pendukung Lingkungan

Masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi lokal, memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan remaja. Dukungan masyarakat dapat berupa:

1) Partisipasi dalam kegiatan kesehatan
2) Penyediaan fasilitas atau ruang kegiatan
3) Dukungan sosial terhadap remaja

Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat meningkatkan keberlanjutan program kesehatan berbasis komunitas (Rokhimah & Dewi, 2024).

Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh peran masing-masing stakeholder secara individu, tetapi juga oleh sinergi antar stakeholder. Kolaborasi yang baik akan menghasilkan program yang lebih komprehensif , jangkauan layanan yang lebih luas dan keberlanjutan program yang lebih kuat.

Dengan demikian, pemangku kepentingan dalam program kesehatan reproduksi remaja memiliki peran yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Program yang dirancang dengan melibatkan seluruh stakeholder secara aktif akan lebih mampu menjawab kebutuhan remaja secara komprehensif, serta memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi.

6. Prinsip Inklusivitas dalam Program

Inklusivitas merupakan prinsip penting dalam pelayanan kesehatan remaja. Program harus dapat menjangkau seluruh kelompok remaja tanpa diskriminasi, termasuk remaja dengan latar belakang sosial ekonomi rendah, remaja dengan disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan kebutuhannya.

Penelitian Rokhimah dan Dewi (2024) menunjukkan bahwa program kesehatan yang inklusif lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi remaja karena mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Inklusivitas juga berkaitan dengan penggunaan bahasa yang mudah dipahami, pendekatan yang sensitif budaya, serta penghormatan terhadap privasi remaja.

a. Inklusivitas Berbasis Gender

Program kesehatan reproduksi harus sensitif terhadap perbedaan kebutuhan antara remaja laki-laki dan perempuan. Selama ini, program kesehatan reproduksi sering lebih berfokus pada remaja putri, terutama terkait menstruasi dan anemia, sementara kebutuhan remaja laki-laki sering kurang diperhatikan.

Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya keterlibatan remaja laki-laki dalam edukasi kesehatan reproduksi dapat meningkatkan risiko perilaku seksual berisiko serta rendahnya pemahaman tentang tanggung jawab kesehatan reproduksi (Sari et al., 2023). Oleh karena itu, program harus dirancang agar inklusif bagi kedua gender, dengan materi yang relevan dan pendekatan yang sesuai.

Contoh implementasi:

1) Edukasi kesehatan reproduksi untuk laki-laki dan perempuan
2) Diskusi kelompok terpisah untuk topik sensitif
3) Materi yang tidak bias gender

b. Inklusivitas Sosial Ekonomi

Remaja dari latar belakang ekonomi rendah sering menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan, termasuk keterbatasan biaya, fasilitas, dan informasi. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam status kesehatan reproduksi.

Penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi berpengaruh signifikan terhadap akses dan pemanfaatan layanan kesehatan remaja (Yuliana et al., 2023). Oleh karena itu, program harus dirancang agar dapat menjangkau seluruh kelompok remaja tanpa hambatan biaya atau akses.

Contoh implementasi:

1) Layanan kesehatan gratis di sekolah
2) Penyediaan tablet tambah darah tanpa biaya
3) Edukasi menggunakan media sederhana dan mudah diakses

c. Inklusivitas bagi Remaja dengan Kebutuhan Khusus (Disabilitas)

Remaja dengan disabilitas merupakan kelompok yang sering terabaikan dalam program kesehatan reproduksi. Padahal, mereka memiliki kebutuhan yang sama bahkan lebih kompleks dibandingkan remaja lainnya.

Penelitian menunjukkan bahwa remaja dengan disabilitas memiliki akses yang lebih rendah terhadap informasi kesehatan reproduksi serta lebih rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi (Kurniasari et al., 2023). Oleh karena itu, program harus dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas bagi semua.

Contoh implementasi:

1) Materi edukasi dengan media visual/audio
2) Pendampingan khusus saat edukasi
3) Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami

d. Inklusivitas Budaya dan Nilai Lokal

Indonesia memiliki keragaman budaya yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kesehatan reproduksi. Dalam beberapa budaya, topik kesehatan reproduksi masih dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka.

Contoh implementasi:

1) Melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama
2) Menggunakan bahasa lokal
3) Menyesuaikan metode edukasi dengan budaya setempat

e. Inklusivitas dalam Akses Informasi dan Teknologi

Di era digital, akses informasi kesehatan tidak hanya melalui tatap muka, tetapi juga melalui media digital. Namun, tidak semua remaja memiliki akses yang sama terhadap teknologi.

Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital dapat meningkatkan jangkauan edukasi kesehatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesenjangan jika tidak diimbangi dengan pendekatan offline (Sari et al., 2023).

Contoh implementasi:

1) Kombinasi edukasi offline dan online
2) Penggunaan media sosial untuk edukasi
3) Penyediaan materi cetak bagi yang tidak memiliki akses digital

f. Inklusivitas dalam Lingkungan yang Aman dan Nyaman

Lingkungan yang aman secara fisik dan psikologis merupakan faktor penting dalam keberhasilan program kesehatan remaja. Remaja akan lebih terbuka dalam menerima informasi dan berkonsultasi jika merasa aman dan tidak dihakimi.

Penelitian menunjukkan bahwa stigma dan diskriminasi menjadi salah satu hambatan utama dalam akses layanan kesehatan reproduksi remaja (Mariana, Putri dan Halim, 2024). Oleh karena itu, program harus menciptakan lingkungan yang suportif dan non-diskriminatif.

Contoh implementasi:

1) Konseling yang menjaga kerahasiaan
2) Pendekatan komunikasi yang empatik
3) Tidak menghakimi perilaku remaja

Secara konseptual inklusivitas bukan hanya sekadar prinsip tambahan, tetapi merupakan fondasi utama dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Program yang inklusif akan menjangkau lebih banyak remaja, mengurangi kesenjangan kesehatan, meningkatkan efektivitas intervensi, dan mendorong keberlanjutan program. Tanpa pendekatan inklusif, program berisiko hanya menjangkau sebagian kecil remaja dan gagal memberikan dampak yang merata.

7. Rencana Operasional Program

Rencana operasional merupakan bentuk konkret dari perencanaan program yang menjabarkan "apa yang akan dilakukan, kapan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana cara melaksanakan, serta sumber daya apa yang dibutuhkan". Dengan kata lain, rencana operasional berfungsi sebagai pedoman kerja yang memastikan bahwa program dapat dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbasis sekolah, rencana operasional menjadi sangat penting karena melibatkan berbagai pihak, seperti tenaga kesehatan, guru, dan remaja (Duta UKS), sehingga diperlukan koordinasi yang jelas dan terstruktur. Tanpa rencana operasional yang baik, program berisiko berjalan tidak konsisten, tidak terukur, dan sulit dievaluasi.

Secara teoritis, rencana operasional merupakan turunan dari perencanaan strategis yang bersifat lebih teknis dan implementatif. Rencana ini biasanya disusun dalam periode tertentu (misalnya bulanan atau semesteran) dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi sekolah.

Komponen Utama Rencana Operasional Program agar rencana operasional dapat berfungsi secara optimal, terdapat beberapa komponen penting yang harus disusun secara jelas, yaitu:

a. Jadwal Kegiatan Edukasi

Jadwal kegiatan merupakan pengaturan waktu pelaksanaan program yang disusun secara sistematis. Jadwal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan secara teratur dan tidak mengganggu aktivitas utama siswa. Jadwal kegiatan sebaiknya mencakup:

1) Waktu pelaksanaan (tanggal dan jam)
2) Jenis kegiatan (edukasi, skrining, konseling, dll)
3) Sasaran kegiatan (kelas atau kelompok tertentu)

Jadwal yang jelas akan membantu meningkatkan kedisiplinan pelaksanaan program serta memudahkan proses monitoring.

b. Pembagian Peran Duta UKS dan Tim Pelaksana

Pembagian peran bertujuan untuk menghindari tumpang tindih tugas serta memastikan setiap anggota tim memahami tanggung jawabnya. Dalam program berbasis sekolah, pembagian peran biasanya melibatkan:

1) Duta UKS → edukator sebaya
2) Guru pembina → koordinator kegiatan
3) Tenaga kesehatan → narasumber dan supervisor

c. Media Edukasi yang Digunakan

Media edukasi merupakan alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada remaja. Pemilihan media harus disesuaikan dengan karakteristik remaja agar materi lebih mudah dipahami dan menarik.

Media yang dapat digunakan antara lain:

1) Poster dan leaflet
2) Video edukasi
3) PowerPoint interaktif
4) Media sosial (Instagram, TikTok)

d. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Rencana operasional juga harus mencakup bagaimana program akan dipantau dan dievaluasi. Monitoring dilakukan selama program berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil program.

Mekanisme ini dapat meliputi:

1) Pengisian logbook kegiatan
2) Absensi peserta
3) Pre-test dan post-test
4) Diskusi refleksi kegiatan

Monitoring dan evaluasi yang terencana dengan baik akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan.

e. Alokasi Sumber Daya (Tambahan Penguatan)

Selain komponen di atas, rencana operasional juga perlu mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, seperti:

1) Sumber daya manusia (guru, tenaga kesehatan, Duta UKS)
2) Sarana dan prasarana (ruangan, alat edukasi)
3) Pendanaan (jika diperlukan)

Pengelolaan sumber daya yang baik akan mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Rencana operasional yang baik memiliki beberapa ciri, yaitu:

1) Jelas dan rinci
2) Realistis dan sesuai kondisi
3) Fleksibel (dapat disesuaikan jika diperlukan)
4) Terukur (memiliki indikator keberhasilan)
5) Melibatkan semua pihak terkait

Dengan demikian, rencana operasional merupakan jembatan antara perencanaan dan pelaksanaan program. Rencana ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa program berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tanpa rencana operasional yang jelas, program berisiko berjalan tidak terarah dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

B. Melaksanakan pencatatan–pelaporan dan monitoring–evaluasi sederhana untuk perbaikan layanan berbasis data:

1. Konsep Pencatatan dan Pelaporan dalam Program Kesehatan Remaja

Pencatatan dan pelaporan merupakan komponen penting dalam siklus manajemen program kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbasis sekolah dan komunitas. Pencatatan (recording) adalah proses pengumpulan dan pendokumentasian data kegiatan secara sistematis, sedangkan pelaporan (reporting) merupakan proses penyampaian informasi hasil kegiatan kepada pihak terkait untuk tujuan evaluasi dan pengambilan keputusan.

Pencatatan dan pelaporan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan (health information system). Dalam siklus manajemen program, pencatatan dan pelaporan berada pada tahap monitoring dan evaluasi, namun secara praktis juga memengaruhi seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengambilan keputusan. Data yang dihasilkan dari proses pencatatan akan diolah menjadi informasi melalui pelaporan, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan atau perbaikan program.

Dalam konteks program kesehatan remaja, pencatatan dan pelaporan berfungsi sebagai dasar untuk menilai capaian program, mengidentifikasi permasalahan, serta merencanakan perbaikan layanan. Penelitian oleh Mumtazah dan Sulistiadi (2022) menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem pencatatan dan pelaporan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), khususnya dalam aspek evaluasi input, proses, dan output program.

a. Pencatatan dan Pelaporan sebagai Bagian dari Siklus Manajemen Program.

Dalam teori manajemen program kesehatan, pencatatan dan pelaporan tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari siklus berkelanjutan yang meliputi:

1) Perencanaan (planning): menentukan tujuan dan indikator
2) Pelaksanaan (implementation): menjalankan kegiatan
3) Monitoring (monitoring): memantau proses melalui pencatatan
4) Evaluasi (evaluation): menilai hasil melalui pelaporan
5) Perbaikan (feedback/improvement): menggunakan data untuk peningkatan program

Dengan demikian, tanpa pencatatan yang baik, proses monitoring tidak dapat dilakukan secara akurat, dan tanpa pelaporan yang jelas, evaluasi program menjadi tidak optimal.

b. Fungsi Strategis Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan memiliki beberapa fungsi strategis dalam program kesehatan remaja, yaitu:

1) Sebagai dasar pengambilan Keputusan: Data yang tercatat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan atau intervensi yang tepat.
2) Sebagai alat monitoring program: Memungkinkan pelaksana program untuk memantau apakah kegiatan berjalan sesuai rencana.
3) Sebagai alat evaluasi program: Digunakan untuk menilai keberhasilan program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
4) Sebagai bentuk akuntabilitas: Menunjukkan pertanggungjawaban pelaksanaan program kepada pihak terkait.
5) Sebagai sumber informasi dan pembelajaran: Data yang terdokumentasi dapat digunakan untuk pengembangan program di masa mendatang.

c. Karakteristik Pencatatan dan Pelaporan yang Efektif

Agar pencatatan dan pelaporan dapat memberikan manfaat optimal, terdapat beberapa karakteristik yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Sederhana: mudah dilakukan oleh pelaksana program, termasuk remaja (Duta UKS)
2) Sistematis: menggunakan format yang terstruktur
3) Akurat: mencerminkan kondisi yang sebenarnya
4) Tepat waktu: dilakukan secara rutin dan tidak tertunda
5) Relevan: sesuai dengan tujuan program

Dalam konteks sekolah, sistem pencatatan yang terlalu kompleks justru dapat menjadi hambatan. Oleh karena itu, pendekatan pencatatan sederhana namun konsisten lebih dianjurkan.

2. Prinsip Pencatatan Data yang Berkualitas

Pencatatan data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam sistem informasi kesehatan, karena kualitas data yang dihasilkan akan sangat menentukan kualitas informasi dan keputusan yang diambil. Dalam program kesehatan reproduksi remaja berbasis sekolah dan komunitas, pencatatan tidak hanya bertujuan untuk mendokumentasikan kegiatan, tetapi juga untuk menghasilkan data yang dapat digunakan dalam monitoring, evaluasi, dan perbaikan program secara berkelanjutan.

Secara teoritis, kualitas data mengacu pada sejauh mana data tersebut mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya (valid) dan dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pencatatan yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip kualitas data, yaitu lengkap, akurat, tepat waktu, konsisten, dan menjaga kerahasiaan. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan bias informasi, kesalahan analisis, serta keputusan program yang tidak tepat sasaran.

Berikut beberapa Prinsip Pencatatan Data yang Berkualitas:

a. Kelengkapan Data (Completeness)

Kelengkapan data yaitu seluruh informasi yang dibutuhkan tercatat secara utuh tanpa ada bagian yang terlewat. Data yang tidak lengkap akan menyulitkan dalam analisis dan dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru.

Contoh: Dalam kegiatan edukasi, data yang perlu dicatat meliputi jumlah peserta, topik yang disampaikan, waktu pelaksanaan, serta hasil kegiatan. Jika salah satu komponen tidak dicatat, maka evaluasi program menjadi tidak optimal.

b. Keakuratan Data (Accuracy)

Keakuratan data menunjukkan bahwa data yang dicatat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam perencanaan maupun evaluasi program.

Contoh: Jumlah peserta yang dicatat harus sesuai dengan jumlah peserta yang hadir, bukan perkiraan.

Keakuratan data sangat dipengaruhi oleh kemampuan pencatat, sehingga diperlukan pelatihan sederhana bagi pelaksana program (kader kesehatan, Duta UKS).

c. Ketepatan Waktu (Timeliness)

Data harus dicatat dan dilaporkan tepat waktu agar tetap relevan dan dapat segera digunakan dalam pengambilan keputusan. Keterlambatan pencatatan dapat menyebabkan data menjadi tidak aktual.

Contoh: Pencatatan kegiatan dilakukan segera setelah kegiatan selesai, bukan ditunda beberapa hari.

Ketepatan waktu juga penting dalam pelaporan berkala, seperti laporan bulanan atau semester.

d. Konsistensi Data (Consistency)

Konsistensi berarti data dicatat dengan cara yang sama dari waktu ke waktu, sehingga dapat dibandingkan dan dianalisis secara berkelanjutan. Ketidakkonsistenan format atau cara pencatatan akan menyulitkan dalam analisis data.

Contoh: Penggunaan format logbook yang sama untuk setiap kegiatan edukasi.

Konsistensi juga mencakup penggunaan istilah dan indikator yang seragam.

e. Kerahasiaan Data (Confidentiality)

Kerahasiaan merupakan prinsip yang sangat penting, terutama dalam program kesehatan reproduksi remaja yang sering kali berkaitan dengan informasi sensitif. Data harus dijaga agar tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Dalam konteks remaja, aspek kerahasiaan menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan peserta terhadap layanan. Oleh karena itu, penggunaan kode atau inisial lebih dianjurkan dibandingkan dengan identitas lengkap.

Penelitian menunjukkan bahwa jaminan kerahasiaan dapat meningkatkan keterbukaan remaja dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi (Mariana, Putri dan Halim, 2024).

Kelima prinsip tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Data yang lengkap tetapi tidak akurat tetap tidak dapat digunakan dengan baik, begitu pula data yang akurat tetapi tidak tepat waktu akan kehilangan relevansinya. Dalam sistem monitoring dan evaluasi, kualitas data menentukan:

1) Ketepatan analisis program
2) Keakuratan penilaian capaian indikator
3) Ketepatan dalam menentukan intervensi lanjutan

Untuk memastikan kualitas data tetap terjaga, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1) Menggunakan format pencatatan yang sederhana dan standar
2) Memberikan pelatihan singkat kepada pelaksana program
3) Melakukan supervisi atau pengecekan berkala
4) Menyusun jadwal pencatatan dan pelaporan yang rutin
5) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya data dalam program

3. Jenis dan Sumber Data dalam Program Kesehatan Remaja

Data merupakan komponen utama dalam pengelolaan program kesehatan, karena seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sangat bergantung pada ketersediaan data yang relevan dan berkualitas. Dalam program kesehatan reproduksi remaja berbasis sekolah dan komunitas, data digunakan untuk menggambarkan kondisi awal, memantau pelaksanaan kegiatan, serta menilai keberhasilan program.

Data dalam program kesehatan dapat diklasifikasikan berdasarkan tahapan dalam siklus manajemen program, yaitu input, proses, output, dan outcome. Klasifikasi ini membantu pelaksana program dalam memahami alur perubahan yang terjadi sebagai hasil dari intervensi yang dilakukan.

Berikut jenis-jenis data dalam Program Kesehatan Remaja: Kementerian Kesehatan RI (2022) dan Azwar, A. (2010)

a. Data Input (Input Data)

Data input merupakan data yang berkaitan dengan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program. Data ini menggambarkan kesiapan program sebelum kegiatan dilaksanakan.

Data input meliputi:

1) Sumber daya manusia (tenaga kesehatan, guru, Duta UKS)
2) Media dan alat edukasi
3) Sarana dan prasarana
4) Pendanaan program

Contoh: Jumlah Duta UKS yang telah dilatih, jumlah media edukasi yang tersedia, serta dukungan tenaga kesehatan dari puskesmas.

Data input penting untuk memastikan bahwa program memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Data Proses (Process Data)

Data proses merupakan data yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan program. Data ini berfungsi untuk memantau apakah kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Data proses meliputi:

1) Jumlah kegiatan edukasi yang dilaksanakan

2) Frekuensi konseling remaja
3) Tingkat partisipasi siswa
4) Keterlibatan stakeholder

Data proses sangat penting dalam kegiatan monitoring, karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi hambatan selama pelaksanaan program.

c. Data Output (Output Data)

Data output merupakan hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan program. Data ini biasanya bersifat kuantitatif dan dapat diukur dalam jangka pendek.

Data output meliputi:

1) Jumlah peserta yang terjangkau
2) Cakupan layanan kesehatan
3) Jumlah kegiatan yang berhasil dilaksanakan

Data output digunakan untuk menilai sejauh mana target kegiatan telah tercapai.

d. Data Outcome (Outcome Data)

Data outcome merupakan data yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada sasaran program setelah intervensi dilakukan. Data ini lebih berfokus pada dampak program dalam jangka menengah.

Data outcome meliputi:

1) Peningkatan pengetahuan remaja
2) Perubahan sikap terhadap kesehatan reproduksi
3) Perubahan perilaku (misalnya kepatuhan konsumsi TTD, perilaku hidup sehat)

Contoh: Terjadi peningkatan skor pengetahuan remaja setelah edukasi, atau peningkatan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah.

Data outcome sangat penting untuk menilai efektivitas program dalam mencapai tujuan yang lebih substantif.

Dalam praktiknya, data tidak hanya bersifat angka (kuantitatif), tetapi juga dapat berupa informasi naratif (kualitatif). Kombinasi kedua jenis data ini sangat dianjurkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Penelitian Nadeak et al. (2023) menunjukkan bahwa evaluasi program kesehatan reproduksi berbasis sekolah yang menggunakan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait efektivitas program, termasuk perubahan pengetahuan dan perilaku remaja.

1) Data kuantitatif: memberikan gambaran angka (jumlah peserta, persentase, skor)

2) Data kualitatif: memberikan pemahaman mendalam (pendapat, pengalaman, hambatan)

Contoh:

Kuantitatif: 75% siswa mengalami peningkatan pengetahuan

Kualitatif: siswa merasa lebih percaya diri untuk berdiskusi tentang kesehatan reproduksi

Sumber data merupakan asal atau tempat diperolehnya data yang digunakan dalam program. Pemilihan sumber data harus disesuaikan dengan tujuan pengumpulan data serta kemudahan akses di lapangan. Sumber data dalam program kesehatan remaja diperoleh melalui berbagai metode pencatatan dan pengumpulan data, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara umum, sumber data tersebut meliputi pencatatan rutin pelayanan kesehatan serta metode pengumpulan data penelitian, seperti kuesioner, wawancara, dan diskusi kelompok (Azwar, 2010; Notoatmodjo, 2018).

Beberapa sumber data yang umum yang dapat digunakan digunakan antara lain:

a. Buku Register Kegiatan: merupakan catatan utama yang berisi data kegiatan secara rutin, seperti jenis kegiatan, jumlah peserta, dan waktu pelaksanaan. Digunakan untuk: monitoring kegiatan secara berkala
b. Formulir Layanan: digunakan untuk mencatat layanan yang diberikan kepada remaja, seperti konseling atau pemeriksaan kesehatan. Digunakan untuk: dokumentasi layanan individu
c. Survei Sederhana (Kuesioner): Digunakan untuk mengukur pengetahuan, sikap, atau perilaku remaja sebelum dan sesudah intervensi. Digunakan untuk: evaluasi outcome program
d. Wawancara atau Diskusi Kelompok (FGD): Digunakan untuk menggali informasi secara mendalam terkait pengalaman, persepsi, dan hambatan yang dihadapi remaja. Digunakan untuk: memahami konteks dan faktor penyebab masalah

Integrasi Sumber Data dalam Program Berbasis Sekolah**.** Dalam praktiknya, penggunaan berbagai sumber data secara bersamaan akan menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Misalnya, data dari logbook kegiatan dapat dikombinasikan dengan hasil survei dan wawancara untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas program.

4. Pelaporan Program sebagai Dasar Pengambilan Keputusan

Pelaporan merupakan tahapan lanjutan dari pencatatan yang bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk informasi yang sistematis, ringkas, dan

mudah dipahami oleh pengambil kebijakan. Jika pencatatan berfokus pada pengumpulan data mentah, maka pelaporan berfungsi mengolah data tersebut menjadi informasi yang bermakna dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Pelaporan merupakan bagian penting dalam sistem informasi kesehatan dan siklus manajemen program, khususnya pada tahap evaluasi dan umpan balik (feedback). Informasi yang dihasilkan dari laporan akan digunakan untuk menilai capaian program, mengidentifikasi kesenjangan, serta merumuskan strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran (Kementerian Kesehatan RI, 2022; Notoatmodjo, 2018).

Dalam konteks program kesehatan reproduksi remaja berbasis sekolah dan komunitas, pelaporan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kualitas layanan. Laporan yang disusun secara baik akan membantu pihak sekolah, tenaga kesehatan, maupun pemangku kebijakan dalam memahami kondisi nyata di lapangan.

a. Fungsi Pelaporan dalam Program Kesehatan Remaja

Pelaporan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1) Sebagai dasar pengambilan Keputusan. Laporan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan kebijakan atau intervensi selanjutnya.
2) Sebagai alat evaluasi program. Laporan digunakan untuk menilai keberhasilan program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
3) Sebagai bentuk akuntabilitas Laporan menjadi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan program kepada pihak terkait (sekolah, puskesmas, pemerintah).
4) Sebagai dasar perencanaan program berikutnya Informasi dalam laporan digunakan untuk menyusun perencanaan yang lebih baik di masa mendatang.

Menurut Azwar (2010), pengambilan keputusan dalam program kesehatan harus didasarkan pada data dan informasi yang valid, sehingga pelaporan yang baik menjadi prasyarat penting dalam manajemen program yang efektif.

Agar laporan dapat berfungsi secara optimal, laporan harus memenuhi beberapa karakteristik, yaitu:

1) Jelas dan ringkas → mudah dipahami oleh pembaca
2) Sistematis → disusun sesuai struktur yang logis
3) Berbasis data → didukung oleh data yang valid
4) Relevan → sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan

5) Tepat waktu → disampaikan sesuai jadwal pelaporan

Laporan yang tidak jelas atau tidak sistematis akan menyulitkan proses analisis dan berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

b. Komponen Utama dalam Laporan Program

Laporan program kesehatan remaja umumnya mencakup beberapa komponen utama sebagai berikut:

1) Ringkasan Kegiatan: Berisi gambaran umum kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk jenis kegiatan, waktu, dan sasaran.
2) Capaian Indikator: Berisi hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk jumlah maupun persentase.
3) Permasalahan yang dihadapi: Mengidentifikasi hambatan selama pelaksanaan program, baik dari segi sumber daya, partisipasi, maupun teknis pelaksanaan.
4) Rekomendasi Perbaikan: Berisi saran atau tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas program.

5. Monitoring dan Evaluasi Program

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus manajemen program kesehatan remaja yang berfungsi untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Monitoring program

Monitoring adalah proses pemantauan kegiatan secara berkala yang berfokus pada aspek pelaksanaan (proses), seperti kesesuaian kegiatan dengan rencana yang telah disusun (Azwar, 2010; Notoatmodjo, 2018).

Penelitian Muthmainnah et al. (2021) menunjukkan bahwa kurangnya monitoring secara rutin dapat menyebabkan ketimpangan akses layanan kesehatan remaja di berbagai sekolah, sehingga monitoring perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Monitoring dapat dilakukan melalui beberapa cara:

1) Observasi langsung, yaitu melihat pelaksanaan kegiatan secara nyata di lapangan
2) Checklist kegiatan, untuk memastikan setiap tahapan kegiatan telah dilakukan sesuai rencana
3) Supervisi lapangan, berupa pendampingan dan pembinaan oleh tenaga kesehatan atau guruobservasi langsung, penggunaan checklist kegiatan, serta supervisi lapangan oleh guru atau tenaga kesehatan.

b. Evaluasi program

Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan pada aspek input, proses, output, dan outcome untuk melihat efektivitas program secara menyeluruh (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Berbeda dengan monitoring yang berfokus pada proses, evaluasi lebih menitikberatkan pada hasil dan dampak program (Notoatmodjo, 2018).

Evaluasi dalam program kesehatan remaja dapat dilakukan pada beberapa aspek, yaitu:

1) Input (ketersediaan sumber daya)
2) Proses (pelaksanaan kegiatan)
3) Output (hasil langsung kegiatan)
4) Outcome (perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku)

Evaluasi bertujuan untuk:

1) Menilai efektivitas program
2) Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan program
3) Menyusun rekomendasi perbaikan

Data yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi selanjutnya perlu dianalisis agar menghasilkan informasi yang bermakna. Analisis data sederhana dapat dilakukan melalui tabulasi, perhitungan persentase, serta perbandingan sebelum dan sesudah intervensi. Penelitian Nadeak et al. (2023) menunjukkan bahwa analisis data yang dilakukan secara berkelanjutan mampu menggambarkan tren perubahan perilaku remaja dan menjadi dasar dalam perbaikan program.

Hasil analisis data kemudian digunakan sebagai dasar dalam memberikan umpan balik dan melakukan perbaikan program. Proses ini dapat dilakukan melalui siklus Plan–Do–Check–Act (PDCA), yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan program secara berkelanjutan (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Pendekatan berbasis data ini terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program kesehatan remaja.

Selain itu, aspek etika juga menjadi bagian penting dalam proses monitoring, evaluasi, dan pengelolaan data program. Data kesehatan remaja harus dikelola secara aman dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan (confidentiality), persetujuan (informed consent), serta penggunaan data yang tepat (WHO, 2017; Kementerian Kesehatan RI, 2022). Hal ini penting karena remaja merupakan

kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus, terutama terkait informasi sensitif seperti kesehatan reproduksi. Penerapan prinsip etika yang baik juga terbukti dapat meningkatkan kepercayaan remaja terhadap layanan kesehatan yang diberikan.

C. Penilaian

CPMK-7: Mampu Merancang Program Berbasis Sekolah/Komunitas serta Melakukan Pencatatan, Pelaporan, dan Monitoring–Evaluasi Sederhana

Bentuk Penilaian: (soal Vignette dan Penugasan laporan berbasis proyek (Project-Based Learning) berupa penyusunan: (Bobot Penilaian: 15%)

Soal Vignette (10 soal)

1. Seorang bidan puskesmas bekerja sama dengan SMA "Harapan Bangsa" untuk meningkatkan kesehatan reproduksi remaja. Hasil survei awal menunjukkan sebagian besar siswi mengalami anemia ringan, banyak siswa merasa malu berkonsultasi mengenai kesehatan reproduksi, serta kegiatan UKS di sekolah belum berjalan optimal. Sekolah memiliki 2 guru pembina UKS, tetapi belum ada keterlibatan aktif siswa sebagai kader kesehatan. Tim puskesmas kemudian merancang program berbasis sekolah dengan melibatkan Duta UKS sebagai *peer educator*, edukasi melalui media sosial sekolah, skrining anemia, dan konseling remaja berkala. Program juga direncanakan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengevaluasi peningkatan pengetahuan siswa.

   Komponen rencana operasional yang PALING penting disusun terlebih dahulu pada kasus tersebut adalah:

   A. Penyusunan laporan akhir program
   B. Penentuan jadwal dan pembagian peran pelaksana
   C. Penyusunan publikasi media sosial sekolah
   D. Pengadaan alat laboratorium kesehatan
   E. Penyusunan surat pertanggungjawaban dana

2. Di sebuah SMP, program edukasi kesehatan reproduksi telah berjalan selama 3 bulan melalui kegiatan Duta UKS dan penyuluhan dari puskesmas. Namun, hasil evaluasi menunjukkan kehadiran siswa menurun dan sebagian kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik. Guru pembina kesulitan mengetahui kegiatan mana yang sudah dan belum dilakukan.

   Tindakan yang paling tepat untuk memperbaiki monitoring program adalah:

   A. Mengurangi jumlah kegiatan edukasi
   B. Mengganti seluruh anggota Duta UKS
   C. Menggunakan logbook dan checklist kegiatan secara rutin
   D. Meniadakan evaluasi bulanan

E. Menyerahkan seluruh kegiatan kepada puskesmas

3. Sebuah sekolah melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi menggunakan presentasi digital dan media sosial. Namun, beberapa siswa dengan gangguan pendengaran dan siswa dari keluarga kurang mampu mengaku kesulitan mengikuti kegiatan karena keterbatasan akses dan media pembelajaran yang digunakan.

   Prinsip yang BELUM diterapkan secara optimal dalam program tersebut adalah:

   A. Kerahasiaan
   B. Monitoring program
   C. Inklusivitas layanan
   D. Dokumentasi kegiatan
   E. Rujukan kesehatan

4. Sebuah SMP di wilayah perkotaan memiliki angka perilaku merokok pada remaja laki-laki yang meningkat dalam 1 tahun terakhir. Pihak sekolah telah melakukan penyuluhan, tetapi hasil evaluasi menunjukkan perubahan perilaku siswa masih rendah. Bidan puskesmas kemudian mengusulkan program kolaboratif dengan melibatkan guru BK, orang tua, kader remaja, dan tokoh masyarakat sekitar sekolah.

   Tujuan utama pembentukan jejaring pada kasus tersebut adalah:

   A. Mengurangi biaya pelaksanaan program
   B. Mempermudah penyusunan laporan sekolah
   C. Meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan remaja
   D. Menggantikan peran guru UKS
   E. Menambah jumlah kegiatan ekstrakurikuler

5. Di sebuah SMA sebagian siswa merasa lebih nyaman berdiskusi mengenai kesehatan reproduksi dengan teman sebaya dibandingkan guru atau tenaga kesehatan. Sekolah kemudian membentuk Duta UKS yang diberikan pelatihan komunikasi, konseling dasar, dan edukasi kesehatan reproduksi.

   Peran utama Duta UKS pada kasus tersebut adalah:

   A. Menggantikan tenaga kesehatan sekolah
   B. Menjadi pengawas kedisiplinan siswa
   C. Menjadi fasilitator edukasi teman sebaya
   D. Menentukan diagnosis masalah kesehatan siswa
   E. Memberikan terapi medis kepada siswa

6. Program kesehatan remaja di sebuah sekolah telah berjalan selama 6 bulan, namun pihak puskesmas mengalami kesulitan saat mengevaluasi capaian program karena data kehadiran, hasil skrining, dan dokumentasi kegiatan tidak tersusun dengan baik.

Dokumen yang paling penting diperbaiki terlebih dahulu adalah:

A. Proposal kegiatan
B. Struktur organisasi UKS
C. Sistem pencatatan dan pelaporan program
D. Jadwal piket guru
E. Buku tata tertib sekolah

7. Seorang siswi SMA sering tidak masuk sekolah setelah mengalami perundungan di media sosial. Guru BK melaporkan bahwa siswi tampak menarik diri, sulit berkonsentrasi, dan tidak mau mengikuti kegiatan sekolah. Tim UKS kemudian melakukan pendekatan bersama bidan puskesmas.

   Langkah awal yang paling tepat dilakukan adalah:

   A. Memberikan sanksi pada siswa lain
   B. Melakukan konseling suportif dan asesmen psikososial
   C. Mengeluarkan siswa dari media sosial
   D. Memberikan terapi obat penenang
   E. Memindahkan siswa ke sekolah lain

8. Setelah program edukasi anemia remaja dilaksanakan selama satu semester, bidan sekolah ingin mengetahui apakah program berhasil meningkatkan pengetahuan dan perilaku konsumsi tablet tambah darah pada siswi.

   Metode evaluasi yang paling tepat digunakan adalah:

   A. Menghitung jumlah siswa baru
   B. Membandingkan hasil pre-test dan post-test
   C. Evaluasi frekuensi penyuluhan
   D. Menghitung jumlah guru UKS yang terlibat
   E. Menambah media edukasi

9. Sebuah sekolah ingin membuat program kesehatan reproduksi berbasis digital karena tingginya penggunaan media sosial pada remaja. Tim sekolah mengumpulkan hasil penelitian terbaru terkait efektivitas media digital dalam edukasi kesehatan remaja sebelum menyusun program.

   Pendekatan yang diterapkan pada kasus tersebut adalah:

   A. Trial and error
   B. Pendekatan administrative
   C. Evidence based program
   D. Hukuman preventif
   E. Pendekatan kuratif

10. Puskesmas menemukan bahwa remaja laki-laki jarang memanfaatkan layanan konseling kesehatan karena merasa malu dan takut tidak dijaga kerahasiaannya.

Prinsip pelayanan yang paling penting diperkuat pada kasus tersebut adalah:

A. Kompetisi layanan
B. Kerahasiaan dan kenyamanan layanan
C. Pembatasan jumlah konseling
D. Pengurangan waktu pelayanan
E. Pemberian hukuman bagi siswa yang tidak hadir

Jawaban pertanyaan:

1. B
2. C
3. C
4. C
5. C
6. C
7. B
8. B
9. C
10. B

1. Laporan berbasis proyek (Project-Based Learning)
   a. Laporan Program Sekolah/Komunitas
   b. Laporan Monitoring dan Evaluasi (M&E) Sederhana

TUGAS: Mahasiswa diminta menyusun mini proposal program kesehatan remaja berbasis sekolah atau komunitas yang mencakup:

a. Analisis kebutuhan program
b. Desain jejaring dan peran stakeholder
c. Rencana kegiatan edukasi
d. Rencana pencatatan dan pelaporan
e. Rencana monitoring dan evaluasi
f. Analisis data sederhana dan rekomendasi perbaikan

Output tugas:

a. Dokumen proposal program (portofolio/laporan)
b. Format pencatatan dan pelaporan
c. Laporan monitoring dan evaluasi sederhana

D. Rubrik

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Desain jejaring/program sekolah–komunitas	Tidak jelas stakeholder/alur; tidak inklusif	Stakeholder/alur ada namun belum lengkap	Stakeholder dan alur jelas; inklusif dasar	Sangat jelas dan kuat; kolaborasi realistis, inklusif, dan ada strategi keberlanjutan
7.2 Pencatatan–pelaporan & M&E sederhana	Format tidak rapi/tidak konsisten; indikator tidak jelas	Format cukup; indikator terbatas; analisis minim	Format konsisten; indikator jelas; analisis dasar untuk perbaikan	Format sangat baik; indikator tepat; analisis data bermakna dan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang spesifik

E. Rangkuman Materi

Pelayanan kesehatan remaja berbasis sekolah dan komunitas merupakan pendekatan strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi remaja. Program ini menekankan pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan, penguatan jejaring layanan, serta keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan seperti sekolah, tenaga kesehatan, dan remaja itu sendiri sebagai agen perubahan.

Perancangan program harus memperhatikan analisis kebutuhan, kejelasan peran stakeholder, serta prinsip inklusivitas, sehingga program dapat menjangkau seluruh remaja tanpa diskriminasi. Selain itu, penyusunan rencana operasional yang sistematis menjadi kunci keberhasilan implementasi program di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, program harus didukung oleh sistem pencatatan dan pelaporan yang baik, yang memenuhi prinsip kualitas data seperti lengkap, akurat, tepat waktu, konsisten, dan menjaga kerahasiaan. Data yang dikumpulkan dapat

berupa data input, proses, output, dan outcome yang berasal dari berbagai sumber seperti logbook kegiatan, formulir layanan, survei, dan wawancara.

Selanjutnya, monitoring dan evaluasi (M&E) dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana serta menilai keberhasilannya. Hasil monitoring dan evaluasi dianalisis untuk menghasilkan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan program secara berkelanjutan melalui pendekatan berbasis data.

F. Daftar Pustaka

Al Aufa, B., Suryani, D. dan Prasetyo, A. (2020). Evaluasi program kesehatan remaja berbasis komunitas. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 9(2), pp. 77–85. https://jurnal.htp.ac.id/index.php/keskom.

Azwar, A. (2010).*Pengantar administrasi kesehatan*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Fakhrurozi, M. (2022). Evaluasi pelaksanaan UKS di sekolah dasar. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 17(1), pp. 45–53. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpki.

https://www.who.int/publications/i/item/9789241512657.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022). *Pedoman pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR)*. https://kesmas.kemkes.go.id.

Kurniasari, D. et al. (2023). Akses layanan kesehatan pada remaja dengan kebutuhan khusus. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 19(2), pp. 120–128. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas.

Lestari, D. et al. (2023). Pola konsumsi dan status gizi remaja di Indonesia. *Jurnal Gizi Indonesia*, 11(2), pp. 85–93. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgi.

Mariana, D., Putri, R. dan Halim, A. (2024). Efektivitas peer educator dalam pendidikan kesehatan remaja. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 15(1), pp. 33–41. https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/kespro.

Mumtazah, N. dan Sulistiadi, W. (2022). Evaluasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR). *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 10(2). https://e-journal.unair.ac.id/JAKI.

Muthmainnah, S., Rahmawati, L. dan Handayani, R. (2021). Analisis pelaksanaan program kesehatan remaja di sekolah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 17(3), pp. 145–152. https://journal.unnes.ac.id.

Nadeak, R., Simanjuntak, T. dan Siregar, D. (2023). Evaluasi program kesehatan reproduksi remaja berbasis sekolah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(2). https://journal.unnes.ac.id.

Notoatmodjo, S. (2018). *Promosi kesehatan dan ilmu perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pratama, R. et al. (2023). Hubungan aktivitas fisik dengan status kesehatan remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(1), pp. 25–32. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas.

Rokhimah, N. dan Dewi, S. (2024). Pendekatan inklusif dalam promosi kesehatan remaja. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 9(2), pp. 77–85. https://jurnal.htp.ac.id/index.php/keskom.

Saparini, S., Simbolon, D. dan Ningsih, L. (2023). Knowledge and access to adolescent reproductive health information in Indonesia. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 19(1), pp. 1–10. https://doi.org/10.14710/jpki.19.1.1-10.

Sari, N. dan Utami, D. (2023). Kesehatan mental dan perilaku berisiko pada remaja. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 11(2), pp. 101–110. https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKJ.

Sari, N. et al. (2023) .Pemanfaatan media digital dalam edukasi kesehatan remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(2), pp. 90–98. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas.

Sari, T.P., Gunarmi dan Hastuti, W. (2024). *Optimalisasi peran Duta UKS sebagai peer educator dalam layanan kesehatan reproduksi*. Tesis.

Sugiyono (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susilawati, D. dan Saputra, R. (2024). Evaluasi pelaporan program kesehatan dalam pencapaian standar pelayanan minimal. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 19(1).

Wahyuni, S., Fitriani, Y. dan Lestari, D. (2025). Analisis kualitas pencatatan data dalam program kesehatan remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 20(1).

Wijaya, A., Putri, N. dan Kurniawan, H. (2025). Pengaruh sistem pencatatan terhadap efektivitas program kesehatan remaja. *Jurnal Kesehatan Indonesia*, 15(1).

Wijaya, A.A. et al. (2025). Efektivitas program PKPR berbasis sekolah. *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, 8(2), pp. 181–191. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK.

World Health Organization (2017). *Guidelines on ethical issues in public health surveillance*.

Wulandari, S. et al. (2024). Body image dan perilaku makan pada remaja putri. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 15(1), pp. 55–63. https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/kespro.

Yuliana, R. et al. (2023). Peran sosial ekonomi dalam akses kesehatan remaja. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 26(1), pp. 15–23.

Yuliastuti, R., Dewi, M. dan Anggraini, S. (2024). Perencanaan operasional program kesehatan berbasis sekolah. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 19(2). https://journal.unnes.ac.id.

PROFIL PENULIS



Bdn. Ermaya Sari Bayu Ningsih, SST.,M.Kes.,M.Keb Lahir di Helvetia, 10 Maret 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Kebidanan di STIKes Haji Medan lulus pada tahun 2005; D4 Bidan Pendidik di Poltekes Medan lulus pada tahun 2007; Profesi Bidan di Bakti Pertiwi Indonesia lulus pada tahun 2021; S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Respati Indonesia Jakarta lulus pada tahun 2015; S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2023.
Sejak tahun 2005 penulis mulai aktif mengajar sebagai Dosen Kebidanan dan saat ini penulis aktif mengajar di Institut Kesehatan Helvetia Medan. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal Nasional dan Internasional lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mayapendi3969@gmail.com atau mayasetiawan1984@gmail.com
Motto: "Ilmu mewarnai dunia. Ingin duniamu berwarna maka belajarlah mencari ilmu. jadikan belajar sebagai *lifestyle* mu".



Cynthia Puspariny, S.ST., Bdn., M.Kes.
Cynthia Puspariny lahir di Bandar Lampung, 25 September 1985. Ia merupakan dosen dan praktisi kebidanan di Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pringsewu pada Program Studi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan.
Menempuh pendidikan DIII Kebidanan di Akademi Kebidanan Estu Utomo Boyolali, DIV Bidan Pendidik di Poltekkes Surakarta, serta Magister Kesehatan Masyarakat konsentrasi Kesehatan Reproduksi di Universitas Malahayati lalu me
Aktif dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, khususnya terkait kesehatan reproduksi remaja, kesehatan perempuan, konseling kebidanan, serta terapi komplementer. Beberapa karya ilmiah dan publikasinya terindeks pada platform akademik nasional seperti SINTA Kemdiktisaintek.
Selain mengajar, penulis juga aktif menyusun buku ajar dan melakukan edukasi kesehatan reproduksi berbasis promotif dan preventif untuk remaja dan masyarakat.

PROFIL PENULIS



Bdn. Feling Polwandari Lahir di Nganjuk, 30 Oktober 1987. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Terapan Kebidanan di STIKES Husada Jombang pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Kebidanan di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2017. Riwayat profesional penulis pada tahun 2009 sebagai dosen tetap di Universitas Faletehan sampai dengan sekarang, mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Asuhan Kebidanan pada Kehamilan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penelitian dan pengadian masyarakat yang fokus pada keilmuan yang diampu. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: **greenfeling21@gmail.com** untuk diskusi lebih lanjut terkait isi buku ini atau kolaborasi keilmuan lainnya.

Motto: “A meaningful life is one spent learning, sharing, and growing."

PROFIL PENULIS



Dr. Sri Handayani, S.Kep., Ns., M.Kes. lahir di Binjai pada tanggal 22 Desember 1963. Penulis menempuh pendidikan Diploma III Keperawatan di Akademi Keperawatan Pajajaran Bandung dan lulus pada tahun 1989. Selanjutnya penulis menyelesaikan Program Pendidikan Bidan (PPB-B) di Surabaya pada tahun 1994. Pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners diselesaikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2003. Penulis kemudian melanjutkan studi Magister Kesehatan dengan minat Kesehatan Reproduksi di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2001. Komitmen untuk terus mengembangkan keilmuan diwujudkan dengan menyelesaikan Program Doktor (S3) pada bidang Kesehatan Reproduksi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015.

Karier akademik penulis dimulai sebagai dosen di Akper 'Aisyiyah Yogyakarta pada tahun 1990 hingga 2004. Selanjutnya penulis mengabdikan diri sebagai dosen di STIKES Yogyakarta pada periode 2009–2024. Sejak tahun 2025 hingga saat ini, penulis aktif sebagai dosen di Akademi Kebidanan Banua Husada Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selain menjalankan tugas sebagai pendidik, penulis juga dipercaya menduduki berbagai jabatan akademik dan manajerial: Wadir III bidang kemahasiswaan di Akper 'Aisyiyah Yogyakarta, Ketua STIKES Yogyakarta tahun 2011-2015, serta aktif dalam kegiatan pengembangan institusi pendidikan kesehatan.

Sebagai akademisi, penulis memiliki ketertarikan pada bidang keperawatan, kebidanan, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, pendidikan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Penulis aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, penulisan buku ajar, serta berbagai seminar dan pelatihan di bidang kesehatan. Dedikasi dan pengalaman panjang dalam dunia pendidikan kesehatan menjadi motivasi penulis untuk terus berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan di Indonesia.

Motto: "Mengabdi dengan ilmu, berkarya dengan ketulusan, dan memberi manfaat bagi sesama."

PROFIL PENULIS



Tria Puspita Sari, SST.,M.Kes.,M.Keb Lahir di Surakarta, 04 Juni 1987, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Kebidanan dan lulus pada tahun 2009 di Universitas Sebelas Maret Surakarta, menempuh DIII Kebidanan pada Program Studi DIII Kebidanan Universitas Sebelas Maret Surakarta lulus tahun 2010. Melanjutkan pendidikan S2 Magister Kedokteran Keluarga pada Universitas Sebelas Maret, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan studi pendidikan S2 Magister Kebidanan di Stikes Guna Bangsa Yogyakarta dan lulus tahun 2024. Saat ini penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta mulai dari tahun 2010 sampai sekarang, penulis mengampu mata kuliah Asuhan kesehatan reproduksi remaja dan perimenopouse, Ketrampilan dasar praktik kebidanan, asuhan kebidanan pada neonatus, bayi baru lahir, balita dan anak prasekolah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan kegiatan pengabdian masyarakat.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: triaps@umpku.ac.id

Motto: “Pendidikan adalah proses menanam kesabaran. Setiap anak adalah tunas yang mekar di waktu yang berbeda. Jangan menganggap satu menitmu sama dengan satu menit orang lain, satu menit saat ini bisa membuat perbedaan puluhan tahun ke depan”

Sinopsis

Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi untuk Bidan 2 disusun sebagai bahan ajar bagi mahasiswa kebidanan dalam memahami berbagai aspek kesehatan reproduksi remaja dan pelayanan prakonsepsi secara komprehensif. Buku ini membahas infeksi menular seksual dan HIV pada remaja, meliputi skrining risiko, edukasi, rujukan, simulasi keterampilan, rubrik penilaian, ringkasan, serta tabel red flags dan eskalasi. Materi tersebut diharapkan dapat membekali calon bidan dalam memberikan pelayanan promotif, preventif, dan rujukan yang tepat pada remaja dengan risiko masalah kesehatan reproduksi.

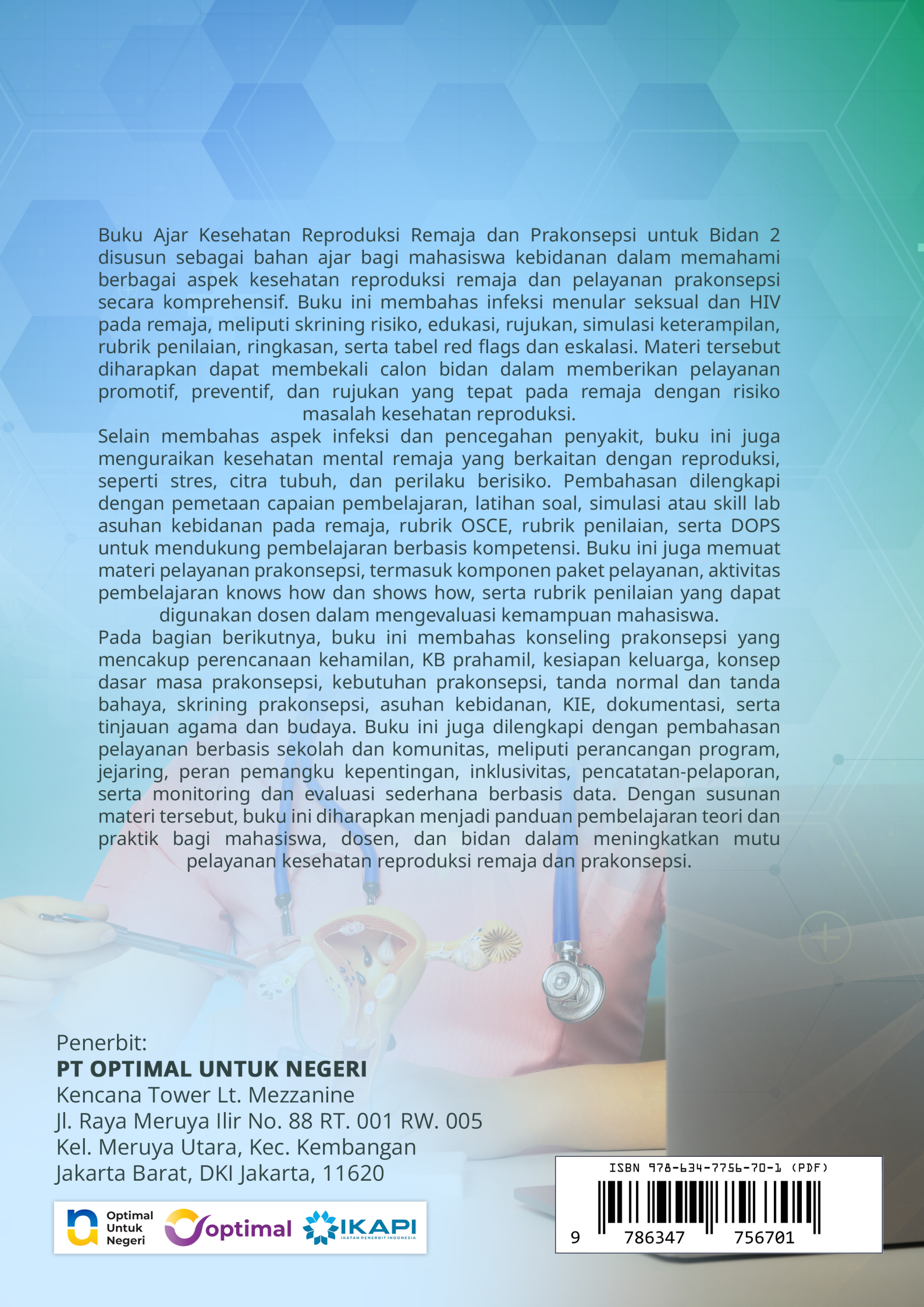
Selain membahas aspek infeksi dan pencegahan penyakit, buku ini juga menguraikan kesehatan mental remaja yang berkaitan dengan reproduksi, seperti stres, citra tubuh, dan perilaku berisiko. Pembahasan dilengkapi dengan pemetaan capaian pembelajaran, latihan soal, simulasi atau skill lab asuhan kebidanan pada remaja, rubrik OSCE, rubrik penilaian, serta DOPS untuk mendukung pembelajaran berbasis kompetensi. Buku ini juga memuat materi pelayanan prakonsepsi, termasuk komponen paket pelayanan, aktivitas pembelajaran knows how dan shows how, serta rubrik penilaian yang dapat digunakan dosen dalam mengevaluasi kemampuan mahasiswa.

Pada bagian berikutnya, buku ini membahas konseling prakonsepsi yang mencakup perencanaan kehamilan, KB prahamil, kesiapan keluarga, konsep dasar masa prakonsepsi, kebutuhan prakonsepsi, tanda normal dan tanda bahaya, skrining prakonsepsi, asuhan kebidanan, KIE, dokumentasi, serta tinjauan agama dan budaya. Buku ini juga dilengkapi dengan pembahasan pelayanan berbasis sekolah dan komunitas, meliputi perancangan program, jejaring, peran pemangku kepentingan, inklusivitas, pencatatan-pelaporan, serta monitoring dan evaluasi sederhana berbasis data. Dengan susunan materi tersebut, buku ini diharapkan menjadi panduan pembelajaran teori dan praktik bagi mahasiswa, dosen, dan bidan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi.

Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi untuk Bidan 2 disusun sebagai bahan ajar bagi mahasiswa kebidanan dalam memahami berbagai aspek kesehatan reproduksi remaja dan pelayanan prakonsepsi secara komprehensif. Buku ini membahas infeksi menular seksual dan HIV pada remaja, meliputi skrining risiko, edukasi, rujukan, simulasi keterampilan, rubrik penilaian, ringkasan, serta tabel red flags dan eskalasi. Materi tersebut diharapkan dapat membekali calon bidan dalam memberikan pelayanan promotif, preventif, dan rujukan yang tepat pada remaja dengan risiko masalah kesehatan reproduksi.

Selain membahas aspek infeksi dan pencegahan penyakit, buku ini juga menguraikan kesehatan mental remaja yang berkaitan dengan reproduksi, seperti stres, citra tubuh, dan perilaku berisiko. Pembahasan dilengkapi dengan pemetaan capaian pembelajaran, latihan soal, simulasi atau skill lab asuhan kebidanan pada remaja, rubrik OSCE, rubrik penilaian, serta DOPS untuk mendukung pembelajaran berbasis kompetensi. Buku ini juga memuat materi pelayanan prakonsepsi, termasuk komponen paket pelayanan, aktivitas pembelajaran knows how dan shows how, serta rubrik penilaian yang dapat digunakan dosen dalam mengevaluasi kemampuan mahasiswa.

Pada bagian berikutnya, buku ini membahas konseling prakonsepsi yang mencakup perencanaan kehamilan, KB prahamil, kesiapan keluarga, konsep dasar masa prakonsepsi, kebutuhan prakonsepsi, tanda normal dan tanda bahaya, skrining prakonsepsi, asuhan kebidanan, KIE, dokumentasi, serta tinjauan agama dan budaya. Buku ini juga dilengkapi dengan pembahasan pelayanan berbasis sekolah dan komunitas, meliputi perancangan program, jejaring, peran pemangku kepentingan, inklusivitas, pencatatan-pelaporan, serta monitoring dan evaluasi sederhana berbasis data. Dengan susunan materi tersebut, buku ini diharapkan menjadi panduan pembelajaran teori dan praktik bagi mahasiswa, dosen, dan bidan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi.



Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-70-1 (PDF)
9 786347 756701